

COLEGIO PROFESIONAL DE
FISIOTERAPEUTAS
COMUNIDAD DE MADRID

Documento técnico
Septiembre de 2026



COLEGIO PROFESIONAL DE
FISIOTERAPEUTAS
COMUNIDAD DE MADRID

DOCUMENTO TÉCNICO

Fisioterapia en Atención Primaria en el
Sistema Nacional de Salud

Modelo organizativo, acceso, dotación y evaluación
Propuesta dirigida al Ministerio de Sanidad

2026

Índice de contenidos

Resumen ejecutivo	5
Petición al Ministerio de Sanidad	5
Fases de dotación	5
Evidencia y experiencia en las que se apoya	5
Lo que este documento no propone	6
Nota de método	6
1. Introducción y justificación	7
1.1. Papel de la fisioterapia en el primer nivel asistencial	7
1.2. Carga de los procesos musculoesqueléticos en atención primaria	7
1.3. Incapacidad temporal por procesos musculoesqueléticos	8
1.4. El coste de derivar tarde o de derivar dos veces	9
1.5. Capacidad resolutoria de la fisioterapia de atención primaria	10
2. Marco normativo y de planificación	11
2.1. Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias	11
2.2. Real Decreto 1030/2006, de cartera de servicios comunes	11
2.3. Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	12
2.4. Marco Estratégico y planes de acción de atención primaria	12
2.5. Instrumentos autonómicos que desarrollan la cartera común	13
2.6. Real Decreto 601/2019, sobre exposiciones médicas	13
2.7. Marco internacional	13
3. Situación de la fisioterapia de atención primaria en España	14
3.1. Dotación actual	14
3.2. Modelos autonómicos	14
3.3. Modelos de referencia en España	15
3.4. Diagnóstico de los modelos vigentes en los documentos profesionales	17
3.5. Heterogeneidad e inequidad	18
4. Modelos internacionales de referencia	19
4.1. Inglaterra y la fisioterapia de primer contacto	19
4.2. Noruega, Países Bajos y Suecia y la autorreferencia normalizada	20
4.3. Australia y Canadá	21
4.4. Triaje musculoesquelético por fisioterapia y tasa de conversión quirúrgica	21
4.5. Síntesis de la evidencia sobre acceso directo	22
4.6. Densidad de fisioterapeutas en Europa	23
5. Modelo organizativo propuesto	25
5.1. Principios	25
5.2. Niveles de atención comunitaria	25
5.3. Funciones clínicas	26
5.4. Programas grupales y programas comunitarios	26
5.5. Modalidades asistenciales	28
5.6. Herramientas de salud digital	29
6. Vías de acceso y circuitos asistenciales	30
6.1. Vías de entrada	30

6.2. Circuito 1. Autorreferencia.....	30
6.3. Circuito 2. Derivación desde medicina de familia.....	31
6.4. Circuito 3. Derivación desde enfermería familiar y comunitaria.....	31
6.5. Circuito 4. Derivación desde medicina de atención hospitalaria.....	32
6.6. Circuito 5. Retorno desde rehabilitación hospitalaria.....	32
6.7. Coordinación con otras unidades de atención específica.....	33
6.8. Matriz de coherencia.....	34
7. Competencias solicitadas y marco legal.....	35
7.1. Competencias que ya ampara la Ley 44/2003.....	35
7.2. Competencias que requieren desarrollo autónómico o protocolo.....	35
7.3. Ecografía como apoyo a la valoración.....	35
7.4. Solicitud de radiología simple.....	36
7.5. Compatibilidad con la cartera común.....	36
7.6. Lo que no se pide.....	37
8. Criterios clínicos de acceso directo.....	38
8.1. Criterio transversal de seguridad clínica.....	38
8.2. Procesos con acceso directo.....	38
8.3. Situaciones excluidas del acceso directo.....	39
8.4. Herramientas de cribado.....	39
8.5. Evidencia de efectividad en los procesos de acceso directo.....	40
9. Dotación calculada por demanda, por fases y con ajuste territorial.....	42
9.1. Punto de partida.....	42
9.2. Modelo de demanda.....	42
9.3. Escenarios como fases.....	45
9.4. Ajustes territoriales.....	45
9.5. Referencias externas de dotación.....	46
9.6. Retorno económico esperado.....	46
10. Sistema de evaluación en formato EFQM.....	48
10.1. Marco.....	48
10.2. Indicadores de Dirección.....	48
10.3. Indicadores de Ejecución.....	48
10.4. Indicadores de Resultados.....	49
10.5. Ficha de indicador.....	50
11. Plan de implantación y gestión de riesgos.....	51
11.1. Fases e hitos.....	51
11.2. Sistemas de información.....	51
11.3. Formación.....	51
11.4. Gobernanza.....	52
11.5. Riesgos y mitigación.....	52
12. Propuesta de texto para el documento ministerial.....	54
Anexo A. Fichas de programas grupales y comunitarios.....	56
Anexo B. Fichas de indicadores.....	60
Anexo C. Matriz de coherencia de procesos, vías y condiciones.....	69
Anexo D. Glosario y terminología normalizada.....	72

Anexo E. Tabla de fuentes por cifra.....	74
Anexo F. Metodología de selección y verificación de fuentes.....	80
F.1. Criterios.....	80
F.2. Procedimiento de verificación.....	80
F.3. Afirmaciones que no se usan por falta de fuente.....	80
Referencias.....	80

Resumen ejecutivo

La fisioterapia de atención primaria es un recurso del primer nivel asistencial, ya previsto en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Su despliegue es desigual entre comunidades autónomas. Un modelo homogéneo puede resolver en atención primaria una parte importante de los procesos musculoesqueléticos de alta prevalencia. Ese modelo combina consulta propia, acceso por varias vías, criterios clínicos de seguridad aplicados por el propio fisioterapeuta, dotación planificada por demanda e indicadores comunes. Además, reduce las derivaciones duplicadas y mejora la equidad territorial.

Peticiones al Ministerio de Sanidad

Este documento formula seis peticiones:

1. **Modelo organizativo homogéneo.** El fisioterapeuta se integra en el equipo de atención primaria de cada zona básica de salud, con consulta propia, agenda propia y tiempo protegido.
2. **Vías de acceso con autorreferencia regulada.** La persona puede pedir cita sin derivación para procesos protocolizados. El Consejo Interterritorial impulsa la actualización de la cartera común para recoger esa vía, que hoy exige indicación médica.
3. **Competencias.** Se reconoce la ecografía como apoyo a la valoración y se inicia el desarrollo normativo para que el fisioterapeuta de atención primaria pueda solicitar radiografía simple en procesos protocolizados.
4. **Dotación calculada por demanda.** La dotación sale de un modelo común con parámetros explícitos y se despliega en tres fases.
5. **Indicadores comunes.** Los servicios de salud registran en el Sistema de Información de Atención Primaria un conjunto común de indicadores con formato EFQM.
6. **Grupo de trabajo del Consejo Interterritorial.** Un grupo de trabajo coordina el despliegue, aprueba la matriz común de procesos y fija los estándares.

Fases de dotación

Tabla R.1. Fases de dotación que propone este documento

Fase	Horizonte	Dotación
Implantación	Años primero y segundo	Ninguna comunidad autónoma por debajo de 1 fisioterapeuta por cada 23.900 habitantes
Consolidación	Años tercero a quinto	1 fisioterapeuta por cada 7.500 habitantes
Necesidad especial	Desde el tercer año	Hasta 1 fisioterapeuta por cada 4.400 habitantes en zonas rurales, envejecidas y con alta dependencia

Fuente: modelo de demanda de la sección 9 y tabla 9.4.

Evidencia y experiencia en las que se apoya

- **Experiencia española.** Madrid ya cita directamente con fisioterapia tres procesos, mediante una instrucción de su Gerencia Asistencial de AP con criterios escritos de inclusión y de exclusión. Galicia incorporó la fisioterapia a su protocolo de gestión de la demanda.

- **Seguridad y uso de recursos.** Las revisiones internacionales no encuentran daños atribuibles al acceso directo, y sí menos pruebas de imagen y menos medicación.
- **Momento del acceso.** La fisioterapia precoz se asocia a menos uso posterior de servicios y a un coste menor, aunque la evidencia procede de otros sistemas sanitarios.
- **Procesos concretos.** En el hombro doloroso, los ensayos con seguimientos de hasta diez años no encuentran ventaja de la cirugía de descompresión sobre el ejercicio. En la epicondilalgia, la fisioterapia supera a la infiltración a medio plazo.
- **Capacidad diagnóstica.** Las revisiones sobre práctica avanzada encuentran una concordancia diagnóstica alta entre el fisioterapeuta y el médico.
- **Carencia declarada.** Ningún estudio ha evaluado todavía el acceso directo en el SNS. Por eso el despliegue se diseña para medir sus resultados desde el primer día.

Lo que este documento no propone

- No propone dimensionar la fisioterapia de atención primaria para absorber la demora de rehabilitación hospitalaria. La relación entre ambos niveles se regula con un circuito de continuidad.
- No propone que el personal no sanitario realice ningún cribado ni triaje. El personal administrativo solo aplica motivos de consulta parametrizados por los clínicos.
- No propone crear especialidades de fisioterapia.
- No pide la prescripción de medicamentos, la solicitud de pruebas de imagen avanzada ni la derivación a atención hospitalaria sin pasar por medicina de familia.

Nota de método

Todas las cifras del cuerpo del documento llevan su fuente y figuran en el anexo E. Las referencias proceden de fuentes primarias, y el anexo F describe cómo se seleccionaron y verificaron. El efecto del acceso directo sobre las consultas de medicina de familia se presenta como un resultado a evaluar y no como un resultado garantizado.

1. Introducción y justificación

Esta sección explica por qué la fisioterapia forma parte del primer nivel asistencial y qué peso tienen los procesos musculoesqueléticos en atención primaria (AP). También expone el coste de derivar tarde o de derivar el mismo proceso a dos servicios. Termina con los datos publicados sobre la capacidad resolutoria de la fisioterapia de AP.

1.1. Papel de la fisioterapia en el primer nivel asistencial

La Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias, define el ámbito de la profesión en su artículo 7.2.b [1]. El texto dice: «corresponde a los Diplomados universitarios en Fisioterapia la prestación de los cuidados propios de su disciplina, a través de tratamientos con medios y agentes físicos, dirigidos a la recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o discapacidades somáticas, así como a la prevención de las mismas» [1]. La definición incluye, por tanto, la prevención y la recuperación funcional. Ambas son tareas propias del primer nivel asistencial.

World Physiotherapy describe la formación de acceso a la profesión como suficiente para ejercer como profesional autónomo de primer contacto [2]. Según esa declaración, el fisioterapeuta puede valorar, diagnosticar, intervenir, medir resultados y dar el alta sin derivación previa de otro profesional [2]. La descripción de la profesión que publica la misma organización sitúa la función y el movimiento en el centro de su actuación [3].

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa la rehabilitación entre los servicios esenciales de salud [4]. La iniciativa Rehabilitation 2030 pidió integrarla en todos los niveles del sistema, incluida la atención primaria [5]. En 2023, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA76.6 para fortalecer la rehabilitación en los sistemas de salud [6]. La OMS publicó además un paquete de intervenciones de rehabilitación con una selección pensada para la atención primaria [7].

En España, tres documentos recientes trasladan esa función a la AP. La Sociedade Galega de Fisioterapeutas propuso en 2019 que el fisioterapeuta fuera el profesional de referencia para cribar los procesos musculoesqueléticos de alta prevalencia [8]. Esa función se ejercería dentro del equipo interdisciplinar [8]. La Gerencia Asistencial de AP de Madrid organiza su gestión de la demanda con el criterio de asignar cada demanda al profesional que mejor puede resolverla [9]. Por último, el colegio profesional madrileño defiende que el fisioterapeuta de AP pueda completar los procesos de acceso directo sin una consulta médica intermedia [10].

1.2. Carga de los procesos musculoesqueléticos en atención primaria

La Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP) registra los problemas de salud atendidos en AP con la clasificación CIAP-2 [11]. En 2023, los problemas del aparato locomotor, capítulo L de esa clasificación, sumaron 51.813.798 registros [11]. Ese volumen solo quedó por detrás del grupo de problemas generales e inespecíficos [11]. El dato cuenta problemas registrados en la historia clínica, no consultas ni personas. Por eso no puede compararse con las cifras de otros países que se describen a continuación.

En Inglaterra, el Musculoskeletal Services Framework del Department of Health atribuyó a los problemas musculoesqueléticos hasta el 30 % de las consultas de medicina general [12]. NHS England reproduce esa

cifra en su página sobre fisioterapia de primer contacto [13]. Se trata de una cifra de un documento de política sanitaria, no de un estudio que la haya medido.

Los estudios que miden consultas dan cifras menores. Jordan y colaboradores analizaron doce consultas de medicina general inglesas con datos de 2006 [14]. En ese estudio, una de cada siete consultas registradas correspondió a un problema musculoesquelético [14]. El ensayo piloto STEMS estimó que alrededor del 17 % de las consultas de medicina general se deben a estos procesos [15]. Keavy y colaboradores revisaron 545 consultas de un centro urbano y hallaron una proporción del 21,1 % [16].

La carga es, por tanto, alta con cualquier definición. Sin embargo, el rango empírico se sitúa entre una de cada siete y una de cada cinco consultas [14, 16]. Este documento usa ese rango y no la cifra del 30 % del documento de política, porque el rango procede de mediciones directas [12, 14].

La carga de estos procesos no se limita al volumen de consultas. El dolor lumbar se ha convertido en la primera causa de discapacidad en el mundo [17]. Los años vividos con discapacidad por esta causa aumentaron un 54 % entre 1990 y 2015 [17]. Una revisión de 165 estudios de 54 países estimó una prevalencia puntual del 11,9 % y una prevalencia al mes del 23,2 % [18]. La misma revisión prevé un aumento sustancial del número de personas afectadas a medida que envejezca la población [18].

El dolor lumbar tiende además a repetirse. Una cohorte finlandesa siguió durante décadas a trabajadores industriales [19]. Entre el 73 % y el 88 % de quienes tenían dolor lumbar al inicio lo refería de nuevo en los seguimientos posteriores [19]. Los autores concluyen que el dolor lumbar es recurrente con frecuencia [19]. Por eso la matriz del anexo C incluye la recidiva de un proceso ya diagnosticado entre los motivos de autorreferencia.

El dolor cervical ocupa el cuarto lugar entre las causas de discapacidad, con una prevalencia anual superior al 30 % [20]. La mayoría de los episodios agudos se resuelve, pero cerca del 50 % de las personas mantiene algún grado de dolor o episodios frecuentes [20]. El hombro doloroso completa el grupo de procesos más frecuentes. En el síndrome subacromial, el tratamiento conservador consigue resultados satisfactorios en dos años en el 60 % de los casos, según una revisión narrativa [21].

El dolor persistente de intensidad moderada o grave afecta al 19 % de la población adulta europea, según una encuesta realizada en quince países europeos e Israel [22]. En esa encuesta, el 21 % de las personas con dolor persistente había utilizado fisioterapia, y solo el 2 % recibía atención de un especialista en dolor [22]. Además, el 40 % consideraba inadecuado el manejo de su dolor [22]. El resumen publicado no desglosa el dato de España.

1.3. Incapacidad temporal por procesos musculoesqueléticos

La estadística de incapacidad temporal de la Seguridad Social ofrece la distribución de los procesos por grupo diagnóstico [23]. Esa estadística es la referencia que debe usar el indicador IR-6 del anexo B.

Regal-Ramos analizó 60.000 trabajadores valorados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en 2019 por patología osteomuscular [24]. Entre los procesos valorados, la columna lumbar supuso el 31,6 %, el hombro el 13,5 % y la rodilla el 11,9 % [24]. Las tres localizaciones coinciden con procesos que este documento propone atender en AP. Por eso la duración de la incapacidad temporal en esos procesos es un resultado que el modelo debe medir.

Los costes indirectos dominan el coste total de estos procesos. En los Países Bajos, el coste del dolor lumbar bajó de 4.300 a 3.500 millones de euros entre 2002 y 2007 [25]. Durante todo ese periodo, los costes

indirectos supusieron el 88 % del total, y los costes directos el 12 % [25]. La pérdida de productividad pesa, por tanto, mucho más que el gasto asistencial.

Las políticas de incapacidad también influyen en el retorno al trabajo. Una cohorte de 2.825 personas de baja por dolor lumbar en seis países siguió su evolución durante dos años [26]. El retorno sostenido al trabajo osciló entre el 22 % de la cohorte alemana y el 62 % de la neerlandesa [26]. Las intervenciones en el lugar de trabajo y las características del empleo explicaron la mayor parte de esas diferencias [26].

La intensidad y el momento de la intervención condicionan su efecto sobre la baja laboral. En un ensayo sueco seguido durante diez años, la rehabilitación multidisciplinar redujo la incapacidad temporal en unos 43 días al año frente al tratamiento habitual [27]. La fisioterapia aislada y la terapia cognitivo-conductual no mostraron diferencias significativas frente al grupo control [27]. Cuando Suecia extendió la rehabilitación multimodal a todo el país, un estudio con controles emparejados no encontró menos días de baja que con el tratamiento habitual [28]. Sí encontró menos pensiones de incapacidad nuevas en el grupo de intervención [28]. Sus autores proponen iniciar la rehabilitación en los primeros 60 días de baja, como implicación práctica y no como resultado medido [28].

Esta evidencia tiene dos consecuencias para el modelo. La primera es que la fisioterapia de AP debe llegar pronto a las personas en incapacidad temporal, y el indicador IE-10 del anexo B mide ese intervalo. La segunda es que la reducción de la baja laboral no puede prometerse como efecto automático, de modo que el indicador IR-6 la mide sin fijar un estándar previo.

1.4. El coste de derivar tarde o de derivar dos veces

Cada proceso debe llegar primero al recurso más adecuado para él. Si la respuesta de ese recurso no basta, el profesional valora entonces la derivación a otro. La derivación simultánea del mismo proceso a dos servicios duplica esperas, consultas y pruebas. Además, fragmenta la información clínica y dificulta que un único profesional asuma el seguimiento.

La literatura sobre acceso directo aporta datos sobre ese coste. Una revisión sistemática de Ojha y colaboradores comparó episodios de fisioterapia con acceso directo y episodios derivados por un médico [29]. Los episodios con acceso directo tuvieron menos sesiones de fisioterapia, menos pruebas de imagen y menos medicación prescrita, sin evidencia de daño [29]. Los estudios incluidos eran observacionales, de modo que el resultado debe leerse con cautela [29].

Frogner y colaboradores estudiaron el dolor lumbar en aseguradoras comerciales de Estados Unidos [30]. Las personas que consultaron primero con fisioterapia tuvieron menor probabilidad de recibir opioides, imagen avanzada o atención en urgencias [30]. En cambio, tuvieron una probabilidad mayor de hospitalización, y el estudio no permite explicar ese hallazgo [30]. Un metaanálisis de ensayos aleatorizados publicado en 2025 encontró menos pruebas de imagen y menos medicación cuando la fisioterapia es el primer contacto [31].

El momento del acceso también influye en el coste. Fritz y colaboradores analizaron 32.070 personas que consultaron por primera vez en AP por dolor lumbar en Estados Unidos [32]. Solo el 7,0 % recibió fisioterapia [32]. Frente a la fisioterapia diferida, la fisioterapia en los primeros 14 días se asoció a menos imagen avanzada, menos visitas médicas, menos cirugía, menos infiltraciones y menos opioides [32]. El coste médico total del dolor lumbar fue 2.736 dólares menor con la fisioterapia precoz [32]. Se trata de un estudio observacional, de modo que la asociación no prueba por sí sola una relación causal.

Los ensayos aleatorizados apuntan en la misma dirección, aunque con efectos más modestos. En un ensayo sueco en AP, el acceso a fisioterapia en dos días redujo más el dolor a los seis meses que una espera de cuatro semanas [33]. Sus autores señalan que ese acceso precoz puede lograrse reorganizando el servicio, sin recursos adicionales [33]. En un ensayo británico, el tratamiento inmediato mejoró antes la discapacidad y el estado de ánimo que la espera [34]. A largo plazo, el dolor y la discapacidad se igualaron entre los grupos [34]. Un estudio laboral de 3.867 casos encontró menos visitas médicas y menos días de baja con la fisioterapia precoz, sin aleatorización [35].

La derivación hospitalaria sin paso previo por fisioterapia también tiene un coste. Un estudio español analizó 6.225 solicitudes de derivación desde AP a traumatología en un área de salud de Castilla y León durante el primer semestre de 2019 [36]. Los procesos degenerativos justificaron el 65,7 % de las solicitudes, sobre todo de columna y de rodilla [36]. Solo el 36,5 % describía alguna exploración física, y solo el 11,2 % mencionaba una fisioterapia previa [36]. Estos datos muestran que muchas solicitudes de consulta con traumatología corresponden a procesos que la fisioterapia de AP puede valorar primero.

1.5. Capacidad resolutive de la fisioterapia de atención primaria

Downie y colaboradores evaluaron durante dos años un servicio escocés de fisioterapia como alternativa al médico de familia [37]. De los 8.417 contactos registrados, el 87,3 % se resolvió en atención primaria [37]. Además, el 60,4 % necesitó solo pautas de automanejo [37].

Una evaluación nacional retrospectiva en setenta redes de atención primaria del Reino Unido analizó la reconsulta tras una cita de fisioterapia de primer contacto [38]. El 78,5 % de las personas no volvió a consultar en las doce semanas siguientes [38].

En España, la Comunidad de Madrid informó de que sus unidades de fisioterapia de AP atendieron a cerca de 159.000 personas en 2024 [39]. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid recoge esos datos de 2024 en su documento de posición [10]. Según ese documento, la consecución de objetivos rondó el 77 % y la reducción del dolor alcanzó a cerca del 93 % de los casos [10]. Estos datos proceden de la actividad asistencial y no de un estudio comparativo.

Los servicios de triaje musculoesquelético aportan otra medida de la capacidad resolutive. En estos servicios, un fisioterapeuta de práctica avanzada valora antes que el cirujano a las personas que el médico ha enviado a traumatología o a columna. Wood y colaboradores revisaron 2.651 personas atendidas por este perfil en una unidad de columna del Reino Unido [40]. El fisioterapeuta resolvió de forma independiente el 92 % de los casos, y solo el 8 % necesitó comentar el caso o una revisión quirúrgica [40]. En Gales, un equipo liderado por fisioterapia revisó 2.362 altas de un año [41]. Entre doce y dieciocho meses después del alta, solo el 2 % de esas personas volvió a atención hospitalaria por el mismo problema [41]. La sección 4.4 resume esta evidencia.

La búsqueda realizada para este documento no ha encontrado ningún estudio publicado que evalúe un modelo de acceso directo a fisioterapia dentro del Sistema Nacional de Salud. Sí existen estudios españoles de fisioterapia de AP sobre programas grupales y educación en dolor, que la sección 5.4 recoge. Esta carencia tiene una consecuencia práctica. El despliegue que se propone debe medir sus resultados desde el primer día, con indicadores comunes para todas las comunidades autónomas (sección 10).

2. Marco normativo y de planificación

Esta sección muestra que la propuesta desarrolla un servicio que ya forma parte de la cartera común del Sistema Nacional de Salud (SNS). También identifica los límites normativos que la propuesta debe respetar o pedir que se modifiquen.

2.1. Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias

La Ley 44/2003 reconoce a los profesionales sanitarios la prestación de los cuidados propios de su competencia en las distintas fases del proceso de atención [1]. El mismo artículo 7 añade que esa prestación se hace sin menoscabo de la competencia, la responsabilidad y la autonomía de los demás profesionales que intervienen [1]. El artículo 7.2.b, citado en la sección 1.1, delimita el contenido propio de la fisioterapia [1].

El artículo 4.7 establece que las profesiones sanitarias se ejercen con plena autonomía técnica y científica, con los únicos límites que fija el ordenamiento jurídico y deontológico [1]. Esa autonomía ampara la valoración y el alta fisioterapéuticas que describe la sección 7.1.

La ley también regula las relaciones interprofesionales y el trabajo en equipo en su artículo 9 [1]. Ese artículo ampara la integración del fisioterapeuta en el equipo de AP como miembro de pleno derecho. La ley no atribuye al fisioterapeuta la solicitud de pruebas de imagen, y la sección 7 trata esa cuestión por separado [1].

2.2. Real Decreto 1030/2006, de cartera de servicios comunes

El anexo II del Real Decreto 1030/2006 contiene la cartera común de AP, y su apartado 6 regula la rehabilitación básica [42, 43]. El texto dice: «Comprende las actividades de educación, prevención y rehabilitación que son susceptibles de realizarse en el ámbito de atención primaria, en régimen ambulatorio, previa indicación médica y de acuerdo con los programas de cada servicio de salud, incluyendo la asistencia domiciliaria si se considera necesaria por circunstancias clínicas o por limitaciones en la accesibilidad» [43].

El apartado incluye seis contenidos [43]:

- La prevención del desarrollo o de la progresión de trastornos musculoesqueléticos.
- Los tratamientos fisioterapéuticos para el control de síntomas y la mejora funcional en procesos crónicos musculoesqueléticos.
- La recuperación de procesos agudos musculoesqueléticos leves.
- Los tratamientos fisioterapéuticos en trastornos neurológicos.
- La fisioterapia respiratoria.
- La orientación y formación sanitaria al paciente o a la persona cuidadora, en su caso.

La fisioterapia forma parte, por tanto, de la cartera común de AP desde 2006 [42]. Esta propuesta no crea un servicio nuevo, sino que desarrolla uno existente y homogeneiza su prestación.

El apartado 6 contiene, sin embargo, un inciso que condiciona toda la propuesta: las actividades se realizan «previa indicación médica» [43]. Un modelo estatal de autorreferencia tiene que tratar este inciso de forma expresa. La sección 7.5 expone cómo lo hace este documento.

El anexo III del mismo real decreto regula la rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable en el ámbito hospitalario [42]. Su contenido comprende el diagnóstico, la evaluación, la prevención y el tratamiento de ese déficit, con el fin de reintegrar al paciente en su medio habitual [42]. La distinción entre ambos anexos delimita los dos niveles. La rehabilitación básica corresponde a AP, mientras que la rehabilitación del déficit funcional complejo corresponde a la atención hospitalaria. La Orden SND/454/2025 modificó varios anexos del real decreto [44]. Este documento se refiere siempre al texto consolidado del apartado 6 del anexo II.

2.3. Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud

La Ley 16/2003 define la cartera común básica en su artículo 8 bis [45]. Según ese artículo, la cartera comprende las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realizan en centros sanitarios o sociosanitarios [45].

El artículo 20 establece que la cartera de servicios se acuerda en el seno del Consejo Interterritorial y se aprueba mediante real decreto [45]. El artículo 21 regula su actualización, que exige evaluar la seguridad, la eficacia, la eficiencia o la efectividad del procedimiento [45]. El artículo 71 atribuye al Consejo Interterritorial el conocimiento y el debate sobre el desarrollo de la cartera común [45]. Esta ley ofrece la vía formal para dos de las peticiones de este documento: la actualización del apartado 6 del anexo II y la creación de un grupo de trabajo para el despliegue.

2.4. Marco Estratégico y planes de acción de atención primaria

El Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria se aprobó en el Consejo Interterritorial en 2019 [46]. Su acción A.4.4 incluye el objetivo de «incrementar la capacidad resolutive de fisioterapia, asumiendo patología aguda de baja complejidad y crónica estable, mediante circuitos y protocolos de actuación basados en la evidencia» [10, 46]. El mismo marco pide «potenciar la participación de fisioterapia en actividades preventivas» [46].

El Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023 dio continuidad a ese marco [47]. El Plan de Acción 2025-2027, aprobado en diciembre de 2024, define un nuevo mapa de competencias que incluye a los fisioterapeutas de AP [48, 49]. Sus objetivos incluyen la continuidad asistencial, la ampliación de la cartera y la mejora de la capacidad resolutive [49]. Este documento se presenta como desarrollo operativo de esos objetivos para la fisioterapia. Un documento de trabajo madrileño propone usar ese mapa de competencias para ampliar el papel clínico del fisioterapeuta [50]. El mismo documento propone abrir el acceso directo en procesos de alta prevalencia y baja discapacidad [50].

Otras tres estrategias del Ministerio de Sanidad enmarcan la propuesta. La Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad orienta la atención de los procesos crónicos [51]. La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención vincula el consejo sobre estilos de vida en AP con los recursos comunitarios [52]. Por último, la Estrategia de Salud Digital del SNS ofrece el marco para la teleconsulta y el seguimiento remoto [53].

2.5. Instrumentos autonómicos que desarrollan la cartera común

Las comunidades autónomas desarrollan el apartado 6 del anexo II mediante instrumentos de rango muy distinto. La tabla 3.2 recoge carteras de servicios, guías de actuación, protocolos de área y formación oficial. Todos ellos son documentos técnicos o de gestión de los servicios de salud.

La instrucción de la Gerencia Asistencial de AP de Madrid ilustra ese nivel normativo. Su ficha de gestión documental identifica la autoría, los revisores, el órgano que la aprueba, los destinatarios y la fecha de entrada en vigor [9]. La aprueba la propia gerencia, y sus destinatarios son las direcciones asistenciales y los profesionales de los centros de salud [9]. Se trata, por tanto, de una instrucción de gestión interna y no de una norma autonómica.

Este rango tiene dos consecuencias para la propuesta. Por un lado, permite a cada servicio de salud abrir el acceso directo sin esperar una reforma estatal. Por otro, deja el acceso directo en una situación frágil frente al inciso «previa indicación médica» del apartado 6 [43]. Por eso la sección 7.5 pide actualizar ese apartado, y la sección 11.4 propone que la matriz común se apruebe en el Consejo Interterritorial.

La Sociedad Galega de Fisioterapeutas planteó en 2019 la misma cuestión para Galicia [8]. Su análisis situaba la derivación directa desde medicina de familia como una política pública de gestión sanitaria que debía incorporarse al nuevo modelo de AP [8]. Ambos documentos muestran que el despliegue depende hoy de decisiones de gestión y no de un marco estatal común.

2.6. Real Decreto 601/2019, sobre exposiciones médicas

El Real Decreto 601/2019 regula la justificación y la optimización de las exposiciones médicas a radiaciones ionizantes [54]. La norma distingue dos figuras. El prescriptor es el «médico, odontólogo u otro profesional sanitario autorizado para remitir a personas para ser sometidas a procedimientos médico-radiológicos» [54]. El profesional sanitario habilitado es quien asume la responsabilidad clínica de la exposición [54].

La norma no menciona al fisioterapeuta en ninguna de las dos figuras [54]. La Directiva 2013/59/Euratom, que el real decreto transpone, tampoco reserva en exclusiva a los médicos la remisión a estos procedimientos [55]. Este marco es la base de la petición de la sección 7.4.

2.7. Marco internacional

La resolución WHA76.6 insta a los Estados a fortalecer la rehabilitación en sus sistemas de salud [6]. La OMS recomienda integrar la rehabilitación en la atención primaria y ha publicado para ese nivel un paquete de intervenciones priorizadas [4, 7]. World Physiotherapy mantiene una declaración de política sobre el acceso directo y la autorreferencia, revisada en 2023 [2]. La región europea de esa organización publicó también una declaración sobre la fisioterapia en atención primaria [56].

3. Situación de la fisioterapia de atención primaria en España

Esta sección describe la dotación actual y los modelos que aplica cada comunidad autónoma. Cada afirmación sobre una comunidad cita el documento que la sostiene y su año. Cuando solo existe una noticia de prensa, el texto la identifica como fuente secundaria.

3.1. Dotación actual

El informe monográfico de recursos humanos del SNS de 2024 contabiliza 2.418 fisioterapeutas en AP [57]. Según el mismo informe, el 84,8 % de los fisioterapeutas del SNS trabaja en hospitales y el 10 % en AP [57]. El reparto muestra que la fisioterapia pública se concentra en el nivel hospitalario.

La dotación de AP varía mucho entre comunidades autónomas. Un editorial de la revista Fisioterapia recogió en 2022 los habitantes por fisioterapeuta de AP según el Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) [58]. La tabla 3.1 resume los valores extremos que publicó [58].

Tabla 3.1. Habitantes por fisioterapeuta de atención primaria en las comunidades autónomas con los valores extremos

Comunidad autónoma	Habitantes por fisioterapeuta de AP	Posición
Asturias	13.694	Entre las de mayor dotación
Cantabria	10.091	Mayor dotación
Cataluña	104.847	Menor dotación
Extremadura	12.101	Entre las de mayor dotación
Navarra	91.972	Entre las de menor dotación

Fuente: Aiguadé Aiguadé, 2022, con datos del SIAP [58]. El editorial no precisa el año del dato. Los valores son anteriores a la incorporación de fisioterapeutas a los equipos de AP de Cataluña en 2022 y 2023 [59].

La diferencia entre los extremos supera la relación de diez a uno [58]. La cifra de Cataluña es anterior a su programa de incorporación de fisioterapeutas, que situó un profesional en cada equipo de AP entre 2022 y 2023 [59, 60]. El SIAP publica la serie completa por comunidad autónoma y es la fuente que usará el indicador IE-3 [61].

3.2. Modelos autonómicos

La tabla 3.2 resume el modelo de cada comunidad autónoma. Las columnas indican tres cosas. La primera es si existe consulta propia en el centro de salud. La segunda es si el médico de familia deriva sin pasar por rehabilitación hospitalaria. La tercera es si la persona puede pedir cita sin derivación.

Tabla 3.2. Modelos de fisioterapia de atención primaria por comunidad autónoma

Comunidad autónoma	Documento de referencia	Año	Consulta propia	Derivación directa desde medicina de familia	Acceso directo del ciudadano
Andalucía	Cartera de servicios de AP y circuito de derivación directa del Servicio Andaluz de Salud [62, 63]	2026	Sí	Sí, para seis procesos	No
Aragón	Cartera de Servicios de Atención Primaria del Gobierno de Aragón [64]	2024	Sí	Sin protocolo localizado	No
Asturias	No localizado	No consta	No consta	No consta	No

Comunidad autónoma	Documento de referencia	Año	Consulta propia	Derivación directa desde medicina de familia	Acceso directo del ciudadano
Baleares	Protocolo de derivación directa de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca [65]	2023	Sí	Sí, para doce patologías	No
Canarias	Guía de actuación de la consulta de fisioterapia en AP del Servicio Canario de la Salud [66, 67]	2022	Sí	Sí	No
Cantabria	No localizado	No consta	No consta	No consta	No
Castilla-La Mancha	Guía de Unidades de Fisioterapia de AP del SESCAM [68]	2022	Sí	Sí, también desde pediatría	No
Castilla y León	Protocolos de fisioterapia en AP de la Junta de Castilla y León [69]	2017	Sí	Sí	No
Cataluña	Programa de incorporación de fisioterapeutas y plan funcional del Departament de Salut [59, 60]	2023	Sí, en cada equipo de AP	Sí, dentro del equipo	No consta
Comunidad Valenciana	Cartera de servicios de Atención Primaria Comunitaria de la Conselleria de Sanitat [70]	2022	Sí	No consta	No
Extremadura	Protocolo de derivación del Área de Salud de Plasencia [71]	2019	Sí	Sí, en esa área	No
Galicia	Carteira de servizos de fisioterapia de AP del SERGAS [72]	2022	Sí	Sí	Sí, con motivos parametrizados
La Rioja	No localizado	No consta	No consta	No consta	No
Madrid	Cartera de Servicios Estandarizados de AP del Servicio Madrileño de Salud e instrucción de la Gerencia Asistencial de AP sobre procesos de demanda [9, 39, 73]	2025	Sí	Sí	Sí, para tres procesos
Murcia	Cartera de Servicios de Fisioterapia en AP del Servicio Murciano de Salud [74]	2026	Sí	No consta	No
Navarra	Formación oficial del Servicio Navarro de Salud sobre derivación directa [75]	No consta	Sí	Sí, para procesos determinados	No
País Vasco	Información institucional de Osakidetza [76]	2024	Sí	No consta	No

Fuente: elaboración propia a partir de los documentos citados en cada fila. «No localizado» indica que no se ha encontrado un documento oficial publicado.

3.3. Modelos de referencia en España

Canarias protocoliza la derivación desde medicina de familia

El Servicio Canario de la Salud dispone desde 2022 de una guía de actuación de la consulta de fisioterapia en AP [66]. El despliegue comenzó en 24 zonas básicas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, según la nota oficial del Gobierno de Canarias [67]. El modelo se basa en la valoración individual, el plan personalizado, la educación sanitaria y el ejercicio terapéutico [67]. Incluye procesos como la gonartrosis, la coxartrosis, el dolor lumbar y cervical persistente, la epicondilitis y la EPOC leve estable [67].

Galicia abre el acceso directo mediante la gestión de la demanda

El Servizo Galego de Saúde (SERGAS) publica una cartera de servicios de fisioterapia de AP y comunitaria [72]. En 2022 incorporó la categoría de fisioterapeuta a su protocolo de gestión de la demanda del equipo, conocido como XIDE [77]. Con ese protocolo, la persona accede a la consulta de fisioterapia sin la intermediación de otro profesional para motivos clínicos parametrizados [77]. El pilotaje comenzó en los

servicios de Culleredo e Illas Canarias, según una noticia de prensa que este documento usa como fuente secundaria [77].

Madrid admite el acceso directo para tres procesos

La Cartera de Servicios Estandarizados de AP del Servicio Madrileño de Salud, actualizada en septiembre de 2025, incluye la atención fisioterapéutica a personas con procesos musculoesqueléticos agudos y subagudos [73]. En los procesos que no admiten acceso directo, la página institucional de la Comunidad de Madrid indica que es necesaria la derivación del médico de familia [78]. La nota oficial de septiembre de 2025 describe la citación directa desde la Unidad de Atención al Usuario [39].

La Gerencia Asistencial de AP regula esa citación en una instrucción interna titulada «Atención a procesos de demanda en las consultas de las Unidades de Atención Específica de Atención Primaria» [9]. La instrucción procede del Plan Estratégico 2020-2024 de la gerencia y de su proyecto de reorganización asistencial de los centros de salud [9]. Dentro de ese proyecto, el subproyecto de gestión de la demanda busca identificar «qué profesional es el que mejor respuesta puede dar a una demanda concreta» [9]. La instrucción se aplica a cuatro tipos de unidades: matronas, trabajo social sanitario, salud bucodental y fisioterapia [9].

Para la fisioterapia, la instrucción describe tres procesos: la epicondilalgia, el esguince de tobillo y la fascitis plantar [9]. Cada proceso tiene una definición, sus códigos de la Clasificación Internacional de Atención Primaria, una pauta de valoración y unos criterios de derivación [9]. La tabla 3.3 resume esos elementos.

Tabla 3.3. Procesos de citación directa con fisioterapia en la instrucción de la Gerencia Asistencial de AP de Madrid

Proceso	Códigos CIAP	Valoración que pide la instrucción	Se cita con fisioterapia	Se cita con medicina de familia
Epicondilalgia lateral o medial	L93	Escala visual analógica del dolor, cuestionario PRTEE, pruebas de Cozen y de Thomson, prueba de la silla e indicadores de pronóstico negativo	Epicondilalgia sin antecedente traumático	Antecedente traumático en el codo, pérdida de movilidad del codo, la mano o los dedos, o pérdida de sensibilidad en el brazo
Esguince de tobillo	L77 y L16	Escala visual analógica del dolor, valoración de la función y maniobras dinámicas, con las reglas de Ottawa para descartar lesión ósea	Esguince de grado I o II	Traumatismo importante con afectación grave de la movilidad, alteración de la sensibilidad del pie e imposibilidad de apoyo
Fascitis plantar	L87 y L17	Escala visual analógica del dolor y valoración de la función	Toda persona con el cuadro clínico descrito	Traumatismo previo o pie con indicación de tratamiento ortopédico

Fuente: instrucción de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud [9]. PRTEE: Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation.

La instrucción asigna la cita al fisioterapeuta de referencia de la persona, en un hueco de agenda que denomina «V verde» [9]. El personal de la Unidad de Atención al Usuario aplica así una lista cerrada de motivos, y la valoración clínica corresponde al fisioterapeuta. Este reparto de funciones coincide con el paso 2 del circuito de autorreferencia de la sección 6.2.

La instrucción establece también que el diagnóstico de la epicondilalgia es clínico [9]. Las pruebas complementarias solo proceden si se sospecha otra entidad, y en ese caso la persona debe ser valorada por el médico de familia [9]. En el esguince de tobillo, la instrucción reconoce que la radiología ayuda a descartar lesiones óseas mediante las reglas de Ottawa [9]. Sin embargo, no habilita al fisioterapeuta para solicitarla, de modo que la persona con una regla positiva necesita otra consulta. La sección 7.4 desarrolla esta consecuencia.

Este documento cita la versión 8 de la instrucción, de julio de 2024 [9]. Su ficha de gestión documental la sitúa en vigor desde febrero de 2023 [9].

Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha documentan la derivación directa

El Servicio Andaluz de Salud implantó en mayo de 2026 la derivación desde medicina de familia a fisioterapia de AP en toda la comunidad [63]. El circuito cubre la lumbalgia, la cervicgia, la gonalgia, el hombro doloroso, la fascitis plantar y la epicondilitis [63]. La Gerencia de Atención Primaria de Mallorca aprobó en 2023 un protocolo de derivación directa para doce patologías de baja complejidad y alta resolución [65]. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha publicó en 2022 una guía que permite al médico de familia y al pediatra derivar directamente a fisioterapia [68].

3.4. Diagnóstico de los modelos vigentes en los documentos profesionales

Dos documentos profesionales recientes analizan los modelos de Galicia y de Madrid. Ambos coinciden en el diagnóstico, aunque difieren en la calidad de sus fuentes.

La Sociedade Galega de Fisioterapeutas pidió en 2019 la derivación directa

La Sociedade Galega de Fisioterapeutas presentó en febrero de 2019 un análisis de la efectividad clínica y del impacto económico de la fisioterapia en AP [8]. Uno de sus autores representaba a la sociedad en el grupo de trabajo del nuevo modelo de AP del SERGAS [8]. El análisis revisó cinco grupos de procesos: el dolor lumbar no específico, el dolor cervical, el síndrome subacromial, el dolor persistente y la patología traumatológica y ortopédica de baja complejidad [8]. También revisó la evidencia internacional sobre la derivación directa desde medicina de familia y sobre el fisioterapeuta de triaje [8].

Su conclusión pedía implantar la derivación directa desde medicina de familia en el nuevo modelo de AP gallego [8]. Tres años después, el SERGAS incorporó la fisioterapia a su protocolo de gestión de la demanda, según la fuente secundaria citada en la sección 3.3 [77]. Este documento no establece una relación causal entre ambos hechos, porque ninguna fuente la documenta.

Las secciones siguientes citan directamente los estudios originales que ese análisis revisó, contrastados con sus registros de PubMed.

Un documento de trabajo madrileño describe tres limitaciones del modelo

Un documento de trabajo sobre la situación de la fisioterapia de AP en la Comunidad de Madrid describe tres limitaciones del modelo madrileño [50]. La primera es que el acceso depende sobre todo de la derivación desde medicina de familia, con la excepción de la gestión compartida de la demanda [50]. La segunda es que la gestión compartida se ha implantado de forma desigual, y el personal de las unidades de atención al usuario tiene poca experiencia con ella [50]. La tercera es que la persona recibe el alta al terminar el tratamiento, sin un seguimiento longitudinal [50].

El mismo documento propone tres líneas de mejora [50]:

- **Competencias.** Incorporar al fisioterapeuta en el mapa de competencias del Plan de Acción de AP y Comunitaria 2025-2027, con acceso directo en procesos de alta prevalencia y baja discapacidad [48, 50].
- **Cartera de servicios.** Renombrar el servicio de procesos musculoesqueléticos como «Atención de Procesos Musculoesqueléticos», compartir la gestión de las listas de espera y crear una consulta a demanda para el seguimiento de procesos ya diagnosticados [50].

- **Equipo.** Integrar al fisioterapeuta en el equipo multidisciplinar, con coordinación con medicina de familia, programas de educación para la salud grupales y comunitarios, y seguimiento con herramientas digitales [50].

Este documento recoge las tres líneas. La consulta a demanda para procesos ya diagnosticados corresponde a la recidiva de la matriz del anexo C. La coordinación con medicina de familia y los programas de educación para la salud se desarrollan en las secciones 5 y 6.

3.5. Heterogeneidad e inequidad

La misma cartera común se traduce en modelos muy distintos según el territorio. En la mayoría de las comunidades autónomas, la derivación directa desde medicina de familia ya está documentada (tabla 3.2). Sin embargo, solo Galicia y Madrid documentan el acceso directo del ciudadano, y Madrid lo limita a tres procesos [39, 77].

La dotación también difiere en más de diez veces entre comunidades autónomas [58]. Una persona con el mismo proceso puede recibir, por tanto, una atención muy distinta según su lugar de residencia. Esta desigualdad es el argumento principal para un modelo homogéneo en todo el SNS.

4. Modelos internacionales de referencia

Esta sección describe los sistemas sanitarios que sirven de referencia a la propuesta. Para cada uno, indica qué elementos se toman y qué elementos no se piden para España. Todas las afirmaciones proceden de documentos oficiales del sistema descrito o de artículos revisados por pares.

Advertencia metodológica. Las estadísticas internacionales cuentan los fisioterapeutas de todo el sistema sanitario y no los de atención primaria. Además, cada país usa una definición distinta: fisioterapeutas en ejercicio, profesionalmente activos o con licencia. Ninguna cifra de esta sección sirve para fijar una ratio de atención primaria. La dotación que propone este documento sale del modelo de demanda de la sección 9.

4.1. Inglaterra y la fisioterapia de primer contacto

El NHS Long Term Plan de 2019 impulsó equipos multidisciplinares comunitarios ligados a las redes de atención primaria [79]. Desde 2020, las consultas de medicina general pueden financiar la contratación de fisioterapeutas de primer contacto a través del Additional Roles Reimbursement Scheme [13, 80]. NHS England describe el objetivo de que las personas adultas puedan ver a un fisioterapeuta de primer contacto en su centro sin derivación del médico general [13].

Health Education England publicó en 2020 una hoja de ruta de competencias para este perfil [81]. El documento sitúa la práctica en nivel de máster y organiza catorce capacidades en cuatro dominios [81]. Según esa documentación, el profesional de primer contacto puede solicitar pruebas y derivar a atención hospitalaria por las mismas vías que el médico general [81]. La Chartered Society of Physiotherapy publicó con la British Medical Association y el Royal College of General Practitioners una guía de implantación [82].

El Reino Unido debatía ya en los años noventa el acceso de los médicos generales a la fisioterapia sin pasar por el especialista hospitalario. Una revisión de 1997 reunió ocho estudios que comparaban distintos modelos de acceso [83]. Sus principales ventajas eran una espera menor, un coste menor por paciente tratado y un coste menor para el propio paciente [83]. Otra revisión del mismo año encontró un coste medio menor cuando el médico general derivaba directamente a fisioterapia que cuando lo hacía el especialista hospitalario [84]. La misma revisión advirtió que la fisioterapia en AP parecía generar más demanda que los demás modelos [84]. El modelo de primer contacto actual se apoya en esa experiencia previa de derivación directa.

Las evaluaciones publicadas describen el funcionamiento del modelo:

- Goodwin y Hendrick evaluaron más de quinientos pacientes atendidos por fisioterapia como primer contacto en dos consultas de medicina general [85].
- La evaluación nacional de Stynes y colaboradores incluyó 40 centros y 240 fisioterapeutas de primer contacto en Inglaterra [86]. La misma evaluación estudió la satisfacción de los pacientes y la experiencia de los profesionales [87, 88].
- El estudio FRONTIER comparó la atención de primer contacto por fisioterapia con la atención iniciada por el médico general en 426 adultos de 46 consultas [89]. No encontró diferencias en la función física a los seis meses y no identificó problemas de seguridad [89].

- En FRONTIER, el 44,7 % de las personas del grupo de medicina general recibió medicación tras la primera consulta [89]. En los dos grupos de fisioterapia, la proporción fue del 18,4 % y del 24,7 % [89]. El coste mediano para el NHS fue de 105,5 libras por paciente en el grupo médico, frente a 41,0 y 44,0 libras en los grupos de fisioterapia [89, 90].

Tabla 4.1. Elementos del modelo inglés que se toman y que no se piden

Elemento del modelo inglés	Se toma para el SNS	Se pide en este documento
Fisioterapeuta integrado en el equipo de atención primaria	Sí	Sí, como principio del modelo organizativo
Primer contacto para procesos musculoesqueléticos sin derivación médica	Sí, para procesos protocolizados	Sí, con la matriz del anexo C
Financiación específica ligada a la contratación	No	No
Solicitud de radiografía simple	En parte	Sí, como habilitación normativa limitada (sección 7.4)
Solicitud de resonancia magnética y otras pruebas avanzadas	No	No
Derivación directa a atención hospitalaria sin medicina de familia	No	No, salvo el circuito de urgencias
Objetivo de liberar consultas médicas	Sí, como resultado a evaluar	No se presenta como resultado garantizado

Fuente: elaboración propia a partir de los documentos de NHS England, Health Education England y la Chartered Society of Physiotherapy [13, 81, 82].

4.2. Noruega, Países Bajos y Suecia y la autorreferencia normalizada

Los Países Bajos introdujeron el acceso directo a fisioterapia en 2006 [91]. En el primer año, el 28 % de los pacientes llegó a fisioterapia por acceso directo [91]. Ese mismo estudio observó que el número total de pacientes atendidos no aumentó respecto al año anterior [91]. Los pacientes con acceso directo recibieron además menos sesiones de tratamiento [91]. Una evaluación posterior describió la evolución de la autorreferencia durante cinco años [92]. Según el instituto Nivel, en 2024 el 74,3 % de los pacientes acudió a fisioterapia sin derivación [93]. El coste total del dolor lumbar en los Países Bajos bajó de 4.300 a 3.500 millones de euros entre 2002 y 2007 [25]. Este documento no atribuye ese descenso al acceso directo, porque el estudio no analiza esa relación y el acceso directo empezó en 2006 [25, 91].

Noruega eliminó el requisito de derivación médica para la fisioterapia financiada el 1 de enero de 2018 [94]. La condición para la financiación pública es que el fisioterapeuta tenga acuerdo con el municipio [94].

En Suecia, la organización depende de cada región. La región de Estocolmo informa de que no se necesita derivación para contactar con fisioterapia de AP, aunque advierte que otras regiones pueden exigirla [95]. Un ensayo pragmático sueco comparó la valoración inicial por fisioterapia en el centro de salud con la valoración inicial por el médico general [96]. Su evaluación económica encontró un manejo más coste-efectivo cuando la primera valoración la hacía fisioterapia [97]. Ese diseño es un triaje dentro del centro y no un acceso directo nacional, de modo que no debe presentarse como tal. Otro ensayo sueco en AP comparó el acceso a fisioterapia en dos días con una espera de cuatro semanas en el dolor lumbar subagudo [33]. El acceso precoz redujo más el dolor a los seis meses, y sus autores lo consideran viable mediante una reorganización sin recursos adicionales [33].

Tabla 4.2. Elementos de Noruega, Países Bajos y Suecia que se toman

Elemento	Aplicación en la propuesta
Acceso directo normalizado	Legitima la autorreferencia protocolizada
Aumento progresivo de la autorreferencia a lo largo de los años	Justifica un despliegue por fases y un parámetro de captación en el modelo
Financiación pública ligada a un acuerdo con la administración	Refuerza la integración del fisioterapeuta en la estructura pública
Triage por fisioterapia dentro del centro de salud	Apoya la consulta de primer contacto del nivel 1

Fuente: elaboración propia a partir de los documentos citados en la sección 4.2 [91, 93-95].

4.3. Australia y Canadá

La Australian Physiotherapy Association describe la práctica avanzada y el primer contacto, incluida la solicitud de imagen en algunos servicios de urgencias [98]. La Canadian Physiotherapy Association reconoce el acceso directo, pero advierte que la práctica cambia entre provincias [99]. Ambos sistemas se citan solo como referencia de equipos interprofesionales, porque la cobertura pública de la fisioterapia es distinta de la española.

Canadá ha evaluado con detalle el triaje por fisioterapia en la interfaz con cirugía ortopédica. En Columbia Británica, Napier y colaboradores compararon las decisiones de manejo quirúrgico del fisioterapeuta y del cirujano [100]. La concordancia entre ambos fue sustancial, con un índice kappa ponderado de 0,77 [100]. En Saskatchewan, un programa de triaje de columna clasificó el 92,5 % de los casos como columna mecánica y solo el 2 % como columna quirúrgica [101]. Entre las personas que el programa derivó al cirujano, el 80 % resultó candidata a cirugía [101].

En Ontario, un grupo de investigación diseñó un ensayo por conglomerados para evaluar un modelo de AP liderado por fisioterapia para el dolor lumbar [102]. PubMed no recoge todavía los resultados del estudio piloto. Este documento cita el protocolo solo como muestra de que otros sistemas públicos están evaluando el mismo modelo.

4.4. Triage musculoesquelético por fisioterapia y tasa de conversión quirúrgica

El triaje musculoesquelético es un modelo distinto del acceso directo. En él, un fisioterapeuta de práctica avanzada valora a las personas ya derivadas a traumatología o a una unidad de columna. El fisioterapeuta decide si la persona necesita ver al cirujano o puede seguir un tratamiento conservador. La tasa de conversión quirúrgica mide el porcentaje de personas derivadas al cirujano que terminan con indicación de cirugía.

Este documento no pide implantar el triaje en la interfaz con atención hospitalaria. Sin embargo, su evidencia informa sobre dos capacidades que la propuesta sí usa: la precisión diagnóstica del fisioterapeuta y su capacidad para seleccionar a quién derivar.

Tabla 4.3. Estudios y revisiones sobre triaje musculoesquelético por fisioterapia

Estudio	Ámbito	Diseño	Resultado principal
Napier y colaboradores, 2013 [100]	Columbia Británica, Canadá	Estudio prospectivo en dos centros	Conversión quirúrgica del 91 % en las derivaciones del fisioterapeuta, frente al 22 % en las del médico general o de urgencias

Estudio	Ámbito	Diseño	Resultado principal
Bath y colaboradores, 2012 [101]	Saskatchewan, Canadá	Revisión retrospectiva de historias	El 2 % de los casos se clasificó como columna quirúrgica, y el 80 % de las derivaciones al cirujano resultó candidata a cirugía
Wood y colaboradores, 2016 [40]	Unidad de columna, Reino Unido	Evaluación retrospectiva de 2.651 personas	El 92 % se resolvió sin el cirujano, y el 81 % de las derivaciones al cirujano fue adecuado
Candy y colaboradores, 2016 [41]	Gales, Reino Unido	Evaluación de servicio con 2.362 altas	El 2 % volvió a atención hospitalaria por el mismo problema entre doce y dieciocho meses después
Oakley y Shacklady, 2015 [103]	Revisión sistemática	14 estudios	Resultados favorables en todos los estudios, con buena capacidad diagnóstica frente a un patrón de referencia como la cirugía
Samsson y colaboradores, 2020 [104]	Revisión sistemática	2 ensayos y 11 cohortes	Conversión quirúrgica del 55 % al 91 % con triaje por fisioterapia, frente al 22 % al 38 % sin él, con certeza baja a moderada
Trøstrup y colaboradores, 2020 [105]	Revisión sistemática	1 ensayo y 31 estudios observacionales	Concordancia diagnóstica con el cirujano del 65 % al 100 % y ahorro del 27 % al 49 % en la valoración diagnóstica
Lafrance y colaboradores, 2023 [106]	Revisión sistemática con metaanálisis	19 estudios de concordancia y 6 ensayos	Kappa de 0,76 para la concordancia diagnóstica con el médico y de 0,71 para la decisión quirúrgica

Fuente: elaboración propia a partir de los resúmenes de PubMed de cada estudio [40, 41, 100, 101, 103-106].

Las revisiones más recientes tienen mayor peso que los estudios aislados. Lafrance y colaboradores encontraron, con certeza moderada, una concordancia diagnóstica alta entre el fisioterapeuta de práctica avanzada y el médico [106]. La concordancia en la decisión quirúrgica también fue alta, con certeza alta [106]. Samsson y colaboradores hallaron además tiempos de espera más cortos en un ensayo y en una cohorte, y un coste menor en un ensayo [104].

Dos cautelas limitan la lectura de estos datos. La primera es que los estudios aislados son evaluaciones de servicio sin grupo control. La segunda es que el 81 % de Wood y colaboradores mide la adecuación de la derivación y no la cirugía realizada [40].

4.5. Síntesis de la evidencia sobre acceso directo

Las revisiones sistemáticas disponibles comparan el acceso directo con la atención iniciada por el médico. Ojha y colaboradores incluyeron ocho estudios observacionales y no encontraron evidencia de daño [29]. Piscitelli y colaboradores revisaron trece estudios sobre viabilidad, efectividad, costes, seguridad y satisfacción [107]. Demont y colaboradores incluyeron dieciocho estudios de calidad débil a moderada [108]. Babatunde y colaboradores concluyeron que el dolor y la discapacidad no difieren mucho entre ambos modelos [109]. La misma revisión encontró un uso menor de servicios y menos ausencia laboral con el acceso directo, con una evidencia consistente pero limitada [109].

Las revisiones más recientes aportan estimaciones cuantitativas. Gallotti y colaboradores revisaron 28 artículos y no encontraron eventos adversos en ninguno de ellos [110]. Abuhl y colaboradores combinaron diez ensayos aleatorizados con 2.081 pacientes [31]. El primer contacto por fisioterapia redujo la solicitud de imagen, con un riesgo relativo de 0,55, y la medicación, con un riesgo relativo de 0,29 [31]. Una revisión de práctica avanzada llegó a conclusiones favorables sobre la efectividad de este perfil [111].

El efecto sobre la carga de medicina de familia es heterogéneo, y este documento lo presenta como un resultado posible y no garantizado. El estudio STEMS-2 analizó seis años de datos de cuatro consultas

inglesas antes y después de abrir la autorreferencia [112]. No encontró un efecto consistente sobre las consultas musculoesqueléticas de medicina general [112]. La autorreferencia real supuso solo el 10 % y el 6 % de las entradas a fisioterapia en los dos brazos del estudio [112]. En cambio, una revisión de 2026 reunió 21 estudios con 90.401 pacientes [113]. Esa revisión estimó entre un 10 % y un 30 % menos de consultas de medicina general con acceso directo [113]. Un metaanálisis del mismo grupo encontró menos prescripción, con un riesgo relativo de 0,57 y una certeza baja [114].

La intensidad del tratamiento también se ha estudiado. Una revisión de ocho ensayos con 1.153 personas con dolor lumbar comparó dos o menos visitas de fisioterapia con tres o más [115]. Al año no encontró diferencias en dolor, discapacidad ni calidad de vida [115]. Sin embargo, dos de los tres estudios con análisis económico encontraron más coste-efectivo el uso mayor [115]. Este resultado apoya un modelo que ajuste el número de sesiones a la necesidad y no a una pauta fija.

La percepción ciudadana del acceso directo es otro factor. En una encuesta telefónica en Florida, el 67,3 % de las personas no conocía la posibilidad de acceso directo, pero el 73,4 % declaró que acudiría directamente al fisioterapeuta [116]. El dato procede de otro sistema sanitario, pero anticipa la necesidad de informar a la ciudadanía que recoge la tabla 11.2.

Tabla 4.4. Síntesis de la evidencia por tipo de resultado

Resultado	Dirección del efecto del acceso directo	Certeza y comentario
Seguridad	Sin eventos adversos atribuibles en las revisiones	Consistente entre revisiones [29, 110, 113]
Dolor y función	Sin diferencias relevantes frente a la atención médica	Ensayos y revisiones [89, 109]
Pruebas de imagen	Menos solicitudes	Metaanálisis de ensayos [31]
Medicación	Menos prescripción	Metaanálisis con certeza baja a moderada [31, 114]
Coste	Menor en la mayoría de los estudios	Entornos distintos del español [30, 89, 97]
Consultas de medicina general	Heterogéneo	Sin efecto consistente en STEMS-2 y reducción estimada en una revisión [112, 113]
Captación de la autorreferencia	Baja al inicio y creciente con los años	Datos del Reino Unido y de los Países Bajos [91, 93, 112]
Momento del acceso	Menos uso posterior de servicios y menor coste con la fisioterapia precoz	Un estudio observacional y dos ensayos con efectos modestos [32-34]
Tasa de conversión quirúrgica	Mayor cuando deriva el fisioterapeuta de triaje	Revisión con certeza baja a moderada, fuera del acceso directo [104]

Fuente: elaboración propia a partir de las revisiones y estudios citados en cada fila.

4.6. Densidad de fisioterapeutas en Europa

Según Eurostat, en 2021 trabajaban en la Unión Europea 611.000 fisioterapeutas, con una media de 136,7 por 100.000 habitantes [117]. Alemania alcanzaba 234,4 y Bélgica 215,9, mientras que Rumanía se situaba en 12,7 [117]. En 2023, la media de la Unión llegó a 149 por 100.000 habitantes [118]. Estas cifras cuentan todos los ámbitos asistenciales, como indica la advertencia inicial de esta sección.

Tabla 4.5. Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en la Unión Europea y en países seleccionados

Territorio	2021	2023	Definición
Alemania	234,4	240	En ejercicio, todos los ámbitos

Territorio	2021	2023	Definición
Bélgica	215,9	228	En ejercicio, todos los ámbitos
Países Bajos	Sin dato en la fuente citada	188	En ejercicio, todos los ámbitos
Rumanía	12,7	Sin dato en la fuente citada	En ejercicio, todos los ámbitos
Unión Europea	136,7	149	Media de los Estados miembros

Fuente: Eurostat [117, 118]. Algunos países notifican fisioterapeutas profesionalmente activos o con licencia, según las notas metodológicas de Eurostat.

El censo anual de World Physiotherapy de 2024 estimó una media mundial de 3,6 fisioterapeutas por 10.000 habitantes [119]. En ese censo, el 39 % de las organizaciones nacionales declaró acceso directo pleno en su país [119]. Una encuesta anterior de Bury y Stokes encontró acceso directo en el 58 % de los países que respondieron, con más frecuencia en el ámbito privado [120].

5. Modelo organizativo propuesto

Esta sección define cómo se organiza la fisioterapia dentro del equipo de AP. Describe tres niveles de atención comunitaria, las funciones clínicas, los programas grupales y comunitarios y las modalidades asistenciales. Cada programa grupal tiene una ficha en el anexo A con las horas de fisioterapia que consume. Esas horas alimentan el modelo de dotación de la sección 9.

5.1. Principios

El modelo se apoya en seis principios:

- **Integración en el equipo.** El fisioterapeuta forma parte del equipo de AP de cada zona básica de salud como miembro de pleno derecho y no como personal de apoyo.
- **Consulta propia.** Cada zona básica dispone de consulta de fisioterapia con espacio físico propio o compartido de forma estable.
- **Agenda propia.** La agenda de fisioterapia admite citas por todas las vías de entrada de la sección 6.
- **Historia clínica compartida.** El fisioterapeuta registra su actividad en la misma historia clínica que el resto del equipo.
- **Tiempo protegido.** La jornada reserva tiempo para la actividad comunitaria no clínica, la docencia, la investigación y la coordinación. El modelo de dotación de la sección 9 lo incluye de forma explícita.
- **Medición común.** Todos los servicios de salud registran los indicadores de la sección 10.
- **Seguimiento longitudinal.** El alta de un episodio no cierra la relación con la persona. Quien recibe el alta puede volver por autorreferencia si recae un proceso ya diagnosticado.

El último principio responde a una limitación descrita en Madrid, donde la persona recibe el alta al terminar el tratamiento, sin un seguimiento posterior [50]. La recidiva de un proceso diagnosticado figura por esa razón entre los motivos de autorreferencia del anexo C.

5.2. Niveles de atención comunitaria

El modelo organiza la actividad en tres niveles de atención comunitaria. Cada nivel tiene una población diana, una puerta de entrada, una intensidad y unas salidas propias.

Tabla 5.1. Niveles de atención comunitaria de la fisioterapia de atención primaria

Nivel	Población diana	Puerta de entrada	Intensidad	Salidas
Nivel 1. Consulta de fisioterapia de primer contacto	Personas adultas con procesos musculoesqueléticos y otros procesos de la matriz del anexo C	Autorreferencia, derivación desde medicina de familia y demás vías de la sección 6	Primera consulta de valoración y, si procede, consultas individuales de seguimiento	Alta con plan de autocuidado, tratamiento individual, programa grupal o derivación a otro profesional
Nivel 2. Intervención grupal e intervención comunitaria	Personas con un proceso definido que se beneficia del trabajo en grupo y población general en la intervención comunitaria	Nivel 1, enfermería familiar y comunitaria y medicina de familia	Ediciones periódicas según las fichas del anexo A	Alta con plan de automanejo o retorno al nivel 1

Nivel	Población diana	Puerta de entrada	Intensidad	Salidas
Nivel 3. Fisioterapia domiciliar y de continuidad	Personas con dependencia, fragilidad, alta hospitalaria reciente o cronicidad compleja	Enfermería, medicina de familia, trabajo social sanitario y atención hospitalaria	Visitas domiciliarias y coordinación sociosanitaria	Alta, paso al nivel 2 o valoración multidisciplinar

Fuente: elaboración propia.

La consulta de primer contacto tiene cuatro salidas posibles. La persona puede recibir el alta con un plan de autocuidado, iniciar un tratamiento individual, incorporarse a un programa grupal o ser derivada a otro profesional.

5.3. Funciones clínicas

El fisioterapeuta de AP valora procesos musculoesqueléticos de distinta complejidad y los estratifica. La función de cribado existe precisamente porque llegan procesos simples y complejos, y el primer contacto debe distinguirlos.

Tabla 5.2. Funciones clínicas del fisioterapeuta de atención primaria

Función	Contenido
Primer contacto	Valoración de procesos musculoesqueléticos con estratificación de su complejidad
Cribado clínico	Detección de signos de alarma, riesgo neurológico, sospecha de fractura y enfermedad sistémica
Diagnóstico fisioterapéutico	Dolor, función, movilidad, fuerza, equilibrio y marcha
Plan de intervención	Ejercicio terapéutico, educación, autocuidado y, si procede, terapia manual o medios físicos
Prescripción de ejercicio	Individualizada y progresiva
Apoyo a la valoración con ecografía	Uso de la ecografía para valorar y reevaluar, sin informe radiológico (sección 7.3)
Derivación	A medicina de familia, enfermería, urgencias o recursos comunitarios
Alta	Informe funcional y plan de autocuidado

Fuente: elaboración propia.

La función de cribado tiene respaldo en la evidencia sobre práctica avanzada. Una revisión con metaanálisis encontró una concordancia diagnóstica alta entre el fisioterapeuta de práctica avanzada y el médico, con un kappa de 0,76 [106]. Esa revisión incluyó también ensayos en los que la atención por fisioterapia redujo el dolor de forma comparable o mayor que la atención habitual [106]. El fisioterapeuta de AP de esta propuesta no ejerce como fisioterapeuta de práctica avanzada, pero su primera consulta usa el mismo razonamiento clínico.

La derivación a atención hospitalaria se hace a través de medicina de familia, salvo la derivación urgente. La solicitud de radiografía simple se trata en la sección 7.4 como petición de desarrollo normativo.

5.4. Programas grupales y programas comunitarios

El documento distingue dos tipos de intervención colectiva. La **intervención grupal** es una intervención clínica sobre un grupo de personas con un proceso definido. La **intervención comunitaria** actúa sobre la población o sobre los activos comunitarios, sin un proceso clínico individual. La distinción se recoge en el glosario del anexo D.

Cada programa grupal tiene una ficha en el anexo A. La ficha indica quién lo lidera, el tamaño del grupo, el número de sesiones, las horas de fisioterapia por edición y la frecuencia de oferta. Con esos datos, el Ministerio de Sanidad puede estimar la carga de trabajo real que implica cada programa.

Tabla 5.3. Programas grupales

Id	Programa	Liderazgo	Grupo	Sesiones	Horas de fisioterapia por edición	Ediciones por 10.000 habitantes y año, escenario central
PG-01	Prevención de caídas y fragilidad [121]	Fisioterapia, con enfermería familiar y comunitaria en la captación y el seguimiento	10 a 12	24	28	4
PG-02	Dolor persistente: educación en neurociencia del dolor y ejercicio [122]	Fisioterapia, con medicina de familia en la selección de participantes	10 a 15	24	32	3
PG-03	Artrosis de rodilla y cadera [123]	Fisioterapia	10 a 12	12	15	3
PG-04	EPOC en fase estable [124]	Compartido: fisioterapia en el ejercicio y enfermería familiar y comunitaria en la educación sobre autocuidado e inhaladores	8 a 10	16	15	2
PG-05	Escuela de espalda [125]	Fisioterapia	10 a 12	8	10	4

Fuente: anexo A. Las horas por edición incluyen la preparación y la evaluación. Las ediciones por 10.000 habitantes son parámetros de diseño que alimentan el modelo de la sección 9.

Los programas grupales se apoyan en evidencia de ensayos y revisiones. El ejercicio que combina equilibrio y trabajo funcional reduce la tasa de caídas en personas mayores que viven en la comunidad, con certeza alta [121]. El ejercicio terapéutico reduce el dolor en la artrosis de rodilla, con certeza alta a corto plazo [123]. La rehabilitación respiratoria mejora la disnea, la fatiga y la capacidad de ejercicio en la EPOC [124]. El ejercicio reduce el dolor lumbar persistente frente a la ausencia de tratamiento o la atención habitual, con certeza moderada [125]. En España, un ensayo pragmático en doce centros de AP de Castilla y León comparó un programa grupal con la fisioterapia habitual en el dolor vertebral persistente [122]. El programa combinó seis sesiones de educación en neurociencia del dolor y dieciocho sesiones de ejercicio grupal en seis semanas [122]. Las diferencias favorecieron al programa grupal y se mantuvieron a los seis meses [122].

La educación en neurociencia del dolor tiene una evidencia favorable, aunque con matices. Una revisión de 13 ensayos respaldó su uso en los trastornos musculoesqueléticos persistentes para reducir el dolor, la discapacidad y el uso de servicios [126]. En cambio, un metaanálisis de nueve ensayos no encontró mejoras en dolor ni discapacidad cuando la educación se comparaba con la atención habitual [127]. Sus autores no recomiendan esa educación como intervención aislada [127]. Por eso el programa PG-02 combina educación y ejercicio, como el ensayo de Castilla y León [122].

Otras experiencias españolas en AP apoyan el formato grupal. En la Costa del Sol, un ensayo no aleatorizado en las escuelas de espalda de fisioterapia de AP añadió educación de base cognitivo-conductual [128]. El grupo de intervención redujo más el miedo, el catastrofismo y la discapacidad, aunque no el dolor [128]. Una cohorte retrospectiva española de 149 personas con dolor vertebral persistente siguió un protocolo de ejercicio terapéutico grupal en AP [129]. El dolor y la discapacidad mejoraron con un tamaño del efecto moderado a grande, aunque el estudio no tuvo grupo control [129].

La evidencia sobre el formato grupal en los procesos agudos es escasa. Un ensayo andaluz en dolor cervical mecánico agudo y subagudo, realizado en un centro de especialidades, encontró mejores resultados con el tratamiento individual que con el grupal [130]. Por esa razón, los programas del anexo A se dirigen a procesos persistentes o estables, y los procesos agudos se atienden en la consulta individual del nivel 1.

La prevención de la fragilidad cuenta con ensayos en AP española. Un ensayo en AP con personas prefrágiles de 70 años o más combinó una valoración nutricional con un programa de actividad física [131]. La intervención redujo la progresión a fragilidad a los doce meses [131]. Pasó a fragilidad el 4,9 % del grupo de intervención y el 15,3 % del grupo control [131]. El ensayo no encontró diferencias en fuerza muscular ni en velocidad de la marcha [131]. En Barcelona, una intervención multifactorial en AP mejoró la función física de personas mayores frágiles a los tres y a los dieciocho meses [132]. El ensayo MEFAP evalúa un programa de ejercicio multicomponente en AP para personas prefrágiles mayores de 70 años [133]. PubMed recoge su protocolo, pero no sus resultados.

Tabla 5.4. Intervenciones comunitarias

Id	Intervención comunitaria	Población	Liderazgo	Horas de fisioterapia por edición	Ediciones por 10.000 habitantes y año, escenario central
PC-01	Promoción de la actividad física con activos comunitarios	Población general adulta de la zona básica de salud	Equipo de atención primaria, con fisioterapia en el diseño y coordinación con salud pública y entidades locales	10	1
PC-02	Salud escolar: ergonomía y actividad física	Alumnado y profesorado de los centros educativos de la zona básica de salud	Fisioterapia y enfermería familiar y comunitaria, con los centros educativos	6	2
PC-03	Salud laboral comunitaria	Colectivos locales con alta carga física en el trabajo	Fisioterapia, en coordinación con los servicios de prevención cuando existan	6	1

Fuente: anexo A. Estas intervenciones desarrollan la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del SNS, que vincula el consejo en AP con los recursos comunitarios [52].

5.5. Modalidades asistenciales

Tabla 5.5. Modalidades asistenciales de la fisioterapia de atención primaria

Modalidad	Se incluye	Contenido
Consulta individual presencial	Sí	Valoración inicial, seguimiento y alta
Consulta breve resolutive	Sí	Educación, consejo y automanejo
Intervención grupal	Sí	Programas de la tabla 5.3
Fisioterapia domiciliaria	Sí	Dependencia, fragilidad y altas hospitalarias
Teleconsulta	Sí	Seguimiento, educación y adherencia
Consulta telefónica	Sí	Revisión, dudas, seguimiento y valoración previa de la idoneidad y la prioridad
Consulta a demanda de seguimiento	Sí	Recidiva de un proceso ya diagnosticado, sin nueva derivación
Interconsulta no presencial	Sí	Coordinación con medicina de familia, enfermería y atención hospitalaria
Intervención comunitaria	Sí	Activos en salud y ejercicio comunitario
Sesión clínica compartida	Sí	Revisión conjunta de casos crónicos complejos entre medicina, enfermería y fisioterapia
Escuela de pacientes	Sí	Dolor persistente, artrosis, EPOC y espalda
Fisioterapia en residencias	Sí, coordinada con el centro	Prevención del deterioro funcional

Fuente: elaboración propia.

La interconsulta no presencial ya existe como servicio de los hospitales de la Comunidad de Madrid, que la denominan e-consulta [78].

La tabla incluye dos modalidades que proceden de la experiencia madrileña. La primera es la consulta a demanda para el seguimiento de procesos ya diagnosticados, que propone el documento de trabajo madrileño [50]. Esta modalidad corresponde a la recidiva de un proceso diagnosticado del anexo C. La segunda es la consulta telefónica previa para valorar la idoneidad y la prioridad [9]. La instrucción de la Gerencia Asistencial la usa en los procesos de demanda de las matronas [9]. Ese formato permite al fisioterapeuta confirmar el motivo antes de ocupar una cita presencial. La sesión clínica compartida es una revisión conjunta de casos entre profesionales, y no una sesión de tratamiento.

5.6. Herramientas de salud digital

La Estrategia de Salud Digital del SNS ofrece el marco para tres herramientas [53]. La teleconsulta permite el seguimiento de personas con dificultades de desplazamiento. El seguimiento remoto de la adherencia refuerza los planes de ejercicio. La prescripción digital de ejercicio facilita la continuidad entre sesiones. Estas herramientas son también una de las tres palancas del ajuste por ruralidad de la sección 9.4. El documento de trabajo madrileño propone también el seguimiento y la monitorización a distancia como parte de la integración del fisioterapeuta en el equipo [50].

6. Vías de acceso y circuitos asistenciales

Esta sección describe por dónde entra una persona a fisioterapia de AP y qué documento acompaña cada entrada. Todos los circuitos terminan con un criterio de retorno explícito. Las tablas de esta sección proceden de la matriz de coherencia del anexo C, que es la única fuente de los procesos, las vías y las condiciones.

6.1. Vías de entrada

Tabla 6.1. Vías de entrada a la fisioterapia de atención primaria

Vía de entrada	Admitida	Procesos de la matriz	Requisito documental	Circuito
Autorreferencia del ciudadano	Sí, para procesos protocolizados de personas adultas	P01 a P08	Solicitud de cita con registro del motivo de consulta parametrizado	1
Medicina de familia y comunitaria	Sí, vía principal para procesos con diagnóstico médico o comorbilidad	P01 a P06, P08 a P10, P15	Interconsulta en la historia clínica compartida	2
Enfermería familiar y comunitaria	Sí, en especial fragilidad, caídas, cronicidad e inmovilidad	P09, P10, P15	Interconsulta con resultado del cribado de fragilidad cuando proceda	3
Pediatría de atención primaria	Sí, si la cartera autonómica define la oferta pediátrica	P17	Interconsulta	2
Matrona	Sí, si la cartera autonómica incorpora el proceso	P16	Interconsulta	2
Trabajo social sanitario	Sí, para dependencia, domicilio y barreras funcionales	P15	Informe social y valoración de necesidades	3
Medicina de atención hospitalaria	Sí, en tres situaciones definidas	P11 a P13	Informe clínico mínimo con criterio de retorno	4
Retorno desde rehabilitación hospitalaria	Sí, para continuidad funcional	P14	Informe de alta de rehabilitación	5

Fuente: anexo C. Los códigos de proceso remiten a la matriz de coherencia.

6.2. Circuito 1. Autorreferencia

La autorreferencia permite a una persona adulta pedir cita con fisioterapia sin derivación previa, solo para los procesos de la tabla 8.1. El circuito tiene cinco pasos:

1. La persona solicita la cita por vía presencial, telefónica o digital.
2. El personal administrativo aplica un protocolo de gestión de la demanda con motivos de consulta parametrizados por los clínicos del equipo. Este paso no es un triaje ni una valoración clínica: solo comprueba que el motivo figura en la lista y asigna la cita.
3. El fisioterapeuta realiza la primera consulta, que incluye el cribado clínico de signos de alarma y la estratificación del proceso.
4. Si el proceso es abordable en AP, el fisioterapeuta elige una de las salidas del nivel 1: alta con plan de autocuidado, tratamiento individual o programa grupal.
5. Si aparecen signos de alarma o complejidad, el fisioterapeuta deriva a medicina de familia en el mismo día o, si la situación lo exige, a urgencias.

Los dos precedentes españoles de acceso directo funcionan con este mecanismo. Galicia incorporó la fisioterapia a su protocolo de gestión de la demanda del equipo en 2022 [77]. Madrid cita desde la Unidad de Atención al Usuario a las personas que refieren tres procesos concretos desde 2025 [39]. El circuito puede usar además un cuestionario de autorreferencia que la persona rellena antes de la cita. Quien lo lee e interpreta es siempre el fisioterapeuta.

La instrucción madrileña concreta cómo funciona el paso 2 [9]. La Unidad de Atención al Usuario cita a la persona con su fisioterapeuta asignado, en un hueco de agenda reservado para esta demanda [9]. Si la persona refiere un traumatismo importante u otros criterios de la instrucción, la cita se da con su médico de familia [9]. Cada proceso lleva asociados sus códigos de la Clasificación Internacional de Atención Primaria, lo que permite registrar y medir la actividad [9].

El documento de trabajo madrileño identifica el punto débil de este paso: el personal de las unidades de atención al usuario tiene poca experiencia con la derivación directa, y su aplicación ha sido desigual [50]. Por eso el circuito exige tres apoyos. El primero es un guion de citación con la lista cerrada de motivos y de criterios de exclusión. El segundo es la formación del personal administrativo que recoge la sección 11.3. El tercero es la auditoría periódica de los motivos registrados, con el indicador IE-6.

6.3. Circuito 2. Derivación desde medicina de familia

1. El médico de familia diagnostica o sospecha un proceso abordable en AP.
2. El médico registra una interconsulta a fisioterapia en la historia clínica compartida.
3. El fisioterapeuta realiza la valoración funcional y define el plan terapéutico.
4. El fisioterapeuta emite un informe de alta o devuelve a la persona a medicina de familia.

El retorno a medicina de familia se produce en cuatro situaciones: ausencia de mejoría, aparición de signos de alarma, situación clínica que contraindica la fisioterapia en ese momento o problema no abordable en AP.

La derivación desde medicina de familia a fisioterapia de AP evita un paso intermedio por atención hospitalaria. Ese paso es frecuente hoy. En un área de salud de Castilla y León, solo el 11,2 % de las derivaciones de AP a traumatología mencionaba una fisioterapia previa [36]. Además, los procesos degenerativos justificaron el 65,7 % de esas derivaciones [36]. En el dolor lumbar, añadir ejercicio y educación a la atención del médico general es más coste-efectivo que la atención médica sola [134].

El documento de trabajo madrileño propone además que medicina de familia y fisioterapia compartan la gestión de las listas de espera [50]. Esta propuesta encaja en el circuito 2 si ambos profesionales usan criterios comunes de prioridad. El grupo de trabajo de la sección 11.4 debe definir esos criterios dentro de la matriz común.

6.4. Circuito 3. Derivación desde enfermería familiar y comunitaria

1. Enfermería detecta fragilidad, riesgo de caídas, inmovilidad, dolor persistente o baja actividad física.
2. En el caso de la fragilidad y las caídas, la entrada exige un cribado de fragilidad positivo realizado por enfermería.
3. Fisioterapia incorpora a la persona a un programa individual, grupal o domiciliario.
4. Enfermería y fisioterapia comparten el seguimiento.

Los ensayos españoles en AP respaldan este circuito. Una intervención con valoración nutricional y actividad física redujo la progresión a fragilidad en personas prefrágiles [131]. Otra intervención multifactorial mejoró la función física de personas mayores frágiles [132]. En ambos casos, la captación se hizo desde la consulta de AP, que es el papel que este circuito asigna a enfermería [131, 132].

6.5. Circuito 4. Derivación desde medicina de atención hospitalaria

Se proponen tres situaciones en las que la derivación desde medicina de atención hospitalaria a fisioterapia de AP es una opción viable. En esas situaciones, la derivación es también eficiente para el paciente y para el sistema:

- La continuidad asistencial tras el alta, con pérdida funcional leve o moderada en procesos respiratorios, cardiológicos, neurológicos u oncológicos.
- Un proceso leve o moderado que no requiere rehabilitación hospitalaria, como la artrosis, el dolor lumbar o el hombro doloroso no quirúrgico.
- El seguimiento funcional comunitario de la fragilidad, las caídas o el ejercicio terapéutico supervisado.

La derivación exige cuatro condiciones:

1. La persona está clínicamente estable.
2. El proceso es abordable en AP. Esto significa que el proceso de salud, en su estado actual, se puede atender con los recursos de fisioterapia de AP. También significa que es compatible con los objetivos del primer nivel: educación, automanejo del proceso por la persona, inclusión en la comunidad y retorno a las actividades diarias con la mayor normalidad posible.
3. Existe un informe clínico mínimo con el diagnóstico, las precauciones, los objetivos funcionales y la medicación relevante.
4. El informe define un criterio de reevaluación o de retorno.

Este circuito no es una vía para trasladar a AP la demora de rehabilitación hospitalaria. Ambos niveles son distintos, y su relación se regula solo mediante un circuito de continuidad con criterios de entrada y retorno. El retorno a atención hospitalaria se produce solo si aparecen criterios de alarma, fracaso terapéutico o complejidad.

El análisis gallego de 2019 advertía de un efecto adverso del circuito inverso [8]. Cuando la persona con dolor persistente pasa por atención hospitalaria solo para iniciar un programa de fisioterapia, aumentan la espera y el gasto [8]. Este documento comparte esa advertencia. Los programas del anexo A se inician en AP, y la atención hospitalaria deriva a ellos cuando el proceso está estable.

6.6. Circuito 5. Retorno desde rehabilitación hospitalaria

Rehabilitación hospitalaria finaliza su fase de tratamiento y emite un informe de alta con objetivos de continuidad. Fisioterapia de AP continúa el ejercicio terapéutico, el autocuidado, la prevención de recaídas y la recuperación de la función. Este circuito recoge también a las personas en fase postquirúrgica que han completado la rehabilitación hospitalaria. El informe de alta de rehabilitación debe indicar los objetivos funcionales pendientes, las precauciones y el criterio de retorno, igual que el informe del circuito 4.

Tabla 6.2. Procesos y situaciones que entran solo por derivación

Id	Proceso o situación	Condición de entrada	Vías de entrada
P09	Riesgo de caídas y fragilidad [121, 131]	Cribado de fragilidad positivo realizado por enfermería familiar y comunitaria	Enfermería familiar y comunitaria, Medicina de familia y comunitaria
P10	EPOC en fase estable [124]	Diagnóstico médico de EPOC en fase estable	Medicina de familia y comunitaria, Enfermería familiar y comunitaria
P11	Pérdida funcional leve o moderada tras el alta hospitalaria	Situación clínica estable, informe clínico mínimo y criterio de retorno definidos	Medicina de atención hospitalaria
P12	Proceso musculoesquelético leve o moderado que no requiere rehabilitación hospitalaria	Situación clínica estable, informe clínico mínimo y criterio de retorno definidos	Medicina de atención hospitalaria
P13	Seguimiento funcional comunitario de la fragilidad o del riesgo de caídas	Situación clínica estable, informe clínico mínimo y criterio de retorno definidos	Medicina de atención hospitalaria
P14	Continuidad tras la fase de rehabilitación hospitalaria	Informe de alta de rehabilitación con objetivos de continuidad	Retorno desde rehabilitación hospitalaria
P15	Dependencia, inmovilidad o barreras funcionales en el domicilio	Valoración previa de necesidades en el domicilio	Trabajo social sanitario, Enfermería familiar y comunitaria, Medicina de familia y comunitaria
P16	Embarazo, posparto o disfunción de suelo pélvico de baja complejidad	Proceso incluido en la cartera autonómica	Matrona
P17	Proceso pediátrico incluido en la cartera autonómica	Oferta pediátrica definida en la cartera autonómica	Pediatría

Fuente: anexo C.

6.7. Coordinación con otras unidades de atención específica

La fisioterapia de AP comparte centro con otras unidades de atención específica. La instrucción madrileña las regula en el mismo documento y muestra tres puntos de contacto con la fisioterapia [9].

- **Trabajo social sanitario.** Los fisioterapeutas figuran entre los profesionales del centro que pueden captar una demanda para trabajo social [9]. El plan social anual de las personas con fragilidad o deterioro funcional incluye la valoración de la persona cuidadora y la coordinación sociosanitaria [9]. Este contacto sostiene el circuito 3 y la derivación desde trabajo social sanitario de la tabla 6.1.
- **Matronas.** Las matronas atienden a demanda las alteraciones del compartimento abdominopélvico, con valoración del suelo pélvico y entrenamiento de su musculatura [9]. La instrucción prevé la derivación hospitalaria si es precisa, pero no menciona a la fisioterapia de AP [9]. Este documento propone que la matrona pueda derivar a fisioterapia de AP los procesos de suelo pélvico de baja complejidad, como recoge la matriz del anexo C.
- **Medicina y enfermería de familia.** Ambas reciben a la persona cuando la instrucción la excluye de la cita directa con fisioterapia [9]. Esa salida coincide con las exclusiones de la tabla 8.2.

La instrucción señala también que el protocolo de valoración del compartimento abdominopélvico está pendiente de desarrollo en AP [9]. El grupo de trabajo puede aprovechar ese vacío para definir un protocolo común de matronas y fisioterapia.

6.8. Matriz de coherencia

El anexo C reúne en una sola tabla todos los procesos, las vías de entrada, las condiciones, las exclusiones y los circuitos alternativos. Las tablas de las secciones 5, 6 y 8 proceden de esa matriz. De esta forma, ningún proceso puede aparecer a la vez como incluido y como excluido.

7. Competencias solicitadas y marco legal

Esta sección declara qué nivel de autonomía pide este documento para el fisioterapeuta de AP y qué no pide. El lector no debe inferirlo del modelo inglés de la sección 4.1.

7.1. Competencias que ya ampara la Ley 44/2003

La Ley 44/2003 ampara hoy la valoración, el diagnóstico fisioterapéutico, el plan de intervención, el alta fisioterapéutica y la derivación a otro profesional del equipo [1]. Estas competencias no requieren ningún cambio normativo.

La evidencia internacional respalda la capacidad diagnóstica que estas competencias presuponen. Una revisión con metaanálisis encontró un kappa de 0,76 para la concordancia diagnóstica entre el fisioterapeuta de práctica avanzada y el médico, con certeza moderada [106]. Otra revisión situó la concordancia diagnóstica con el cirujano ortopédico entre el 65 % y el 100 % [105]. En España, la instrucción madrileña ya encarga al fisioterapeuta la valoración clínica de tres procesos, con pruebas de exploración y cuestionarios definidos [9].

7.2. Competencias que requieren desarrollo autonómico o protocolo

El acceso directo del ciudadano requiere un protocolo del servicio de salud. Galicia y Madrid ya lo han regulado [9, 77]. En Madrid, el instrumento es una instrucción de la Gerencia Asistencial de AP, con criterios de citación y de exclusión escritos para cada proceso [9]. La sección 2.5 analiza el rango de ese instrumento. La interconsulta no presencial con atención hospitalaria requiere también un protocolo de cada área sanitaria.

7.3. Ecografía como apoyo a la valoración

Este documento pide el reconocimiento del uso de la ecografía por el fisioterapeuta de AP como herramienta de apoyo a la valoración, la reevaluación y la decisión de derivación. El informe radiológico sigue siendo competencia del médico especialista. La ecografía no emplea radiaciones ionizantes, de modo que no está sujeta al Real Decreto 601/2019 [54].

La Resolución 1/2023 del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España considera la ecografía una herramienta inherente al proceso de atención en fisioterapia [10, 135]. Según esa resolución, la imagen no sustituye a la exploración física, sino que mejora la valoración y ayuda a decidir la derivación ante un signo de alarma [10]. La Gerencia Asistencial de AP de Madrid dispone ya de ecógrafos en los centros de salud [10]. Además, forma a sus fisioterapeutas en su manejo, según el documento de posición del colegio profesional de esa comunidad [10].

El documento fija tres requisitos para esta competencia: formación acreditada, un protocolo de uso y el registro de cada exploración en la historia clínica. El indicador de adecuación de la radiografía simple no se aplica a la ecografía, porque esta no se solicita a otro servicio. Su seguimiento se hace con la auditoría de registros que prevé la sección 11.3.

7.4. Solicitud de radiología simple

Este documento pide al Ministerio de Sanidad la habilitación expresa del fisioterapeuta de atención primaria como prescriptor de radiología simple musculoesquelética en los procesos protocolizados de acceso directo. La petición es de desarrollo normativo. Ninguna comunidad autónoma ha autorizado todavía esta capacidad, y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid reconoce que hace falta un acto de autorización expreso [10].

La petición se apoya en seis argumentos:

- **Prescriptor y profesional habilitado.** El Real Decreto 601/2019 abre la figura del prescriptor a otro profesional sanitario autorizado [54]. La responsabilidad clínica de la exposición corresponde al profesional sanitario habilitado, que en radiodiagnóstico es el radiólogo [54]. Este documento pide la condición de prescriptor y no la de profesional habilitado.
- **Precedente de la podología.** El mismo real decreto integra a la podología mediante una habilitación específica, según el análisis del colegio profesional madrileño [10]. La vía para la fisioterapia sería análoga [10].
- **Marco europeo.** La Directiva 2013/59/Euratom no reserva en exclusiva a los médicos la remisión a procedimientos radiológicos [55].
- **Planificación estatal.** La acción A.4.4 del Marco Estratégico pide incrementar la capacidad resolutoria de la fisioterapia mediante circuitos y protocolos [10, 46].
- **Circuito redundante.** El acceso directo sin capacidad de solicitud genera la derivación intermedia que pretendía evitar. En un esguince de tobillo con reglas de Ottawa positivas, la persona tiene que volver a otra consulta solo para que otro profesional firme la petición [10, 136]. La instrucción madrileña reconoce en el esguince de tobillo la utilidad de la radiología para descartar lesiones óseas, pero no habilita al fisioterapeuta para pedirla [9]. La doble consulta es, por tanto, una consecuencia prevista del circuito vigente.
- **Experiencia comparada.** En el Reino Unido, la normativa sobre exposiciones médicas reconoce al remitente no médico habilitado por su empleador [137]. La hoja de ruta de Health Education England incluye la solicitud de pruebas entre las capacidades del fisioterapeuta de primer contacto [81].

El alcance que se pide es limitado. Incluye solo la radiología simple musculoesquelética de los procesos protocolizados, con reglas de decisión validadas como las de Ottawa [136, 138]. No incluye la interpretación radiológica formal. La implantación exige formación acreditada en protección radiológica, un protocolo consensuado con radiodiagnóstico y medicina de familia, la trazabilidad de cada solicitud y una auditoría periódica. El indicador IR-12 del anexo B mide la adecuación de las solicitudes.

Mientras la habilitación no se apruebe, el circuito usa un protocolo compartido con medicina de familia para la radiografía simple. Así, el acceso directo funciona desde el primer día sin depender de la reforma.

7.5. Compatibilidad con la cartera común

El apartado 6 del anexo II del Real Decreto 1030/2006 exige «previa indicación médica» para la rehabilitación básica [43]. Este documento aborda el inciso por dos vías complementarias:

- **Para la fase de implantación.** La indicación mediante un protocolo aprobado por el servicio de salud cumple el requisito. Esta es la lectura que de hecho sostienen Galicia y Madrid con sus protocolos de acceso directo [9, 77].
- **Como petición al Ministerio de Sanidad.** El apartado 6 se actualiza por el procedimiento de los artículos 20 y 21 de la Ley 16/2003, para que la autorreferencia protocolizada quede recogida en la cartera común [45].

7.6. Lo que no se pide

Este documento no pide ninguna de las siguientes capacidades:

- La prescripción de medicamentos.
- La creación de especialidades de fisioterapia.
- La sustitución de la valoración médica en procesos con diagnóstico médico pendiente.
- La interpretación radiológica formal.
- La solicitud de pruebas de imagen avanzada o de mayor dosis.
- La derivación a atención hospitalaria sin pasar por medicina de familia, salvo la derivación urgente.

8. Criterios clínicos de acceso directo

Esta sección fija qué procesos admiten autorreferencia y qué situaciones la excluyen. Las dos tablas proceden de la matriz de coherencia del anexo C. Ninguna condición de acceso es una intervención: cada condición se puede comprobar antes de la cita o en la primera consulta.

8.1. Criterio transversal de seguridad clínica

En todos los procesos, el fisioterapeuta evalúa en la primera consulta la presencia de signos de alarma. La ausencia de signos de alarma no es una condición de acceso que pueda comprobar el personal administrativo. Es el resultado del cribado clínico que realiza el profesional sanitario, y su presencia activa la derivación a medicina de familia o a urgencias. El acceso directo se limita además a personas adultas.

8.2. Procesos con acceso directo

Tabla 8.1. Procesos que admiten autorreferencia

Id	Proceso	Condición de acceso	Vías de entrada
P01	Artralgias vertebrales mecánicas [139-141]	Sin déficit neurológico progresivo referido por la persona	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria
P02	Hombro doloroso no traumático [142, 143]	Sin traumatismo desencadenante	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria
P03	Artrosis leve o moderada de rodilla, cadera o mano [123]	Diagnóstico médico previo registrado en la historia clínica	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria
P04	Esguince de tobillo leve o moderado [9, 136, 138]	La persona puede cargar su peso y caminar tres o cuatro pasos, aunque sea con dificultad	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria
P05	Fascitis plantar [9, 39]	Sin traumatismo previo ni signos sistémicos referidos	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria
P06	Epicondialgia [9, 39, 144]	Sin traumatismo desencadenante	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria
P07	Recidiva de un proceso diagnosticado previamente por su médico de familia y comunitaria [19]	Diagnóstico previo registrado en la historia clínica	Autorreferencia
P08	Dolor persistente no complejo [122]	Diagnóstico médico previo, sin descompensación de la comorbilidad	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria

Fuente: anexo C. La condición del esguince de tobillo se basa en las reglas de Ottawa [136, 138].

La tabla agrupa la lumbalgia y la cervicalgia en un único proceso, las artralgias vertebrales mecánicas, porque comparten condición de acceso. La prevención de caídas y la EPOC en fase estable no figuran en la tabla. Ambas entran por derivación desde enfermería o desde medicina de familia, como indica la tabla 6.2. La epicondialgia se incorpora por el precedente de Madrid, que la incluye entre sus procesos de citación directa [9, 39].

Las condiciones de la tabla coinciden en lo esencial con la instrucción madrileña, aunque la formulan de otro modo [9]. En la epicondialgia y la fascitis plantar, ambas excluyen el antecedente traumático [9]. En el esguince de tobillo, la instrucción admite los grados I y II y remite a medicina de familia a quien no puede apoyar el pie [9]. La tabla 8.1 usa en su lugar la capacidad de cargar el peso y dar unos pasos, que procede de

las reglas de Ottawa [136]. Esa condición puede comprobarse antes de la cita. La instrucción remite además a medicina de familia la fascitis plantar con indicación de tratamiento ortopédico, un criterio que la primera consulta de fisioterapia puede detectar [9].

8.3. Situaciones excluidas del acceso directo

Tabla 8.2. Situaciones excluidas del acceso directo y circuito alternativo

Id	Situación excluida del acceso directo	Circuito alternativo
X01	Traumatismo grave	Medicina de familia o urgencias
X02	Déficit neurológico progresivo	Medicina de familia o urgencias
X03	Dolor no mecánico o con signos sistémicos	Medicina de familia
X04	Postquirúrgico de cualquier complejidad	Rehabilitación hospitalaria y retorno a AP por el circuito 5
X05	Menor de edad	Pediatría de atención primaria
X06	Patología laboral o por accidente de tráfico	Circuito que establezca la normativa aplicable
X07	Dependencia severa	Valoración multidisciplinar del equipo de AP por el circuito 3

Fuente: anexo C.

La exclusión del acceso directo no impide la atención en fisioterapia de AP. Por ejemplo, una persona en fase postquirúrgica puede llegar a AP por el circuito 5, tras la rehabilitación hospitalaria.

8.4. Herramientas de cribado

El fisioterapeuta usa herramientas con evidencia publicada:

- **Reglas de Ottawa de tobillo y pie.** Una revisión sistemática con 15.581 pacientes mostró una sensibilidad cercana al 100 % para excluir fracturas [136]. Su implantación redujo las radiografías de tobillo sin fracturas no detectadas [138].
- **Signos de alarma en el dolor lumbar.** Una revisión sistemática mostró que solo un subconjunto de los signos de alarma que recogen las guías tiene precisión diagnóstica demostrada [139]. El protocolo debe priorizar ese subconjunto, como la historia de cáncer para la sospecha de malignidad [139].
- **Estratificación del riesgo en el dolor lumbar.** La herramienta STarT Back permite ajustar la intensidad de la atención al pronóstico, con mejores resultados y menos costes que la práctica habitual [145]. Existe una versión española adaptada en atención primaria [146].
- **Función en la epicondialgia.** La instrucción madrileña pide el cuestionario PRTEE para medir el dolor y la función del codo [9]. Su versión española se validó con 150 pacientes [147]. Mostró una consistencia interna con un alfa de Cronbach de 0,96 y una fiabilidad con un coeficiente de correlación intraclase de 0,9 [147].
- **Momento de la exploración en el esguince de tobillo.** La guía neerlandesa actualizada recomienda una exploración física diferida, entre cuatro y cinco días después del traumatismo [148]. El protocolo puede usar esa pauta para programar la primera consulta.
- **Pruebas de provocación en la epicondialgia.** La instrucción madrileña describe las pruebas de Cozen, de Thomson y de la silla [9]. Este documento no ha localizado estudios de precisión diagnóstica de esas pruebas, de modo que las presenta como parte de la exploración y no como reglas de decisión.

La escala visual analógica o la escala numérica del dolor completan la valoración en todos los procesos, como pide la instrucción madrileña [9]. El indicador IR-1 del anexo B usa la escala numérica de 0 a 10.

8.5. Evidencia de efectividad en los procesos de acceso directo

La tabla 8.3 resume la evidencia que sostiene la inclusión de cada proceso en el acceso directo. La columna de identificador remite a la matriz del anexo C. La tabla cita revisiones sistemáticas, guías y ensayos verificados en PubMed.

Tabla 8.3. Evidencia de efectividad de la fisioterapia en los procesos que admiten autorreferencia

Id	Proceso	Evidencia principal	Lectura para el modelo
P01	Dolor lumbar y cervical mecánico	Las guías recomiendan como primera línea la educación para el automanejo, la vuelta a la actividad y el ejercicio [140]. El ejercicio reduce el dolor lumbar persistente con certeza moderada [125]. En el dolor cervical, las guías proponen educación estructurada con ejercicio o atención multimodal [141, 149]	La consulta de primer contacto aplica la primera línea sin esperar a una derivación
P02	Hombro doloroso sin traumatismo	El ejercicio supera a los controles sin ejercicio en el síndrome subacromial [142]. La descompresión quirúrgica no supera al ejercicio en ensayos con seguimientos de uno a diez años [150-153]. En las roturas no traumáticas del supraespinoso, la cirugía no mejora el resultado de la fisioterapia al año [154]	El ejercicio terapéutico es la primera opción, y la derivación quirúrgica se reserva para el fracaso del tratamiento
P03	Artrosis de rodilla, cadera o mano	El ejercicio terapéutico reduce el dolor en la artrosis de rodilla con certeza alta a corto plazo [123]	El programa grupal PG-03 aplica esta evidencia
P04	Esguince de tobillo	La guía neerlandesa recomienda programas de ejercicio supervisado frente a las modalidades pasivas, y reserva la cirugía para el fracaso del tratamiento con ejercicio [148]	La primera consulta combina las reglas de Ottawa con el plan de ejercicio
P05	Fascitis plantar	Una guía basada en una revisión de 51 ensayos propone como tratamiento nuclear el vendaje, los estiramientos y la educación individualizada, con ondas de choque y ortesis a medida como pasos posteriores [155]. La guía de la asociación estadounidense de fisioterapia actualizó sus recomendaciones en 2023 [156]	La primera consulta aplica el tratamiento nuclear y reserva los pasos posteriores para quien no mejora
P06	Epicondilalgia	La fisioterapia con movilización y ejercicio supera a la infiltración de corticoide después de la sexta semana, y a la espera en las primeras seis semanas [144]	La infiltración ofrece alivio precoz con alta tasa de recaída, de modo que la fisioterapia es la opción de medio plazo
P07	Recidiva de un proceso ya diagnosticado	El dolor lumbar recurre con frecuencia en los seguimientos de largo plazo [17, 19]	La autorreferencia evita una nueva consulta médica para un diagnóstico ya registrado

Id	Proceso	Evidencia principal	Lectura para el modelo
P08	Dolor persistente no complejo	La educación en neurociencia del dolor combinada con ejercicio grupal mejora el dolor y la función en AP española [122]. La educación aislada no mejora el dolor frente a la atención habitual [127]	El programa grupal PG-02 combina educación y ejercicio

Fuente: elaboración propia a partir de los estudios citados en cada fila, verificados en PubMed. Los nombres de los procesos se abrevian; el anexo C recoge el nombre completo.

En el hombro, este documento se apoya en los ensayos que comparan directamente ejercicio y cirugía, y en una revisión Cochrane que no respalda la descompresión subacromial [143]. La evidencia económica es menos favorable en las roturas masivas del manguito. En ellas, un análisis de coste-efectividad situó como opción preferente la prótesis invertida, y la fisioterapia solo lo fue en un análisis de sensibilidad [157].

9. Dotación calculada por demanda, por fases y con ajuste territorial

Esta sección calcula cuántos fisioterapeutas de AP necesita el SNS a partir de la demanda que atienden. Los ratios no se fijan de antemano: salen de un modelo con parámetros explícitos, cada uno con su fuente o con su rango de supuesto. El resultado se presenta como un intervalo y como una secuencia de fases con horizonte temporal.

Advertencia metodológica. Las estadísticas internacionales de densidad cuentan fisioterapeutas de todo el sistema, no de atención primaria, y no sirven para fijar una ratio de AP. El modelo de esta sección combina datos publicados con supuestos declarados. El resultado central depende sobre todo de pocos parámetros, que la tabla 9.3 identifica. Cada servicio de salud debe sustituir los supuestos por sus propios datos cuando disponga de ellos.

9.1. Punto de partida

El SNS contaba en 2024 con 2.418 fisioterapeutas de AP, según el informe monográfico de recursos humanos [57]. La dotación por comunidad autónoma variaba más de diez veces entre los extremos que recogió el editorial de 2022 (tabla 3.1). El punto de partida no es, por tanto, un valor único, sino una distribución muy desigual.

Los datos autonómicos de actividad pueden afinar ese punto de partida. La Comunidad de Madrid informó de que sus unidades de fisioterapia de AP atendieron a cerca de 159.000 personas en 2024 [39]. El SIAP permite completar ese dato con la plantilla de fisioterapeutas de AP de cada comunidad autónoma [61].

9.2. Modelo de demanda

El modelo estima la carga anual de trabajo de fisioterapia por cada 10.000 habitantes. La carga tiene tres componentes:

- **Consulta individual.** Es el producto de las personas que consultan en AP por un problema musculoesquelético (P), la fracción que accede a fisioterapia (F1) y las consultas por persona. Cada persona tiene una primera consulta, y una fracción (F2) necesita además V consultas de seguimiento. Cada consulta dura t horas.
- **Programas grupales y comunitarios.** Es la suma, para cada programa del anexo A, de las ediciones anuales por las horas de fisioterapia de cada edición. El programa de caídas y fragilidad crece en proporción a la población de 65 años o más.
- **Atención domiciliaria.** Multiplica la población de 65 años o más (S65) por la fracción que necesita fisioterapia en el domicilio (D). El resultado se multiplica por las visitas por persona (Vd) y por las horas de cada visita (td).

La capacidad de un fisioterapeuta a tiempo completo es su jornada anual (J) menos la fracción de tiempo protegido (Tp). La dotación necesaria es la carga total dividida por esa capacidad.

Tabla 9.1. Parámetros del modelo de demanda

Símbolo	Parámetro	Unidad	Bajo	Central	Alto	Tipo	Justificación
P	Personas adultas que consultan en atención primaria por un problema musculoesquelético al año	personas por 10.000 habitantes	1.500	2.000	2.500	Supuesto	Jordan y colaboradores registraron 591 personas por 10.000 que consultaron por la espalda, 324 por la rodilla y 556 por problemas de más de una región. El parámetro extiende esas cifras al conjunto de regiones. Debe sustituirse por el dato de la BDCAP cuando se extraiga [14]
F1	Fracción de esas personas que accede a fisioterapia de atención primaria por cualquier vía	proporción	0,25	0,35	0,50	Supuesto	No existe dato español publicado. El rango refleja un despliegue progresivo del acceso directo y de la derivación protocolizada
F2	Fracción de las personas valoradas que necesita tratamiento individual tras la primera consulta	proporción	0,30	0,40	0,50	Supuesto	En la evaluación de Downie y colaboradores, el 60,4 % de los contactos se resolvió solo con automanejo tras la primera consulta [37]
V	Consultas individuales de seguimiento por episodio tratado	consultas	3	4	6	Supuesto	No existe dato español publicado sobre consultas por episodio en fisioterapia de atención primaria
t	Duración media de cada consulta individual	horas	0,33	0,50	0,75	Supuesto	Las consultas de primer contacto del Reino Unido duran veinte minutos en la encuesta de Halls y colaboradores. El valor central incorpora el tiempo de registro y de coordinación [158]
S65	Proporción de población de 65 años o más	proporción	0,18	0,20	0,22	Supuesto	Valor redondeado del padrón continuo. El rango refleja la variación entre zonas básicas y se sustituye por el dato local en los ajustes territoriales [159]
D	Proporción de personas de 65 años o más que necesita fisioterapia domiciliaria al año	proporción	0,02	0,03	0,05	Supuesto	La prevalencia de fragilidad en población comunitaria europea es del 12 %. Solo una parte de esa población necesita atención en el domicilio [160]
Vd	Visitas domiciliarias por persona y año	visitas	4	6	8	Supuesto	Sin dato publicado. Se ajusta localmente
td	Duración media de cada visita domiciliaria, con desplazamiento	horas	1	1,25	1,50	Supuesto	Sin dato publicado. El desplazamiento aumenta en zonas rurales y dispersas
J	Jornada anual de un fisioterapeuta a tiempo completo	horas	1.642	1.600	1.519	Supuesto	Rango de la jornada ordinaria entre 35 y 37,5 horas semanales según el servicio de salud. El orden de bajo a alto sigue la necesidad: una jornada menor exige más dotación
Tp	Fracción de la jornada reservada como tiempo protegido no asistencial	proporción	0,15	0,20	0,25	Diseño	Tiempo para programas comunitarios no clínicos, docencia, investigación y coordinación, que la sección 5.1 exige proteger

Fuente: elaboración propia. Los parámetros de tipo supuesto no tienen un dato español publicado y se acompañan de su rango y de su justificación.

Tabla 9.2. Resultado del modelo en los tres escenarios

Componente, en horas anuales por 10.000 habitantes	Escenario bajo	Escenario central	Escenario alto
Consulta individual	235	910	3.750
Programas grupales y comunitarios	206	351	528
Atención domiciliaria	144	450	1.320
Carga total	585	1.711	5.598
Capacidad asistencial por fisioterapeuta, en horas	1.396	1.280	1.139
Fisioterapeutas por 10.000 habitantes	0,42	1,34	4,91
Habitantes por fisioterapeuta	23.871	7.480	2.035

Fuente: modelo de demanda de esta sección, ejecutado con los parámetros de la tabla 9.1 y las fichas del anexo A. El escenario bajo combina los valores bajos de necesidad con la mayor capacidad por profesional, y el escenario alto hace lo contrario.

El escenario central necesita 1 fisioterapeuta de AP por cada 7.480 habitantes (tabla 9.2). El intervalo entre los escenarios bajo y alto va de 1 por cada 23.871 a 1 por cada 2.035 habitantes (tabla 9.2). La amplitud del intervalo refleja la incertidumbre de los supuestos. Por eso el análisis de sensibilidad identifica los parámetros que más la explican.

Tabla 9.3. Análisis de sensibilidad univariante

Parámetro	Habitantes por fisioterapeuta con el valor bajo	Habitantes por fisioterapeuta con el valor alto	Amplitud
t. Duración media de cada consulta individual	9.131	5.909	3.222
F1. Fracción de esas personas que accede a fisioterapia de atención primaria por cualquier vía	8.820	6.092	2.728
P. Personas adultas que consultan en atención primaria por un problema musculoesquelético al año	8.627	6.602	2.025
D. Proporción de personas de 65 años o más que necesita fisioterapia domiciliaria al año	8.199	6.364	1.834
V. Consultas individuales de seguimiento por episodio tratado	8.146	6.428	1.718
Vd. Visitas domiciliarias por persona y año	8.199	6.877	1.321
PG. Ediciones de programas grupales y comunitarios (anexo A)	8.147	6.840	1.307
F2. Fracción de las personas valoradas que necesita tratamiento individual tras la primera consulta	8.146	6.914	1.232
Tp. Fracción de la jornada reservada como tiempo protegido no asistencial	7.947	7.012	935
td. Duración media de cada visita domiciliaria, con desplazamiento	7.895	7.106	789
J. Jornada anual de un fisioterapeuta a tiempo completo	7.676	7.101	575
S65. Proporción de población de 65 años o más	7.734	7.242	492

Fuente: modelo de demanda de esta sección. Cada fila cambia un parámetro a su valor bajo o alto y mantiene el resto en el valor central. Las filas se ordenan de mayor a menor amplitud.

Los tres parámetros con más influencia son la duración de cada consulta, la fracción que accede a fisioterapia y las personas que consultan por un problema musculoesquelético (tabla 9.3). Ninguno de los tres tiene hoy un dato español publicado. Por eso la primera tarea del grupo de trabajo debe ser medirlos con los registros de actividad de las comunidades que ya tienen consulta de fisioterapia en AP. La instrucción

madrileña facilita esa medición, porque asocia cada proceso de citación directa a sus códigos de la Clasificación Internacional de Atención Primaria [9]. Con esos códigos, un servicio de salud puede contar las personas que consultan por cada proceso y la fracción que llega a fisioterapia.

El número de consultas por persona tampoco tiene un valor fijo. Una revisión de ocho ensayos no encontró diferencias al año entre dos o menos visitas y tres o más en el dolor lumbar [115]. El modelo refleja esa incertidumbre con el rango del parámetro de consultas de seguimiento.

9.3. Escenarios como fases

Los tres escenarios del modelo se transforman en fases con un horizonte temporal. Las cifras de cada fase salen del modelo y no se fijan de antemano.

Tabla 9.4. Fases de dotación

Fase	Horizonte	Objetivo de dotación	Contenido asistencial
Fase 1. Implantación	Años primero y segundo	Ninguna comunidad autónoma por debajo del escenario bajo: 1 fisioterapeuta por cada 23.900 habitantes	Consulta propia en todas las zonas básicas, derivación desde medicina de familia y enfermería, y programas de caídas y de espalda
Fase 2. Consolidación	Años tercero a quinto	Escenario central: 1 fisioterapeuta por cada 7.500 habitantes	Acceso directo protocolizado, todos los programas del anexo A y atención domiciliaria
Fase 3. Necesidad especial	Desde el tercer año, en paralelo	Ajuste territorial con el modelo: hasta 1 fisioterapeuta por cada 4.400 habitantes en zonas rurales, envejecidas y con alta dependencia	Refuerzo de la atención domiciliaria y de los programas de fragilidad

Fuente: elaboración propia a partir de las tablas 9.2 y 9.5. Los horizontes son una propuesta de calendario. Las cifras de dotación se redondean a la centena.

El mínimo de la fase 1 se aplica a cada comunidad autónoma por separado y no es una media nacional. De este modo, la propuesta se apoya en un cálculo y no solo en la comparación con otros sistemas.

9.4. Ajustes territoriales

El modelo se aplica a cada zona básica con sus propios datos. La tabla 9.5 muestra el efecto de cambiar solo los factores que admite esta sección.

Tabla 9.5. Ejemplos de ajuste territorial con el modelo

Tipo de zona	Parámetros modificados sobre el escenario central	Fisioterapeutas por 10.000 habitantes	Habitantes por fisioterapeuta
Zona de referencia	ninguno	1,34	7.480
Zona envejecida	población de 65 años o más del 30 %	1,56	6.425
Zona rural dispersa	visita domiciliaria de 1,75 horas con desplazamiento	1,48	6.768
Zona rural dispersa y envejecida	población de 65 años o más del 30 %, visita domiciliaria de 1,75 horas con desplazamiento	1,77	5.658
Zona rural dispersa y envejecida con alta dependencia	población de 65 años o más del 30 %, visita domiciliaria de 1,75 horas con desplazamiento, necesidad domiciliaria del 5 %	2,26	4.426

Tipo de zona	Parámetros modificados sobre el escenario central	Fisioterapeutas por 10.000 habitantes	Habitantes por fisioterapeuta
Zona con alta carga de incapacidad temporal musculoesquelética	2.400 personas con consulta musculoesquelética por 10.000 habitantes	1,48	6.761
Centro docente o con programas comunitarios extensos	tiempo protegido del 25 %	1,43	7.012

Fuente: modelo de demanda de esta sección. Los valores modificados son ilustrativos y cada servicio de salud los sustituye por los datos de la zona.

El documento admite cuatro factores de ajuste:

- **Ruralidad y dispersión.** Alargan el tiempo de cada visita domiciliaria. La respuesta puede combinar tres palancas: el refuerzo de la plantilla, un fisioterapeuta itinerante de área y las herramientas de salud digital de la sección 5.6.
- **Envejecimiento y dependencia.** Aumentan la atención domiciliaria y la oferta del programa de caídas y fragilidad.
- **Carga de incapacidad temporal musculoesquelética.** Aumenta el número de personas que consultan por estos procesos.
- **Centros docentes o con programas comunitarios extensos.** Aumentan el tiempo protegido no asistencial.

La demora en rehabilitación hospitalaria no es un factor de ajuste de la dotación de AP. Ambos son niveles asistenciales distintos, y la demora hospitalaria no debe condicionar la actividad de AP. Esa demora solo aparece como indicador del circuito de continuidad asistencial (indicador IR-11 del anexo B).

9.5. Referencias externas de dotación

La Chartered Society of Physiotherapy pidió en 2022 aumentar la dotación de fisioterapeutas de primer contacto en Inglaterra hasta 1 por cada 10.000 habitantes [161]. Esa cifra es una reivindicación profesional y no una norma del NHS [161]. Se refiere además solo al perfil de primer contacto, de modo que no incluye la atención domiciliaria ni los programas grupales.

9.6. Retorno económico esperado

Este documento no calcula un ahorro para el SNS, porque no existe ninguna evaluación económica española del modelo que propone. Sin embargo, la literatura internacional permite anticipar en qué partidas puede aparecer el retorno y cómo debe medirse.

La primera partida son los costes indirectos. En el dolor lumbar, los costes indirectos supusieron el 88 % del coste total en los Países Bajos [25]. Una revisión de evaluaciones económicas concluyó que la atención del médico general por sí sola no parece la opción más coste-efectiva en el dolor lumbar [134]. Añadir consejo, educación y ejercicio a esa atención resultó más coste-efectivo que la atención médica habitual sola [134]. Otra revisión encontró que el ejercicio, la rehabilitación interdisciplinar, la manipulación vertebral y la terapia cognitivo-conductual suelen ser coste-efectivos en el dolor lumbar subagudo o persistente [162].

La segunda partida es el uso posterior de servicios. En el estudio de Fritz y colaboradores, la fisioterapia precoz se asoció a un coste médico 2.736 dólares menor por persona con dolor lumbar [32]. En el ensayo FRONTIER, el coste mediano para el NHS fue de 41,0 y 44,0 libras en los grupos de fisioterapia, frente a 105,5

libras en el grupo médico [89, 90]. En Suecia, la valoración inicial por fisioterapia resultó más coste-efectiva que la valoración inicial por el médico general [97].

La tercera partida es la elección del tratamiento. En el dolor cervical, un ensayo neerlandés en AP comparó terapia manual, fisioterapia basada en ejercicio y atención por el médico general [163]. El coste total de la terapia manual, 447 euros por persona, fue alrededor de un tercio del coste de las otras dos opciones, de 1.297 y 1.379 euros [163]. En cambio, la fisioterapia basada en ejercicio no fue más barata que la atención médica en ese ensayo [163]. Una revisión posterior advierte que el número de evaluaciones económicas en dolor cervical no permite conclusiones firmes [164].

Tabla 9.6. Evidencia económica internacional aplicable al modelo

Partida	Estudio	Resultado	Límite para el SNS
Costes indirectos	Lambeek y colaboradores [25]	Los costes indirectos suponen el 88 % del coste del dolor lumbar	Estudio de coste de la enfermedad, sin evaluar la fisioterapia
Atención médica frente a atención con ejercicio	Lin y colaboradores [134, 162]	Añadir educación y ejercicio es más coste-efectivo que la atención médica sola	Evaluaciones de sistemas con precios distintos
Momento del acceso	Fritz y colaboradores [32]	Coste médico menor con la fisioterapia en los primeros 14 días	Estudio observacional en aseguradoras de Estados Unidos
Primer contacto en AP	FRONTIER [89, 90]	Coste mediano para el NHS menor en los grupos de fisioterapia	Sistema público con estructura distinta de la española
Primera valoración en el centro de salud	Bornhöft y colaboradores [97]	Manejo más coste-efectivo con la valoración inicial por fisioterapia	Triaje dentro del centro, no acceso directo
Tratamiento del dolor cervical	Korthals-de Bos y colaboradores [163]	La terapia manual costó un tercio que la fisioterapia basada en ejercicio o la atención médica	Un solo ensayo, con evidencia global insuficiente [164]
Triaje en la interfaz hospitalaria	Trøstrup y colaboradores [105]	Ahorro del 27 % al 49 % en la valoración diagnóstica	Fuera del alcance de esta propuesta

Fuente: elaboración propia a partir de los resúmenes de PubMed de los estudios citados.

Por todo ello, el retorno económico debe medirse y no suponerse. Los indicadores IR-5, IR-6 e IR-7 del anexo B miden las tres partidas descritas: pruebas y derivaciones, incapacidad temporal y medicación. El diseño de evaluación de la sección 11.4 permite atribuir sus cambios al modelo.

10. Sistema de evaluación en formato EFQM

Esta sección define cómo se evalúa el modelo. Los indicadores se organizan según la estructura del modelo EFQM y cada uno tiene una ficha completa en el anexo B.

10.1. Marco

El modelo EFQM se estructura en tres bloques [165]. El bloque de Dirección agrupa el propósito, la visión, la estrategia, la cultura y el liderazgo [165]. El bloque de Ejecución agrupa la implicación de los grupos de interés, la creación de valor sostenible y la gestión del funcionamiento y la transformación [165]. El bloque de Resultados agrupa la percepción de los grupos de interés y el rendimiento estratégico y operativo [165].

Cada indicador se sitúa en uno de esos criterios. El sistema incluye los indicadores que exigen las decisiones de este documento, como la adecuación de la radiografía simple solicitada. Incluye también el inicio precoz en la incapacidad temporal (IE-10) y la adecuación de las derivaciones de medicina de familia a traumatología (IR-13).

10.2. Indicadores de Dirección

Tabla 10.1. Indicadores de Dirección

Id	Indicador	Criterio EFQM	Fuente de datos	Estándar propuesto
ID-1	Cartera autonómica de fisioterapia de atención primaria	1. Propósito, visión y estrategia	Normativa y documentos del servicio de salud	Cartera aprobada en todas las comunidades autónomas al cierre de la fase de implantación
ID-2	Protocolo de acceso directo	1. Propósito, visión y estrategia	Normativa y documentos del servicio de salud	Protocolo aprobado al cierre de la fase de consolidación
ID-3	Circuito de continuidad con atención hospitalaria	1. Propósito, visión y estrategia	Documentos de gestión de las áreas sanitarias	Circuito formalizado en todas las áreas sanitarias al cierre de la fase de consolidación
ID-4	Tiempo protegido	2. Cultura de la organización y liderazgo	Agenda electrónica	Igual o superior al valor de tiempo protegido del modelo de dotación

Fuente: anexo B.

10.3. Indicadores de Ejecución

Tabla 10.2. Indicadores de Ejecución

Id	Indicador	Criterio EFQM	Fuente de datos	Estándar propuesto
IE-1	Cobertura de personal	5. Gestionar el funcionamiento y la transformación	SIAP	100 % al cierre de la fase de implantación
IE-2	Infraestructura de consulta	5. Gestionar el funcionamiento y la transformación	Inventario de centros del servicio de salud	Línea basal en el primer año y estándar fijado por el grupo de trabajo del Consejo Interterritorial
IE-3	Densidad de fisioterapeutas de AP	5. Gestionar el funcionamiento y la transformación	SIAP	El que resulte del modelo de dotación de la sección 9 para la fase correspondiente
IE-4	Agenda e historia clínica propias	5. Gestionar el funcionamiento y la transformación	Sistemas de información del servicio de salud	100 % al cierre de la fase de implantación

Id	Indicador	Criterio EFQM	Fuente de datos	Estándar propuesto
IE-5	Tiempo hasta la primera valoración	4. Crear valor sostenible	Agenda electrónica	Línea basal en el primer año y estándar fijado por el grupo de trabajo del Consejo Interterritorial
IE-6	Distribución de la entrada por vía	3. Implicar a los grupos de interés	Historia clínica	Indicador descriptivo sin estándar
IE-7	Derivación tras la primera consulta	4. Crear valor sostenible	Historia clínica	Indicador de seguridad sin estándar fijo, con revisión de cualquier variación brusca
IE-8	Oferta de programas grupales	4. Crear valor sostenible	Agenda electrónica	Las ediciones del escenario central del anexo A
IE-9	Atención domiciliaria	4. Crear valor sostenible	Historia clínica	Línea basal en el primer año
IE-10	Inicio precoz en la incapacidad temporal	4. Crear valor sostenible	Historia clínica de AP con el registro de la incapacidad temporal	Línea basal en el primer año y estándar fijado por el grupo de trabajo del Consejo Interterritorial

Fuente: anexo B.

Los indicadores IE-1 e IE-2 miden cosas distintas y no deben leerse como una duplicación. IE-1 mide la cobertura de personal: el porcentaje de zonas básicas con un fisioterapeuta asignado presencialmente. IE-2 mide la infraestructura: el porcentaje de centros de salud con un espacio físico propio para la consulta.

El indicador IE-7 no mide rechazos. Una persona derivada a otro profesional tras la primera consulta no ha sido rechazada, sino atendida y cribada.

El indicador IE-6 permite además auditar la gestión de la demanda. En Madrid, la aplicación desigual de la gestión compartida y la poca experiencia del personal administrativo limitaron su efecto, según el documento de trabajo madrileño [50]. La distribución de las entradas por vía y la revisión de los motivos registrados muestran si la autorreferencia funciona como se diseñó.

El indicador IE-10 mide cuánto tarda la fisioterapia de AP en llegar a las personas en incapacidad temporal. Su umbral de 60 días procede de la implicación práctica que proponen Busch y colaboradores tras evaluar la rehabilitación multimodal en Suecia [28]. Ese estudio no demostró por sí solo que el inicio precoz reduzca la baja, de modo que el indicador mide un proceso y no promete un resultado (sección 1.3).

10.4. Indicadores de Resultados

Tabla 10.3. Indicadores de Resultados

Id	Indicador	Criterio EFQM	Fuente de datos	Estándar propuesto
IR-1	Cambio en la intensidad del dolor	7. Rendimiento estratégico y operativo	Historia clínica	Línea basal en el primer año
IR-2	Cambio en la función	7. Rendimiento estratégico y operativo	Historia clínica	Línea basal en el primer año
IR-3	Altas por consecución de objetivos	7. Rendimiento estratégico y operativo	Historia clínica	Línea basal en el primer año
IR-4	Reconsulta por el mismo proceso	7. Rendimiento estratégico y operativo	Historia clínica	Línea basal en el primer año, con la referencia externa del anexo B
IR-5	Derivación posterior a pruebas o a atención hospitalaria	7. Rendimiento estratégico y operativo	Historia clínica	Línea basal en el primer año
IR-6	Duración de la incapacidad temporal	7. Rendimiento estratégico y operativo	Historia clínica e inspección médica	Línea basal en el primer año
IR-7	Uso de analgésicos y antiinflamatorios	7. Rendimiento estratégico y operativo	Receta electrónica e historia clínica	Línea basal en el primer año
IR-8	Satisfacción de las personas atendidas	6. Percepción de los grupos de interés	Encuesta común del servicio de salud	Línea basal en el primer año

Id	Indicador	Criterio EFQM	Fuente de datos	Estándar propuesto
IR-9	Equidad territorial	7. Rendimiento estratégico y operativo	SIAP y agenda electrónica	Reducción de la diferencia en cada fase
IR-10	Consultas de medicina de familia por procesos musculoesqueléticos	7. Rendimiento estratégico y operativo	BDCAP	Indicador de tendencia sin estándar, porque el efecto esperado no está garantizado
IR-11	Demora en rehabilitación hospitalaria	7. Rendimiento estratégico y operativo	Sistema de información de listas de espera	Indicador de seguimiento sin estándar
IR-12	Adecuación de la radiografía simple solicitada	7. Rendimiento estratégico y operativo	Auditoría de historia clínica	Estándar fijado en el protocolo consensuado con radiodiagnóstico
IR-13	Adecuación de las derivaciones de medicina de familia a traumatología	7. Rendimiento estratégico y operativo	Historia clínica compartida de AP y de atención hospitalaria	Línea basal en el primer año, con la referencia internacional de la sección 4.4

Fuente: anexo B.

La mayoría de los estándares de resultados se fijan tras un año de línea basal, porque no existe un dato español previo. Para la reconsulta existe una referencia externa: el 78,5 % de las personas atendidas por fisioterapia de primer contacto en el Reino Unido no volvió a consultar en doce semanas [38]. El indicador IR-10 no tiene estándar, porque la evidencia sobre la reducción de consultas médicas es heterogénea (sección 4.4). El indicador IR-11 mide la demora en rehabilitación hospitalaria solo como resultado del circuito de continuidad, no como criterio de dotación.

El indicador IR-13 mide la adecuación de las derivaciones de medicina de familia a traumatología que siguen a una valoración de fisioterapia de AP. Su referencia externa procede del triaje musculoesquelético: una revisión encontró tasas de conversión quirúrgica del 55 % al 91 % con triaje por fisioterapia, frente al 22 % al 38 % sin él [104]. El modelo de este documento no incluye ese triaje, de modo que la referencia solo orienta el estándar. En España, un estudio de 6.225 solicitudes de consulta de AP con traumatología ofrece un punto de comparación sobre la calidad de las derivaciones actuales [36].

Los indicadores de resultados miden también el retorno económico descrito en la sección 9.6. IR-5 recoge las pruebas y las derivaciones, IR-6 la incapacidad temporal e IR-7 la medicación. Ninguno de los tres tiene hoy un estándar español.

10.5. Ficha de indicador

Cada ficha del anexo B contiene diez campos: nombre, bloque y criterio EFQM, definición, fórmula, numerador, denominador, fuente de datos, periodicidad, estándar propuesto y responsable del registro. El instrumento de función del indicador IR-2 debe elegirlo el grupo de trabajo entre los validados en castellano. Los trabajos españoles sobre conjuntos básicos de la clasificación internacional del funcionamiento en fisioterapia de AP son una base para esa elección [166, 167].

11. Plan de implantación y gestión de riesgos

Esta sección ordena el despliegue en el tiempo e identifica los riesgos principales con su mitigación.

11.1. Fases e hitos

El despliegue sigue las fases de la tabla 9.4. La fase de implantación asegura la consulta propia en todas las zonas básicas y la derivación desde medicina de familia y enfermería. La fase de consolidación abre el acceso directo protocolizado y completa los programas del anexo A. La fase de necesidad especial aplica el modelo a las zonas rurales, envejecidas o con alta dependencia.

Cada fase termina con un hito verificable mediante los indicadores del anexo B. La fase de implantación termina cuando IE-1 e IE-4 alcanzan su estándar. La fase de consolidación termina cuando ID-2 e ID-3 están aprobados en todas las comunidades autónomas.

11.2. Sistemas de información

El despliegue necesita cuatro cambios en los sistemas de información:

- La codificación de los procesos de la matriz del anexo C en la historia clínica.
- La agenda propia de fisioterapia con las vías de entrada como campo obligatorio.
- El registro de la escala numérica del dolor y del instrumento de función en la primera consulta y en el alta.
- La incorporación de los indicadores del anexo B al SIAP.

La codificación de los procesos puede partir de la experiencia madrileña. La instrucción de la Gerencia Asistencial de AP asocia cada proceso de citación directa a sus códigos de la Clasificación Internacional de Atención Primaria [9]. La tabla 11.1 recoge esos códigos como punto de partida para la lista común.

Tabla 11.1. Códigos de la Clasificación Internacional de Atención Primaria que usa la instrucción madrileña

Proceso de citación directa	Códigos	Denominaciones registradas
Epicondialgia	L93	Epicondilitis, codo de tenista, epitrocleitis y tendinitis del codo
Esguince de tobillo	L77 y L16	Esguince de tobillo, y signo, síntoma, inflamación, dolor o limitación del movimiento del tobillo
Fascitis plantar	L87 y L17	Fascitis, fascitis plantar y talalgia

Fuente: instrucción de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud [9].

La tabla muestra una dificultad práctica. Algunos códigos agrupan signos o síntomas de una región, y no un diagnóstico, como ocurre con el dolor de tobillo. La lista común debe distinguir los códigos que abren la autorreferencia de los que solo describen un síntoma. El grupo de trabajo debe completar además los códigos de los demás procesos de la matriz del anexo C.

11.3. Formación

La formación continuada cubre cuatro áreas: el cribado de signos de alarma, la ecografía como apoyo a la valoración, la gestión de grupos y, si se aprueba la habilitación de la sección 7.4, la protección radiológica.

La formación debe alcanzar también a otros perfiles del equipo. El personal de las unidades de atención al usuario necesita formación en el guion de citación y en los criterios de exclusión. En Madrid, su falta de experiencia limitó la gestión compartida de la demanda [50]. Medicina de familia y enfermería necesitan conocer los criterios de derivación y de retorno de los circuitos 2 y 3.

Para los fisioterapeutas, la formación incluye cuatro contenidos adicionales:

- Los protocolos de exploración de cada proceso, como los que describe la instrucción madrileña para la epicondialgia y el esguince de tobillo [9].
- Los instrumentos de medida validados en castellano, como el PRTEE [147] y la versión española de STarT Back [146].
- La codificación de los procesos con la Clasificación Internacional de Atención Primaria.
- El registro de cada exploración ecográfica en la historia clínica, que permite auditar su uso (sección 7.3).

La educación en neurociencia del dolor requiere una formación específica, porque su efecto depende de cómo se combine con el ejercicio (sección 5.4).

11.4. Gobernanza

Este documento propone un grupo de trabajo en la Comisión de Atención Primaria del Consejo Interterritorial [45]. El grupo tendría cuatro tareas:

- Aprobar la matriz común del anexo C.
- Fijar los estándares de los indicadores tras el primer año.
- Medir los parámetros del modelo de la sección 9.
- Impulsar la actualización del apartado 6 del anexo II del Real Decreto 1030/2006.
- Aprobar la lista común de códigos de la Clasificación Internacional de Atención Primaria de los procesos de la matriz.

La evaluación debe tener un diseño que permita atribuir los resultados al modelo. No existe ningún estudio español sobre el acceso directo. Por eso, el despliegue escalonado por áreas de la fase 2 debe aprovecharse para comparar áreas con y sin acceso directo en el mismo periodo. Otros sistemas públicos usan ya este diseño. En Ontario, un grupo de investigación diseñó un ensayo por conglomerados para comparar un modelo de AP liderado por fisioterapia con la atención habitual en el dolor lumbar [102]. Un diseño análogo por zonas básicas o por áreas permitiría al SNS obtener la primera evaluación española del acceso directo.

11.5. Riesgos y mitigación

Tabla 11.2. Riesgos del despliegue y medidas de mitigación

Riesgo	Mitigación	Indicador de seguimiento
Uso de la fisioterapia de AP como lista de espera de la rehabilitación hospitalaria	Circuito 4 con criterios de entrada y retorno, y exclusión de la demora hospitalaria como criterio de dotación	IE-6 e IR-11
Variabilidad entre comunidades autónomas	Matriz común, fichas comunes e indicadores en el SIAP	IR-9

Riesgo	Mitigación	Indicador de seguimiento
Falta de espacio físico en los centros	Priorizar la consulta propia en la fase de implantación	IE-2
Resistencia profesional al acceso directo	Protocolos consensuados con medicina de familia y enfermería, y sesiones clínicas compartidas	ID-2 e IE-7
Baja captación de la autorreferencia al inicio	Información a la ciudadanía y despliegue por fases	IE-6
Demanda superior a la capacidad	Ajuste de la dotación con el modelo y medición de los parámetros reales	IE-5 e IE-3
Retraso de la habilitación para solicitar radiografía simple	Protocolo compartido con medicina de familia mientras no se apruebe	IR-5
Aplicación desigual de la gestión de la demanda por falta de formación del personal administrativo	Guion de citación con lista cerrada de motivos, formación específica y auditoría de los motivos registrados	IE-6
Aumento de la demanda por la mayor accesibilidad del servicio	Criterios de acceso de la matriz, derivación a programas grupales y ajuste de la dotación con el modelo	IE-5 e IE-8
Codificación heterogénea de los procesos	Lista común de códigos aprobada por el grupo de trabajo	ID-2 e IE-6
Llegada tardía a las personas en incapacidad temporal	Prioridad de cita para las personas de baja por procesos de la matriz	IE-10

Fuente: elaboración propia a partir del diagnóstico de las secciones 3, 4 y 9.

La baja captación inicial de la autorreferencia está documentada: en el estudio STEMS-2 supuso el 10 % y el 6 % de las entradas en los dos brazos [112]. En los Países Bajos, la proporción pasó del 28 % en el primer año al 74,3 % en 2024 [91, 93].

El aumento de la demanda es un riesgo conocido desde los primeros estudios británicos. Una revisión económica de 1997 advirtió que la fisioterapia en AP parecía generar más demanda que los demás modelos de acceso [84]. En cambio, el primer año de acceso directo en los Países Bajos no aumentó el número total de pacientes atendidos [91]. El modelo de dotación de la sección 9 y los indicadores IE-5 e IE-8 permiten detectar ese efecto y corregirlo.

12. Propuesta de texto para el documento ministerial

Esta sección ofrece un texto que el Ministerio de Sanidad puede incorporar como acuerdo. Las cifras de dotación proceden del modelo de la sección 9.

Primero. Modelo organizativo. Se implanta en el Sistema Nacional de Salud un modelo homogéneo de fisioterapia de atención primaria. El fisioterapeuta se integra en el equipo de atención primaria de cada zona básica de salud. Dispone de consulta propia, agenda propia y registro en la historia clínica compartida. Su jornada incluye tiempo protegido para la actividad comunitaria, docente e investigadora. La actividad se organiza en tres niveles: consulta de primer contacto, intervención grupal e intervención comunitaria, y fisioterapia domiciliaria y de continuidad.

Segundo. Vías de acceso. El acceso a la fisioterapia de atención primaria se realiza por autorreferencia para los procesos protocolizados de la matriz común. También se accede por derivación desde medicina de familia y comunitaria, enfermería familiar y comunitaria, pediatría, matrona y trabajo social sanitario. La medicina de atención hospitalaria puede derivar cuando el objetivo es la continuidad funcional o el abordaje comunitario de un proceso estable. La autorreferencia funciona mediante un protocolo de gestión de la demanda con motivos parametrizados, codificados con la Clasificación Internacional de Atención Primaria, y el cribado clínico corresponde siempre al fisioterapeuta. El personal administrativo que aplica el protocolo recibe formación específica y dispone de un guion de citación común. El Consejo Interterritorial impulsa la actualización del apartado 6 del anexo II del Real Decreto 1030/2006 para recoger la autorreferencia protocolizada en la cartera común.

Tercero. Competencias. Se reconoce el uso de la ecografía por el fisioterapeuta de atención primaria como apoyo a la valoración, sin informe radiológico. Se reconoce igualmente su capacidad para valorar, diagnosticar desde la fisioterapia, dar el alta y derivar a otros profesionales del equipo, que ya ampara la Ley 44/2003. Se inicia el desarrollo normativo para habilitar al fisioterapeuta de atención primaria como prescriptor de radiología simple musculoesquelética en los procesos protocolizados. Mientras tanto, se aplica un protocolo compartido con medicina de familia.

Cuarto. Dotación. La dotación de fisioterapeutas de atención primaria se calcula con un modelo común de demanda. En la fase de implantación, ninguna comunidad autónoma queda por debajo de 1 fisioterapeuta por cada 23.900 habitantes (tabla 9.4). En la fase de consolidación, el estándar es de 1 fisioterapeuta por cada 7.500 habitantes (tabla 9.4). En zonas rurales, envejecidas o con alta dependencia, la dotación se ajusta con el mismo modelo hasta 1 fisioterapeuta por cada 4.400 habitantes (tabla 9.4).

Quinto. Evaluación. Los servicios de salud registran en el Sistema de Información de Atención Primaria los indicadores comunes de dirección, ejecución y resultados definidos en este documento. La evaluación mide la cobertura, la accesibilidad, los resultados funcionales y la satisfacción de las personas atendidas. Mide también las derivaciones evitadas, el tiempo de acceso de las personas en incapacidad temporal, la adecuación de las derivaciones de medicina de familia a traumatología y la equidad territorial. El retorno económico se mide con esos indicadores y no se supone de antemano.

Sexto. Gobernanza. Se crea un grupo de trabajo en la Comisión de Atención Primaria del Consejo Interterritorial. El grupo aprueba la matriz común de procesos y fija los estándares de los indicadores tras el primer año. También aprueba la lista común de códigos de los procesos, mide los parámetros del modelo de

dotación y coordina el despliegue por fases. El despliegue escalonado se diseña de modo que permita comparar zonas con y sin acceso directo en el mismo periodo.

Anexo A. Fichas de programas grupales y comunitarios

Este anexo contiene la ficha de cada programa grupal y de cada intervención comunitaria. Las fichas alimentan directamente el modelo de dotación de la sección 9. Las horas de fisioterapia por edición se calculan en dos pasos. Primero se multiplican las sesiones por su duración y por la fracción a cargo de fisioterapia. Después se suman las horas de preparación y evaluación. Los parámetros de diseño de estas fichas son una propuesta que cada servicio de salud puede adaptar.

Ficha PG-01. Prevención de caídas y fragilidad

Campo	Contenido
Tipo	Intervención grupal
Población diana	Personas de 65 años o más que viven en la comunidad
Criterios de inclusión	Cribado de fragilidad o de riesgo de caídas positivo realizado por enfermería familiar y comunitaria
Procesos de la matriz del anexo C	P09, P13
Liderazgo	Fisioterapia, con enfermería familiar y comunitaria en la captación y el seguimiento
Tamaño del grupo	10 a 12
Diseño	Doce semanas con dos sesiones semanales de ejercicio de equilibrio, funcional y de fuerza
Sesiones por edición	24
Duración de cada sesión, en horas	1,00
Fracción de la sesión a cargo de fisioterapia	1,00
Horas de preparación y evaluación por edición	4
Horas de fisioterapia por edición	28,0
Ediciones por 10.000 habitantes y año: bajo, central y alto	2, 4 y 6
Evidencia de referencia	[121]

Ficha PG-02. Dolor persistente: educación en neurociencia del dolor y ejercicio

Campo	Contenido
Tipo	Intervención grupal
Población diana	Personas adultas con dolor persistente no complejo
Criterios de inclusión	Diagnóstico médico previo, sin descompensación de la comorbilidad
Procesos de la matriz del anexo C	P08
Liderazgo	Fisioterapia, con medicina de familia en la selección de participantes
Tamaño del grupo	10 a 15
Diseño	Seis sesiones de educación, con diez horas en total, y dieciocho sesiones de ejercicio de una hora, según el ensayo de atención primaria de Castilla y León
Sesiones por edición	24
Duración de cada sesión, en horas	1,17
Fracción de la sesión a cargo de fisioterapia	1,00
Horas de preparación y evaluación por edición	4
Horas de fisioterapia por edición	32,1

Campo	Contenido
Ediciones por 10.000 habitantes y año: bajo, central y alto	2, 3 y 4
Evidencia de referencia	[122]

Ficha PG-03. Artrosis de rodilla y cadera

Campo	Contenido
Tipo	Intervención grupal
Población diana	Personas adultas con artrosis leve o moderada
Criterios de inclusión	Diagnóstico médico previo registrado en la historia clínica
Procesos de la matriz del anexo C	P03
Liderazgo	Fisioterapia
Tamaño del grupo	10 a 12
Diseño	Seis semanas con dos sesiones semanales de ejercicio terapéutico y educación
Sesiones por edición	12
Duración de cada sesión, en horas	1,00
Fracción de la sesión a cargo de fisioterapia	1,00
Horas de preparación y evaluación por edición	3
Horas de fisioterapia por edición	15,0
Ediciones por 10.000 habitantes y año: bajo, central y alto	2, 3 y 4
Evidencia de referencia	[123]

Ficha PG-04. EPOC en fase estable

Campo	Contenido
Tipo	Intervención grupal
Población diana	Personas adultas con EPOC en fase estable
Criterios de inclusión	Diagnóstico médico de EPOC en fase estable
Procesos de la matriz del anexo C	P10
Liderazgo	Compartido: fisioterapia en el ejercicio y enfermería familiar y comunitaria en la educación sobre autocuidado e inhaladores
Tamaño del grupo	8 a 10
Diseño	Ocho semanas con dos sesiones semanales de entrenamiento al ejercicio y educación
Sesiones por edición	16
Duración de cada sesión, en horas	1,00
Fracción de la sesión a cargo de fisioterapia	0,75
Horas de preparación y evaluación por edición	3
Horas de fisioterapia por edición	15,0
Ediciones por 10.000 habitantes y año: bajo, central y alto	1, 2 y 3
Evidencia de referencia	[124]

Ficha PG-05. Escuela de espalda

Campo	Contenido
Tipo	Intervención grupal

Campo	Contenido
Población diana	Personas adultas con artroalgias vertebrales mecánicas
Criterios de inclusión	Valoración previa en la consulta de fisioterapia de primer contacto
Procesos de la matriz del anexo C	P01
Liderazgo	Fisioterapia
Tamaño del grupo	10 a 12
Diseño	Cuatro semanas con dos sesiones semanales de ejercicio y educación
Sesiones por edición	8
Duración de cada sesión, en horas	1,00
Fracción de la sesión a cargo de fisioterapia	1,00
Horas de preparación y evaluación por edición	2
Horas de fisioterapia por edición	10,0
Ediciones por 10.000 habitantes y año: bajo, central y alto	3, 4 y 6
Evidencia de referencia	[125]

Ficha PC-01. Promoción de la actividad física con activos comunitarios

Campo	Contenido
Tipo	Intervención comunitaria
Población diana	Población general adulta de la zona básica de salud
Criterios de inclusión	Sin criterio clínico individual
Procesos de la matriz del anexo C	no aplica
Liderazgo	Equipo de atención primaria, con fisioterapia en el diseño y coordinación con salud pública y entidades locales
Tamaño del grupo	no aplica
Diseño	Diseño, coordinación con activos comunitarios y evaluación anual
Sesiones por edición	4
Duración de cada sesión, en horas	2,50
Fracción de la sesión a cargo de fisioterapia	1,00
Horas de preparación y evaluación por edición	0
Horas de fisioterapia por edición	10,0
Ediciones por 10.000 habitantes y año: bajo, central y alto	1, 1 y 2
Evidencia de referencia	[52]

Ficha PC-02. Salud escolar: ergonomía y actividad física

Campo	Contenido
Tipo	Intervención comunitaria
Población diana	Alumnado y profesorado de los centros educativos de la zona básica de salud
Criterios de inclusión	Sin criterio clínico individual
Procesos de la matriz del anexo C	no aplica
Liderazgo	Fisioterapia y enfermería familiar y comunitaria, con los centros educativos
Tamaño del grupo	no aplica

Campo	Contenido
Diseño	Talleres en el centro educativo
Sesiones por edición	3
Duración de cada sesión, en horas	2,00
Fracción de la sesión a cargo de fisioterapia	1,00
Horas de preparación y evaluación por edición	0
Horas de fisioterapia por edición	6,0
Ediciones por 10.000 habitantes y año: bajo, central y alto	1, 2 y 3
Evidencia de referencia	[52]

Ficha PC-03. Salud laboral comunitaria

Campo	Contenido
Tipo	Intervención comunitaria
Población diana	Colectivos locales con alta carga física en el trabajo
Criterios de inclusión	Sin criterio clínico individual
Procesos de la matriz del anexo C	no aplica
Liderazgo	Fisioterapia, en coordinación con los servicios de prevención cuando existan
Tamaño del grupo	no aplica
Diseño	Talleres de consejo básico sobre carga física
Sesiones por edición	3
Duración de cada sesión, en horas	2,00
Fracción de la sesión a cargo de fisioterapia	1,00
Horas de preparación y evaluación por edición	0
Horas de fisioterapia por edición	6,0
Ediciones por 10.000 habitantes y año: bajo, central y alto	0, 1 y 2
Evidencia de referencia	[52]

Anexo B. Fichas de indicadores

Este anexo contiene la ficha de cada indicador del sistema de evaluación de la sección 10. Las fichas se organizan por bloques del modelo EFQM: Dirección, Ejecución y Resultados. Los estándares que dependen de una línea basal se fijan tras el primer año de registro.

Ficha ID-1. Cartera autonómica de fisioterapia de atención primaria

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Dirección. Criterio 1. Propósito, visión y estrategia
Definición	Existencia de una cartera de servicios de fisioterapia de AP aprobada por el servicio de salud y ajustada a este modelo
Fórmula	Valor binario
Numerador	Cartera aprobada: sí o no
Denominador	No aplica
Fuente de datos	Normativa y documentos del servicio de salud
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Cartera aprobada en todas las comunidades autónomas al cierre de la fase de implantación
Responsable del registro	Dirección de atención primaria de cada servicio de salud

Ficha ID-2. Protocolo de acceso directo

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Dirección. Criterio 1. Propósito, visión y estrategia
Definición	Existencia de un protocolo aprobado de autorreferencia con motivos de consulta parametrizados y criterios de exclusión
Fórmula	Valor binario
Numerador	Protocolo aprobado: sí o no
Denominador	No aplica
Fuente de datos	Normativa y documentos del servicio de salud
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Protocolo aprobado al cierre de la fase de consolidación
Responsable del registro	Dirección de atención primaria de cada servicio de salud

Ficha ID-3. Circuito de continuidad con atención hospitalaria

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Dirección. Criterio 1. Propósito, visión y estrategia
Definición	Existencia de un circuito formalizado de derivación y retorno entre atención hospitalaria y fisioterapia de AP
Fórmula	Valor binario
Numerador	Circuito formalizado: sí o no
Denominador	No aplica
Fuente de datos	Documentos de gestión de las áreas sanitarias
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Circuito formalizado en todas las áreas sanitarias al cierre de la fase de consolidación
Responsable del registro	Gerencias de área

Ficha ID-4. Tiempo protegido

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Dirección. Criterio 2. Cultura de la organización y liderazgo
Definición	Porcentaje de la jornada de fisioterapia de AP reservado a actividad comunitaria no clínica, docencia, investigación y coordinación
Fórmula	$(\text{Horas protegidas en agenda} / \text{horas de jornada}) \times 100$
Numerador	Horas protegidas registradas en agenda
Denominador	Horas de jornada de fisioterapia de AP
Fuente de datos	Agenda electrónica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Igual o superior al valor de tiempo protegido del modelo de dotación
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IE-1. Cobertura de personal

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 5. Gestionar el funcionamiento y la transformación
Definición	Porcentaje de zonas básicas de salud con al menos un fisioterapeuta de AP asignado presencialmente en la zona
Fórmula	$(\text{Zonas básicas con fisioterapeuta asignado presencialmente} / \text{zonas básicas totales}) \times 100$
Numerador	Zonas básicas con fisioterapeuta asignado presencialmente
Denominador	Zonas básicas de salud de la comunidad autónoma
Fuente de datos	SIAP
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	100 % al cierre de la fase de implantación
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IE-2. Infraestructura de consulta

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 5. Gestionar el funcionamiento y la transformación
Definición	Porcentaje de centros de salud que cuentan con un espacio físico propio para la consulta de fisioterapia
Fórmula	$(\text{Centros de salud con espacio propio} / \text{centros de salud totales}) \times 100$
Numerador	Centros de salud con espacio físico propio de fisioterapia
Denominador	Centros de salud de la comunidad autónoma
Fuente de datos	Inventario de centros del servicio de salud
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año y estándar fijado por el grupo de trabajo del Consejo Interterritorial
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IE-3. Densidad de fisioterapeutas de AP

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 5. Gestionar el funcionamiento y la transformación
Definición	Fisioterapeutas de AP a tiempo completo equivalente por 10.000 habitantes
Fórmula	$(\text{Fisioterapeutas de AP equivalentes a tiempo completo} / \text{población}) \times 10.000$

Campo	Contenido
Numerador	Fisioterapeutas de AP equivalentes a tiempo completo
Denominador	Población con tarjeta sanitaria
Fuente de datos	SIAP
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	El que resulte del modelo de dotación de la sección 9 para la fase correspondiente
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IE-4. Agenda e historia clínica propias

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 5. Gestionar el funcionamiento y la transformación
Definición	Porcentaje de fisioterapeutas de AP con agenda propia y registro en la historia clínica compartida
Fórmula	$(\text{Fisioterapeutas con agenda propia y registro en historia compartida} / \text{fisioterapeutas de AP}) \times 100$
Numerador	Fisioterapeutas con agenda propia y registro en la historia clínica compartida
Denominador	Fisioterapeutas de AP
Fuente de datos	Sistemas de información del servicio de salud
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	100 % al cierre de la fase de implantación
Responsable del registro	Dirección de sistemas de información

Ficha IE-5. Tiempo hasta la primera valoración

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 4. Crear valor sostenible
Definición	Mediana de días entre la solicitud o la derivación y la primera consulta de fisioterapia de AP
Fórmula	Mediana de los días transcurridos
Numerador	Días entre solicitud y primera consulta de cada episodio
Denominador	Episodios iniciados en el periodo
Fuente de datos	Agenda electrónica
Periodicidad	Trimestral
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año y estándar fijado por el grupo de trabajo del Consejo Interterritorial
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IE-6. Distribución de la entrada por vía

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 3. Implicar a los grupos de interés
Definición	Porcentaje de episodios iniciados por cada vía de entrada
Fórmula	$(\text{Episodios iniciados por cada vía} / \text{episodios totales}) \times 100$
Numerador	Episodios iniciados por cada vía
Denominador	Episodios iniciados en el periodo
Fuente de datos	Historia clínica
Periodicidad	Semestral
Estándar propuesto	Indicador descriptivo sin estándar

Campo	Contenido
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IE-7. Derivación tras la primera consulta

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 4. Crear valor sostenible
Definición	Porcentaje de personas derivadas a otro profesional tras la primera consulta por signos de alarma o por complejidad
Fórmula	$(\text{Personas derivadas tras la primera consulta} / \text{personas con primera consulta}) \times 100$
Numerador	Personas derivadas tras la primera consulta, por motivo
Denominador	Personas con primera consulta en el periodo
Fuente de datos	Historia clínica
Periodicidad	Semestral
Estándar propuesto	Indicador de seguridad sin estándar fijo, con revisión de cualquier variación brusca
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IE-8. Oferta de programas grupales

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 4. Crear valor sostenible
Definición	Ediciones de programas grupales realizadas por 10.000 habitantes y año
Fórmula	$\text{Ediciones realizadas} / \text{población} \times 10.000$
Numerador	Ediciones realizadas de cada programa del anexo A
Denominador	Población con tarjeta sanitaria
Fuente de datos	Agenda electrónica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Las ediciones del escenario central del anexo A
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IE-9. Atención domiciliaria

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 4. Crear valor sostenible
Definición	Personas atendidas por fisioterapia de AP en el domicilio por 1.000 habitantes de 65 años o más
Fórmula	$\text{Personas atendidas en domicilio} / \text{población de 65 años o más} \times 1.000$
Numerador	Personas atendidas en domicilio
Denominador	Población de 65 años o más
Fuente de datos	Historia clínica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IE-10. Inicio precoz en la incapacidad temporal

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 4. Crear valor sostenible

Campo	Contenido
Definición	Porcentaje de personas en incapacidad temporal por un proceso de la matriz del anexo C que tienen su primera consulta de fisioterapia de AP en los primeros 60 días de baja
Fórmula	$(\text{Personas con primera consulta en los primeros 60 días de baja} / \text{personas en incapacidad temporal atendidas}) \times 100$
Numerador	Personas en incapacidad temporal con primera consulta de fisioterapia de AP en los primeros 60 días de baja
Denominador	Personas en incapacidad temporal por procesos de la matriz atendidas en fisioterapia de AP
Fuente de datos	Historia clínica de AP con el registro de la incapacidad temporal
Periodicidad	Semestral
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año y estándar fijado por el grupo de trabajo del Consejo Interterritorial
Responsable del registro	Dirección de atención primaria e inspección médica del servicio de salud

Ficha IR-1. Cambio en la intensidad del dolor

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Diferencia media en la escala numérica del dolor de 0 a 10 entre la primera consulta y el alta
Fórmula	Media de (valor inicial menos valor al alta)
Numerador	Suma de diferencias individuales
Denominador	Episodios con ambos registros
Fuente de datos	Historia clínica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año
Responsable del registro	Unidad de calidad del servicio de salud

Ficha IR-2. Cambio en la función

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Diferencia media en un instrumento de función validado en castellano, elegido por el grupo de trabajo, entre la primera consulta y el alta
Fórmula	Media de (valor al alta menos valor inicial)
Numerador	Suma de diferencias individuales
Denominador	Episodios con ambos registros
Fuente de datos	Historia clínica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año
Responsable del registro	Unidad de calidad del servicio de salud

Ficha IR-3. Altas por consecución de objetivos

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Porcentaje de altas en las que se registran como alcanzados los objetivos del plan de intervención
Fórmula	$(\text{Altas con objetivos alcanzados} / \text{altas totales}) \times 100$
Numerador	Altas con objetivos alcanzados

Campo	Contenido
Denominador	Altas del periodo
Fuente de datos	Historia clínica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año
Responsable del registro	Unidad de calidad del servicio de salud

Ficha IR-4. Reconsulta por el mismo proceso

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Porcentaje de personas que vuelven a consultar en AP por el mismo proceso en las doce semanas posteriores al alta
Fórmula	$(\text{Personas que reconsultan} / \text{personas dadas de alta}) \times 100$
Numerador	Personas que reconsultan en doce semanas
Denominador	Personas dadas de alta
Fuente de datos	Historia clínica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año, con la referencia externa del anexo B
Responsable del registro	Unidad de calidad del servicio de salud

Ficha IR-5. Derivación posterior a pruebas o a atención hospitalaria

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Porcentaje de episodios con solicitud de pruebas de imagen o derivación a atención hospitalaria en los seis meses posteriores
Fórmula	$(\text{Episodios con prueba o derivación} / \text{episodios cerrados}) \times 100$
Numerador	Episodios con prueba de imagen o derivación hospitalaria
Denominador	Episodios cerrados
Fuente de datos	Historia clínica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año
Responsable del registro	Unidad de calidad del servicio de salud

Ficha IR-6. Duración de la incapacidad temporal

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Mediana de días de incapacidad temporal en los procesos de la matriz del anexo C
Fórmula	Mediana de días por proceso
Numerador	Días de incapacidad temporal por episodio
Denominador	Episodios con incapacidad temporal
Fuente de datos	Historia clínica e inspección médica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año
Responsable del registro	Inspección médica del servicio de salud

Ficha IR-7. Uso de analgésicos y antiinflamatorios

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Porcentaje de episodios de procesos de la matriz con prescripción de analgésicos o antiinflamatorios en los tres meses posteriores al inicio
Fórmula	$(\text{Episodios con prescripción} / \text{episodios iniciados}) \times 100$
Numerador	Episodios con prescripción
Denominador	Episodios iniciados
Fuente de datos	Receta electrónica e historia clínica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año
Responsable del registro	Servicio de farmacia de atención primaria

Ficha IR-8. Satisfacción de las personas atendidas

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 6. Percepción de los grupos de interés
Definición	Puntuación media de satisfacción en una encuesta común tras el alta
Fórmula	Media de la puntuación
Numerador	Suma de puntuaciones
Denominador	Encuestas respondidas
Fuente de datos	Encuesta común del servicio de salud
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año
Responsable del registro	Unidad de calidad del servicio de salud

Ficha IR-9. Equidad territorial

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Diferencia entre zonas rurales y urbanas en cobertura de personal y en tiempo hasta la primera valoración
Fórmula	Diferencia de IE-1 y de IE-5 entre zonas rurales y urbanas
Numerador	Valores de IE-1 e IE-5 en zonas rurales
Denominador	Valores de IE-1 e IE-5 en zonas urbanas
Fuente de datos	SIAP y agenda electrónica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Reducción de la diferencia en cada fase
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IR-10. Consultas de medicina de familia por procesos musculoesqueléticos

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Consultas de medicina de familia con código del aparato locomotor por 1.000 habitantes y año
Fórmula	$\text{Consultas con código del capítulo L de la CIAP-2} / \text{población} \times 1.000$
Numerador	Consultas de medicina de familia con código del capítulo L

Campo	Contenido
Denominador	Población con tarjeta sanitaria
Fuente de datos	BDCAP
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Indicador de tendencia sin estándar, porque el efecto esperado no está garantizado
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IR-11. Demora en rehabilitación hospitalaria

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Indicador del circuito de continuidad asistencial, no del dimensionamiento de AP: mediana de días de espera para la primera consulta de rehabilitación hospitalaria en las áreas con circuito formalizado
Fórmula	Mediana de días
Numerador	Días de espera por paciente
Denominador	Pacientes con primera consulta de rehabilitación
Fuente de datos	Sistema de información de listas de espera
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Indicador de seguimiento sin estándar
Responsable del registro	Gerencias de área

Ficha IR-12. Adecuación de la radiografía simple solicitada

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Solo si se aprueba la habilitación de la sección 7.4: porcentaje de radiografías solicitadas por fisioterapia de AP que cumplen la regla de decisión del protocolo
Fórmula	$(\text{Solicitudes conformes} / \text{solicitudes totales}) \times 100$
Numerador	Solicitudes conformes con la regla de decisión
Denominador	Solicitudes de radiografía de fisioterapia de AP
Fuente de datos	Auditoría de historia clínica
Periodicidad	Semestral
Estándar propuesto	Estándar fijado en el protocolo consensuado con radiodiagnóstico
Responsable del registro	Unidad de calidad y servicio de radiodiagnóstico

Ficha IR-13. Adecuación de las derivaciones de medicina de familia a traumatología

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Porcentaje de personas derivadas a traumatología por medicina de familia tras una valoración de fisioterapia de AP que reciben indicación quirúrgica o de otra técnica hospitalaria
Fórmula	$(\text{Derivaciones con indicación quirúrgica o de técnica hospitalaria} / \text{derivaciones a traumatología tras valoración de fisioterapia de AP}) \times 100$
Numerador	Derivaciones a traumatología tras valoración de fisioterapia de AP que reciben indicación quirúrgica o de otra técnica hospitalaria
Denominador	Derivaciones a traumatología tras valoración de fisioterapia de AP
Fuente de datos	Historia clínica compartida de AP y de atención hospitalaria
Periodicidad	Anual

Campo	Contenido
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año, con la referencia internacional de la sección 4.4
Responsable del registro	Comisión de continuidad asistencial del área sanitaria

Anexo C. Matriz de coherencia de procesos, vías y condiciones

Este anexo es la única fuente de las tablas de procesos de las secciones 5, 6 y 8. Cada proceso o situación aparece una sola vez. La fila indica su tipo, su condición, sus vías de entrada, su nivel de atención comunitaria y su programa asociado. Si el proceso está excluido del acceso directo, indica además su circuito alternativo.

Se aplican tres reglas transversales a todas las filas:

- El cribado clínico de signos de alarma lo realiza el fisioterapeuta en la primera consulta. No es una condición de acceso.
- El acceso directo se limita a personas adultas.
- Una exclusión del acceso directo no impide la atención en fisioterapia de AP por otra vía.

Tabla C.1. Matriz de coherencia

Id	Tipo	Proceso o situación	Condición	Vías	Nivel	Programa	Circuito alternativo
P01	Acceso directo	Artralgias vertebrales mecánicas	Sin déficit neurológico o progresivo referido por la persona	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 1	PG-05	no aplica
P02	Acceso directo	Hombro doloroso no traumático	Sin traumatismo desencadenante	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 1	no aplica	no aplica
P03	Acceso directo	Artrosis leve o moderada de rodilla, cadera o mano	Diagnóstico o médico previo registrado en la historia clínica	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 1 y Nivel 2	PG-03	no aplica
P04	Acceso directo	Esguince de tobillo leve o moderado	La persona puede cargar su peso y caminar tres o cuatro pasos, aunque sea con dificultad	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 1	no aplica	no aplica
P05	Acceso directo	Fascitis plantar	Sin traumatismo previo ni signos sistémicos referidos	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 1	no aplica	no aplica
P06	Acceso directo	Epicondialgia	Sin traumatismo desencadenante	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 1	no aplica	no aplica

Id	Tipo	Proceso o situación	Condición	Vías	Nivel	Programa	Circuito alternativo
P07	Acceso directo	Recidiva de un proceso diagnosticado previamente por su médico de familia y comunitaria	Diagnóstico o previo registrado en la historia clínica	Autorreferencia	Nivel 1	no aplica	no aplica
P08	Acceso directo	Dolor persistente no complejo	Diagnóstico o médico previo, sin descompensación de la comorbilidad	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 1 y Nivel 2	PG-02	no aplica
P09	Solo derivación	Riesgo de caídas y fragilidad	Cribado de fragilidad positivo realizado por enfermería familiar y comunitaria	Enfermería familiar y comunitaria, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 2 y Nivel 3	PG-01	no aplica
P10	Solo derivación	EPOC en fase estable	Diagnóstico o médico de EPOC en fase estable	Medicina de familia y comunitaria, Enfermería familiar y comunitaria	Nivel 2	PG-04	no aplica
P11	Solo derivación	Pérdida funcional leve o moderada tras el alta hospitalaria	Situación clínica estable, informe clínico mínimo y criterio de retorno definidos	Medicina de atención hospitalaria	Nivel 3	no aplica	no aplica
P12	Solo derivación	Proceso musculoesquelético leve o moderado que no requiere rehabilitación hospitalaria	Situación clínica estable, informe clínico mínimo y criterio de retorno definidos	Medicina de atención hospitalaria	Nivel 1	no aplica	no aplica
P13	Solo derivación	Seguimiento funcional comunitario de la fragilidad o del riesgo de caídas	Situación clínica estable, informe clínico mínimo y criterio de retorno definidos	Medicina de atención hospitalaria	Nivel 2	PG-01	no aplica
P14	Solo derivación	Continuidad tras la fase de rehabilitación hospitalaria	Informe de alta de rehabilitación con objetivos de continuidad	Retorno desde rehabilitación hospitalaria	Nivel 1 y Nivel 2	no aplica	no aplica

Id	Tipo	Proceso o situación	Condición	Vías	Nivel	Programa	Circuito alternativo
P15	Solo derivación	Dependencia, inmovilidad o barreras funcionales en el domicilio	Valoración previa de necesidades en el domicilio	Trabajo social sanitario, Enfermería familiar y comunitaria, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 3	no aplica	no aplica
P16	Solo derivación	Embarazo, posparto o disfunción de suelo pélvico de baja complejidad	Proceso incluido en la cartera autonómica	Matrona	Nivel 1 y Nivel 2	no aplica	no aplica
P17	Solo derivación	Proceso pediátrico incluido en la cartera autonómica	Oferta pediátrica definida en la cartera autonómica	Pediatría	Nivel 1	no aplica	no aplica
X01	Excluido del acceso directo	Traumatismo grave	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Medicina de familia o urgencias
X02	Excluido del acceso directo	Déficit neurológico progresivo	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Medicina de familia o urgencias
X03	Excluido del acceso directo	Dolor no mecánico o con signos sistémicos	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Medicina de familia
X04	Excluido del acceso directo	Postquirúrgico de cualquier complejidad	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Rehabilitación hospitalaria y retorno a AP por el circuito 5
X05	Excluido del acceso directo	Menor de edad	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Pediatría de atención primaria
X06	Excluido del acceso directo	Patología laboral o por accidente de tráfico	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Circuito que establezca la normativa aplicable
X07	Excluido del acceso directo	Dependencia severa	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Valoración multidisciplinar del equipo de AP por el circuito 3

Fuente: elaboración propia. Las filas de tipo «Acceso directo» admiten también la derivación por las vías que se indican.

Anexo D. Glosario y terminología normalizada

Este anexo define los términos que el documento usa siempre con el mismo sentido. La segunda columna recoge los términos que el documento ha sustituido y que no deben usarse.

Tabla D.1. Glosario

Término adoptado	Sustituye a	Definición
Artralgias vertebrales mecánicas	Lumbalgia mecánica y cervicalgia mecánica	Dolor de la columna vertebral de origen mecánico, sin signos de alarma ni déficit neurológico progresivo
Autorreferencia o acceso directo del ciudadano	Autocita	Solicitud de cita con fisioterapia sin derivación previa de otro profesional, limitada a los procesos protocolizados
Cribado clínico	Cribado administrativo y triaje administrativo	Valoración que realiza el fisioterapeuta en la primera consulta para detectar signos de alarma y estratificar el proceso
Dolor persistente	Dolor crónico	Dolor que se mantiene más allá del tiempo habitual de recuperación. Se admite «dolor crónico» solo en nombres propios y citas literales
Gestión de la demanda con motivos parametrizados	Cribado administrativo-clínico	Protocolo por el que el personal administrativo asigna cita según una lista de motivos definida por los clínicos, sin valoración clínica
Interconsulta no presencial	Interconsulta virtual	Consulta entre profesionales sin presencia de la persona atendida. En Madrid se denomina e-consulta
Intervención comunitaria	Programa comunitario	Actuación sobre la población o sobre los activos comunitarios, sin un proceso clínico individual
Intervención grupal	Consulta grupal	Intervención clínica sobre un grupo de personas con un proceso definido
Medicina de familia y comunitaria	MFyC	Especialidad médica del equipo de atención primaria. La sigla solo se usa en tablas
Proceso abordable en AP	Objetivos funcionales abordables en AP	Proceso de salud que, en su estado actual, se puede atender con los recursos de fisioterapia de AP y es compatible con los objetivos del primer nivel: educación, automanejo, inclusión en la comunidad y retorno a las actividades diarias
Recidiva de un proceso previamente diagnosticado	Dolor musculoesquelético recurrente	Reaparición de un proceso que el médico de familia ya diagnosticó y registró
Sesión clínica compartida	Sesiones compartidas	Revisión conjunta de casos complejos entre medicina, enfermería y fisioterapia
Signos de alarma	Banderas rojas	Síntomas o signos que sugieren una patología grave y exigen derivación médica
Tasa de conversión quirúrgica	Rendimiento quirúrgico	Porcentaje de personas derivadas al cirujano que terminan con indicación de cirugía. Se admite «rendimiento quirúrgico» en las citas de estudios canadienses
Triage musculoesquelético	Cribado ortopédico	Valoración por un fisioterapeuta de práctica avanzada de personas ya derivadas a traumatología o a columna, para decidir si necesitan ver al cirujano. No forma parte de esta propuesta
Unidad de Atención al Usuario	Admisión	Unidad administrativa del centro de salud que asigna las citas. En la autorreferencia aplica la lista de motivos parametrizados

Término adoptado	Sustituye a	Definición
Unidades de atención específica	Unidades de apoyo	Unidades del centro de salud distintas de medicina y enfermería de familia, como fisioterapia, matronas, trabajo social sanitario y salud bucodental. Denominación de la instrucción madrileña
Atención hospitalaria	Atención especializada	Nivel asistencial hospitalario. Se conserva «atención especializada» solo en citas literales de normas

Fuente: elaboración propia.

Tabla D.2. Siglas

Sigla	Significado
AP	Atención primaria
BDCAP	Base de Datos Clínicos de Atención Primaria
CIAP-2	Clasificación Internacional de Atención Primaria, segunda edición
EFQM	European Foundation for Quality Management
EPOC	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
OMS	Organización Mundial de la Salud
PRTEE	Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation, cuestionario de dolor y función del codo
SERGAS	Servizo Galego de Saúde
SESCAM	Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
SIAP	Sistema de Información de Atención Primaria
SNS	Sistema Nacional de Salud

Fuente: elaboración propia.

Anexo E. Tabla de fuentes por cifra

Este anexo recoge cada cifra del cuerpo del documento con la fuente que la sostiene, el año del dato y su definición. Las cifras que produce el modelo de la sección 9 remiten a ese modelo.

Tabla E.1. Fuentes por cifra

Sección	Cifra	Qué mide	Fuente	Año del dato	Definición
1.2	51.813.798	Problemas del aparato locomotor registrados en la BDCAP	[11]	2023	Registros de problemas de salud del capítulo L de la CIAP-2, no consultas ni personas
1.2	30 %	Consultas de medicina general por problemas musculoesqueléticos según el documento de política inglés	[12]	2006	Cifra de política sanitaria, «hasta el 30 %», sin medición propia
1.2	17 %	Consultas de medicina general por problemas musculoesqueléticos	[15]	2017	Estimación citada en el ensayo piloto STEMS
1.2	545	Consultas revisadas en un centro urbano	[16]	2018	Consultas de medicina general de un centro
1.2	21,1 %	Proporción de consultas musculoesqueléticas en un centro urbano	[16]	2018	Consultas con presentación musculoesquelética sobre el total revisado
1.3	60.000	Trabajadores valorados por el INSS por patología osteomuscular	[24]	2019	Valoraciones de incapacidad laboral
1.3	31,6 %	Procesos de columna lumbar entre los valorados por patología osteomuscular	[24]	2019	Porcentaje sobre los procesos osteomusculares valorados
1.3	13,5 %	Procesos de hombro entre los valorados por patología osteomuscular	[24]	2019	Porcentaje sobre los procesos osteomusculares valorados
1.3	11,9 %	Procesos de rodilla entre los valorados por patología osteomuscular	[24]	2019	Porcentaje sobre los procesos osteomusculares valorados
1.5	8.417	Contactos en la evaluación de un servicio escocés de fisioterapia como alternativa al médico general	[37]	2015 a 2017	Contactos de pacientes en dos años de servicio
1.5	87,3 %	Contactos resueltos en atención primaria	[37]	2015 a 2017	Porcentaje de contactos manejados sin salir de atención primaria
1.5	60,4 %	Contactos resueltos solo con automanejo	[37]	2015 a 2017	Porcentaje de contactos que solo necesitaron automanejo
1.5 y 10.4	78,5 %	Personas sin reconsulta en doce semanas tras una cita de fisioterapia de primer contacto	[38]	Publicado en 2025	Porcentaje de personas que no volvieron a consultar en atención primaria en doce semanas
1.5	159.000	Personas atendidas por las unidades de fisioterapia de AP de Madrid	[39]	2024	Personas atendidas, cifra aproximada de la nota oficial
1.5	77 %	Consecución de objetivos en las unidades de fisioterapia de AP de Madrid	[10]	2024	Porcentaje aproximado de casos con objetivos alcanzados, según el documento de posición
1.5	93 %	Reducción del dolor en las unidades de fisioterapia de AP de Madrid	[10]	2024	Porcentaje aproximado de casos con reducción del dolor, según el documento de posición
3.1 y 9.1	2.418	Fisioterapeutas de atención primaria en el SNS	[57]	2024	Profesionales de fisioterapia de AP registrados en el informe monográfico
3.1	84,8 %	Fisioterapeutas del SNS que trabajan en hospitales	[57]	2024	Porcentaje sobre el total de fisioterapeutas del SNS
3.1	10 %	Fisioterapeutas del SNS que trabajan en atención primaria	[57]	2024	Porcentaje sobre el total de fisioterapeutas del SNS

Sección	Cifra	Qué mide	Fuente	Año del dato	Definición
3.1	13.694	Habitantes por fisioterapeuta de AP en Asturias	[58]	Anterior a 2022	Población por fisioterapeuta de AP según el SIAP
3.1	10.091	Habitantes por fisioterapeuta de AP en Cantabria	[58]	Anterior a 2022	Población por fisioterapeuta de AP según el SIAP
3.1	104.847	Habitantes por fisioterapeuta de AP en Cataluña	[58]	Anterior a 2022	Población por fisioterapeuta de AP según el SIAP
3.1	12.101	Habitantes por fisioterapeuta de AP en Extremadura	[58]	Anterior a 2022	Población por fisioterapeuta de AP según el SIAP
3.1	91.972	Habitantes por fisioterapeuta de AP en Navarra	[58]	Anterior a 2022	Población por fisioterapeuta de AP según el SIAP
3.3	24	Zonas básicas de salud del despliegue inicial en Canarias	[67]	2022	Zonas básicas con servicio de fisioterapia en la primera fase
4.1	40	Centros de la evaluación nacional de la fisioterapia de primer contacto en Inglaterra	[86]	Publicado en 2021	Centros participantes
4.1	240	Fisioterapeutas de primer contacto de la evaluación nacional	[86]	Publicado en 2021	Profesionales participantes
4.1	426	Adultos incluidos en el estudio FRONTIER	[89]	Publicado en 2024	Participantes
4.1	46	Consultas de medicina general del estudio FRONTIER	[89]	Publicado en 2024	Centros participantes
4.1	44,7 %	Personas con medicación tras la primera consulta en el grupo de medicina general	[89]	Publicado en 2024	Porcentaje del grupo
4.1	18,4 %	Personas con medicación tras la primera consulta en un grupo de fisioterapia	[89]	Publicado en 2024	Porcentaje del grupo
4.1	24,7 %	Personas con medicación tras la primera consulta en el otro grupo de fisioterapia	[89]	Publicado en 2024	Porcentaje del grupo
4.1	105,5	Coste mediano por paciente para el NHS en el grupo de medicina general	[89]	Publicado en 2024	Libras esterlinas por paciente
4.1	41,0	Coste mediano por paciente en un grupo de fisioterapia	[89]	Publicado en 2024	Libras esterlinas por paciente
4.1	44,0	Coste mediano por paciente en el otro grupo de fisioterapia	[89]	Publicado en 2024	Libras esterlinas por paciente
4.2 y 11.5	28 %	Pacientes que llegaron a fisioterapia por acceso directo en los Países Bajos	[91]	2006	Porcentaje de los pacientes atendidos en el primer año de acceso directo
4.2 y 11.5	74,3 %	Pacientes que acudieron a fisioterapia sin derivación en los Países Bajos	[93]	2024	Porcentaje de pacientes sin derivación
4.4	28	Artículos de la revisión sistemática de Gallotti y colaboradores	[110]	Publicado en 2023	Artículos incluidos
4.4	2.081	Pacientes del metaanálisis de Abuhl y colaboradores	[31]	Publicado en 2025	Pacientes de diez ensayos aleatorizados
4.4	0,55	Riesgo relativo de solicitud de imagen con primer contacto por fisioterapia	[31]	Publicado en 2025	Riesgo relativo combinado
4.4	0,29	Riesgo relativo de medicación con primer contacto por fisioterapia	[31]	Publicado en 2025	Riesgo relativo combinado
4.4 y 11.5	10 %	Autorreferencia real en uno de los brazos del estudio STEMS-2	[112]	2011 a 2017	Porcentaje de las entradas a fisioterapia
4.4 y 11.5	6 %	Autorreferencia real en el otro brazo del estudio STEMS-2	[112]	2011 a 2017	Porcentaje de las entradas a fisioterapia
4.4	21	Estudios de la revisión de Fischer y colaboradores	[113]	Publicado en 2026	Estudios incluidos

Sección	Cifra	Qué mide	Fuente	Año del dato	Definición
4.4	90.401	Pacientes de la revisión de Fischer y colaboradores	[113]	Publicado en 2026	Pacientes incluidos
4.4	10 %	Límite inferior de la reducción estimada de consultas de medicina general	[113]	Publicado en 2026	Reducción relativa estimada
4.4	30 %	Límite superior de la reducción estimada de consultas de medicina general	[113]	Publicado en 2026	Reducción relativa estimada
4.4	0,57	Riesgo relativo de prescripción con acceso directo	[114]	Publicado en 2026	Riesgo relativo combinado, certeza baja
4.5	611.000	Fisioterapeutas en la Unión Europea	[117]	2021	Fisioterapeutas en ejercicio, todos los ámbitos
4.5	136,7	Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en la Unión Europea	[117]	2021	En ejercicio, todos los ámbitos
4.5	234,4	Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en Alemania	[117]	2021	En ejercicio, todos los ámbitos
4.5	215,9	Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en Bélgica	[117]	2021	En ejercicio, todos los ámbitos
4.5	12,7	Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en Rumanía	[117]	2021	En ejercicio, todos los ámbitos
4.5	149	Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en la Unión Europea	[118]	2023	En ejercicio, todos los ámbitos
4.5	240	Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en Alemania	[118]	2023	En ejercicio, todos los ámbitos
4.5	228	Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en Bélgica	[118]	2023	En ejercicio, todos los ámbitos
4.5	188	Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en los Países Bajos	[118]	2023	En ejercicio, todos los ámbitos
4.5	3,6	Fisioterapeutas por 10.000 habitantes, media mundial	[119]	2024	Censo de las organizaciones miembro de World Physiotherapy
4.5	39 %	Organizaciones que declaran acceso directo pleno	[119]	2024	Porcentaje de organizaciones que respondieron al censo
4.5	58 %	Organizaciones que declararon acceso directo	[120]	Publicado en 2013	Porcentaje de las organizaciones que respondieron a la encuesta
8.4	15.581	Pacientes de la revisión sobre las reglas de Ottawa	[136]	Publicado en 2003	Pacientes de los estudios combinados
8.4	100 %	Sensibilidad de las reglas de Ottawa para excluir fracturas	[136]	Publicado en 2003	Sensibilidad cercana al 100 %
9.5	10.000	Habitantes por fisioterapeuta de primer contacto que pide la Chartered Society of Physiotherapy	[161]	2022	Reivindicación profesional para Inglaterra
1.2	54 %	Aumento de los años vividos con discapacidad por dolor lumbar	[17]	1990 a 2015	Aumento mundial entre 1990 y 2015
1.2	165	Estudios poblacionales incluidos en la revisión de prevalencia del dolor lumbar	[18]	Publicado en 2012	Estudios publicados entre 1980 y 2009
1.2	54	Países de los estudios incluidos en la revisión de prevalencia del dolor lumbar	[18]	Publicado en 2012	Países
1.2	11,9 %	Prevalencia puntual del dolor lumbar	[18]	Publicado en 2012	Media ajustada por variación metodológica
1.2	23,2 %	Prevalencia al mes del dolor lumbar	[18]	Publicado en 2012	Media ajustada por variación metodológica
1.2	73 %	Recurrencia del dolor lumbar en el seguimiento, límite inferior	[19]	Publicado en 2006	Personas con dolor lumbar al inicio que lo refieren en los seguimientos a 5, 10 o 28 años

Sección	Cifra	Qué mide	Fuente	Año del dato	Definición
1.2, 1.3 y 9.6	88 %	Recurrencia del dolor lumbar, límite superior, y peso de los costes indirectos en el coste del dolor lumbar en los Países Bajos	[19, 25]	Publicado en 2006 y en 2011	Dos cifras con el mismo valor: recurrencia a 28 años y costes indirectos entre 2002 y 2007
1.2	30 %	Prevalencia anual del dolor cervical	[20]	Publicado en 2015	Prevalencia anual, «superior al 30 %»
1.2	50 %	Personas con dolor cervical que mantienen algún grado de dolor o episodios frecuentes	[20]	Publicado en 2015	Proporción aproximada
1.2	60 %	Resultados satisfactorios del tratamiento conservador del síndrome subacromial en dos años	[21]	Publicado en 2017	Proporción de casos, según una revisión narrativa
1.2	19 %	Prevalencia del dolor persistente moderado o grave en la población adulta europea	[22]	Publicado en 2006	Encuesta en quince países europeos e Israel
1.2	21 %	Personas con dolor persistente que han utilizado fisioterapia	[22]	Publicado en 2006	Uso de fisioterapia entre las personas entrevistadas
1.2, 1.5, 4.3 y 4.4	2 %	Personas con dolor persistente atendidas por un especialista en dolor; reconsulta hospitalaria tras el alta del equipo galés; casos de columna quirúrgica en Saskatchewan	[22, 41, 101]	Publicado en 2006, 2016 y 2012	Tres cifras con el mismo valor en estudios distintos
1.2	40 %	Personas con dolor persistente que consideran inadecuado el manejo de su dolor	[22]	Publicado en 2006	Proporción de personas entrevistadas
1.3 y 4.2	4.300	Coste total del dolor lumbar en los Países Bajos en 2002	[25]	2002	Millones de euros
1.3 y 4.2	3.500	Coste total del dolor lumbar en los Países Bajos en 2007	[25]	2007	Millones de euros
1.3	12 %	Peso de los costes directos en el coste del dolor lumbar en los Países Bajos	[25]	2002 a 2007	Proporción del coste total
1.3	2.825	Personas de baja por dolor lumbar en la cohorte de seis países	[26]	Publicado en 2009	Participantes
1.3 y 4.4	22 %	Retorno sostenido al trabajo en la cohorte alemana; conversión quirúrgica de las derivaciones del médico general en Columbia Británica	[26, 100]	Publicado en 2009 y en 2013	Dos cifras con el mismo valor en estudios distintos
1.3	62 %	Retorno sostenido al trabajo en la cohorte neerlandesa	[26]	Publicado en 2009	Proporción a los dos años
1.3	43	Días de incapacidad temporal evitados al año con la rehabilitación multidisciplinar	[27]	Publicado en 2011	Diferencia media frente al tratamiento habitual, redondeada
1.3 y 10.3	60	Días de baja dentro de los cuales los autores proponen iniciar la rehabilitación multimodal	[28]	Publicado en 2018	Implicación práctica de los autores, no resultado medido
1.4	32.070	Personas con dolor lumbar incluidas en el estudio de Fritz y colaboradores	[32]	Publicado en 2012	Primera consulta por dolor lumbar en AP
1.4	7,0 %	Personas con dolor lumbar que recibieron fisioterapia en el estudio de Fritz y colaboradores	[32]	Publicado en 2012	Proporción de uso de fisioterapia
1.4 y 9.6	14	Días que definen la fisioterapia precoz en el estudio de Fritz y colaboradores	[32]	Publicado en 2012	Primeros días tras la consulta inicial
1.4 y 9.6	2.736	Diferencia de coste médico total del dolor lumbar con la fisioterapia precoz	[32]	Publicado en 2012	Dólares por persona

Sección	Cifra	Qué mide	Fuente	Año del dato	Definición
1.4	3.867	Casos incluidos en el estudio laboral de fisioterapia precoz	[35]	Publicado en 2000	Casos de salud laboral
1.4 y 10.4	6.225	Solicitudes de derivación de AP a traumatología analizadas en un área de Castilla y León	[36]	Primer semestre de 2019	Volantes de derivación
1.4 y 6.3	65,7 %	Solicitudes de derivación a traumatología justificadas por procesos degenerativos	[36]	Primer semestre de 2019	Proporción de solicitudes
1.4	36,5 %	Solicitudes de derivación a traumatología que describían alguna exploración física	[36]	Primer semestre de 2019	Proporción de solicitudes
1.4 y 6.3	11,2 %	Solicitudes de derivación a traumatología que mencionaban una fisioterapia previa	[36]	Primer semestre de 2019	Proporción de solicitudes
1.5 y 4.4	2.651	Personas atendidas por fisioterapeutas de práctica avanzada en una unidad de columna	[40]	2012 a 2014	Participantes
1.5 y 4.4	92 %	Casos resueltos de forma independiente por el fisioterapeuta de práctica avanzada en columna	[40]	2012 a 2014	Proporción de las derivaciones atendidas
1.5	8 %	Casos que necesitaron comentario o revisión quirúrgica en la unidad de columna	[40]	2012 a 2014	Proporción de las derivaciones atendidas
1.5 y 4.4	2.362	Altas revisadas del equipo galés liderado por fisioterapia	[41]	Diciembre de 2011 a noviembre de 2012	Altas
4.3	0,77	Concordancia entre fisioterapeuta y cirujano en las decisiones de manejo quirúrgico	[100]	Publicado en 2013	Kappa ponderado
4.3	92,5 %	Casos clasificados como columna mecánica en el programa de triaje de Saskatchewan	[101]	2003 a 2006	Proporción de participantes
4.3	80 %	Derivaciones al cirujano que resultaron candidatas a cirugía en Saskatchewan	[101]	2003 a 2006	Rendimiento quirúrgico del programa
4.4	81 %	Derivaciones al cirujano consideradas adecuadas en la unidad de columna	[40]	2012 a 2014	Adecuación de la derivación, no cirugía realizada
4.4 y 9.6	27,3 %	Ahorro atribuido al triaje ortopédico por el análisis gallego	[8]	2019	Cifra no trazable a un estudio indexado, que este documento no usa
4.5	1.153	Personas incluidas en la revisión sobre intensidad de la fisioterapia en el dolor lumbar	[115]	Publicado en 2020	Participantes de ocho ensayos
4.5	67,3 %	Personas que no conocían el acceso directo a fisioterapia en una encuesta de Florida	[116]	Publicado en 2001	Proporción de la muestra
4.5	73,4 %	Personas que acudirían directamente al fisioterapeuta en una encuesta de Florida	[116]	Publicado en 2001	Proporción de la muestra
5.3 y 7.1	0,76	Concordancia diagnóstica entre el fisioterapeuta de práctica avanzada y el médico	[106]	Publicado en 2023	Kappa combinado, certeza moderada
5.4	13	Ensayos incluidos en la revisión sobre educación en neurociencia del dolor	[126]	Publicado en 2016	Ensayos aleatorizados
5.4	70	Edad mínima de las personas prefrágiles del ensayo de prevención de la fragilidad	[131]	Publicado en 2017	Años

Sección	Cifra	Qué mide	Fuente	Año del dato	Definición
5.4	4,9 %	Progresión a fragilidad en el grupo de intervención	[131]	Publicado en 2017	Proporción a los doce meses
5.4	15,3 %	Progresión a fragilidad en el grupo control	[131]	Publicado en 2017	Proporción a los doce meses
5.4	149	Personas con dolor vertebral persistente en la cohorte de ejercicio grupal en AP	[129]	Publicado en 2023	Participantes
7.1	65 %	Concordancia diagnóstica mínima con el cirujano ortopédico en la revisión de Trøstrup	[105]	Publicado en 2020	Límite inferior del intervalo entre estudios
7.1	100 %	Concordancia diagnóstica máxima con el cirujano ortopédico en la revisión de Trøstrup	[105]	Publicado en 2020	Límite superior del intervalo entre estudios
8.4	150	Pacientes de la validación española del PRTEE	[147]	Publicado en 2020	Participantes
8.4	0,96	Alfa de Cronbach de la versión española del PRTEE	[147]	Publicado en 2020	Consistencia interna
8.4	0,9	Coefficiente de correlación intraclase de la versión española del PRTEE	[147]	Publicado en 2020	Fiabilidad
9.6	447	Coste total por persona de la terapia manual en el dolor cervical	[163]	Publicado en 2003	Euros
9.6	1.297	Coste total por persona de la fisioterapia basada en ejercicio en el dolor cervical	[163]	Publicado en 2003	Euros
9.6	1.379	Coste total por persona de la atención por el médico general en el dolor cervical	[163]	Publicado en 2003	Euros
10.4	55 %	Conversión quirúrgica mínima con triaje por fisioterapia	[104]	Publicado en 2020	Límite inferior del intervalo entre estudios
4.4 y 10.4	91 %	Conversión quirúrgica máxima con triaje por fisioterapia	[100, 104]	Publicado en 2013 y en 2020	Límite superior del intervalo y valor del estudio de Napier
10.4	38 %	Conversión quirúrgica máxima sin triaje por fisioterapia	[104]	Publicado en 2020	Límite superior del intervalo entre estudios
9.2	23.871	Habitantes por fisioterapeuta en el escenario bajo	Modelo de la sección 9	No aplica	Resultado del modelo de demanda con los parámetros de la tabla 9.1
9.2	7.480	Habitantes por fisioterapeuta en el escenario central	Modelo de la sección 9	No aplica	Resultado del modelo de demanda con los parámetros de la tabla 9.1
9.2	2.035	Habitantes por fisioterapeuta en el escenario alto	Modelo de la sección 9	No aplica	Resultado del modelo de demanda con los parámetros de la tabla 9.1
9.4	4.426	Habitantes por fisioterapeuta en la zona rural dispersa, envejecida y con alta dependencia	Modelo de la sección 9	No aplica	Resultado del modelo con el ajuste territorial de la tabla 9.5

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias del documento.

Anexo F. Metodología de selección y verificación de fuentes

Este anexo describe cómo se seleccionaron las fuentes del documento y cómo se comprobó cada tipo de fuente. Un documento dirigido al Ministerio de Sanidad debe permitir trazar cada dato hasta su origen.

F.1. Criterios

El documento solo admite fuentes primarias: normas publicadas en el Boletín Oficial del Estado o en los boletines autonómicos, documentos oficiales del organismo competente, bases de datos estadísticas oficiales y artículos revisados por pares. Una noticia de prensa solo se admite como fuente secundaria, identificada en el texto, cuando no existe documento oficial.

Cuando un documento de síntesis cita un estudio, este documento cita el estudio original. Esa regla se aplica también a los informes profesionales que se resumen en la sección 3.4.

F.2. Procedimiento de verificación

Cada tipo de fuente se comprobó de una forma distinta:

- **Artículos científicos.** El título, la autoría, la revista, el año y el resumen se contrastaron con el registro de PubMed. Cada cita incluye su identificador de PubMed y su DOI.
- **Normas, planes y estadísticas oficiales.** Se citan por su publicación oficial, con la dirección de consulta en la lista de referencias.
- **Documentos autonómicos.** Se citan por el documento del servicio de salud o de la consejería. Cuando solo existe una nota oficial o una noticia, el texto lo indica.
- **Documentos institucionales y profesionales no publicados.** Se consultaron completos y se identifican como tales en la lista de referencias.
- **Cifras.** Cada cifra del cuerpo figura en el anexo E con su fuente, el año del dato y su definición. Las cifras que produce el modelo de la sección 9 remiten a ese modelo.

F.3. Afirmaciones que no se usan por falta de fuente

Algunas afirmaciones frecuentes en el debate profesional no se usan en este documento, porque no se ha localizado una fuente que las sostenga.

Tabla F.1. Afirmaciones sin fuente localizable y su tratamiento

Afirmación	Resultado de la búsqueda	Tratamiento en este documento
Resolución del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 2007 con ratios de dotación	No encontrada	Las ratios se calculan con el modelo de la sección 9
Cálculo atribuido a la Chartered Society of Physiotherapy sobre la mitad de las consultas musculoesqueléticas	No encontrado	No se usa
Relación de países con autorreferencia normalizada atribuida a la región europea de World Physiotherapy	No encontrada	Cada país se sostiene con su propia fuente
Solicitud de radiografía simple por fisioterapeutas de AP como práctica vigente en Madrid	No encontrada como norma	Se presenta como petición de desarrollo normativo

Afirmación	Resultado de la búsqueda	Tratamiento en este documento
Acceso directo del ciudadano en Cataluña	No encontrado	Cataluña figura como modelo de integración en el equipo
Fuente oficial sobre el acceso directo en Nueva Zelanda	No encontrada	No se cita
Estudio español que evalúe el acceso directo en el SNS	No encontrado	Se declara la carencia y se propone evaluar el despliegue
Estudio sobre el coste del triaje ortopédico por fisioterapia citado en la literatura profesional con un ahorro del 27,3 %	No indexado en PubMed	No se cita

Fuente: búsqueda documental realizada para este documento.

Referencias

1. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. Boletín Oficial del Estado, BOE-A-2003-21340. Texto consolidado. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340>.
2. World Physiotherapy. Policy statement: Direct access and patient/client self-referral to physiotherapy. Londres: World Physiotherapy; 2023. Disponible en: <https://world.physio/sites/default/files/2024-01/PS-2023-Direct-access.pdf>.
3. World Physiotherapy. Policy statement: Description of physiotherapy. Londres: World Physiotherapy; 2023. Disponible en: <https://world.physio/sites/default/files/2024-01/PS-2023-Description.pdf>.
4. World Health Organization. Rehabilitation in health systems. Ginebra: WHO; 2017. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/254506>.
5. World Health Organization. Rehabilitation 2030: a call for action. Ginebra: WHO; 2017. Disponible en: <https://www.who.int/initiatives/rehabilitation-2030>.
6. Asamblea Mundial de la Salud. Resolución WHA76.6. Strengthening rehabilitation in health systems. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2023. Disponible en: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA76/A76_R6-en.pdf.
7. World Health Organization. Package of interventions for rehabilitation. Ginebra: WHO; 2023. Disponible en: <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/health-topics/rehabilitation/basic-pir-info-sheet.pdf>.
8. Pérez Mariño P, Bilbao Ogando G, Fraiz Barbeito M, López Míguens V, Paseiro Ares G, Díez Meleiro Ó, et al. Análisis de la efectividad clínica e impacto económico de una gestión racional de los recursos de fisioterapia en patología de alta prevalencia en Atención Primaria. [s. l.]: Sociedade Galega de Fisioterapeutas; febrero de 2019. Informe profesional no publicado en revista.
9. Gerencia Asistencial de Atención Primaria, Servicio Madrileño de Salud. Atención a la demanda. Atención a procesos de demanda en las consultas de las Unidades de Atención Específica de Atención Primaria. Versión 8. Madrid: Servicio Madrileño de Salud; julio de 2024. Documento interno del Servicio Madrileño de Salud.
10. Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, Grupo de Trabajo de Especialidades. Pertinencia de la solicitud de radiología simple por los fisioterapeutas de Atención Primaria en el marco de sus competencias. Documento de posición institucional. Madrid: CPFCM; junio de 2026. Documento institucional no publicado.
11. Ministerio de Sanidad. Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP). Problemas de salud, año 2023 [consulta interactiva]. Disponible en: <https://pestadistico.inteligenciadegestion.sanidad.gob.es/publicoSNS/C/base-de-datos-de-clinicos-de-atencion-primaria-bdcap/problemas-de-salud>.
12. Department of Health. The Musculoskeletal Services Framework. A joint responsibility: doing it differently. Londres: Department of Health; 2006. Disponible en: https://chiro.org/Graphics_Box_CONDITIONS/FULL/The_Musculoskeletal_Services_Framework.pdf.
13. NHS England. First contact physiotherapists [página web]. Disponible en: <https://www.england.nhs.uk/gp/expanding-our-workforce/first-contact-physiotherapists/>.
14. Jordan KP, Kadam UT, Hayward R, Porcheret M, Young C, Croft P. Annual consultation prevalence of regional musculoskeletal problems in primary care: an observational study. BMC Musculoskelet Disord. 2010;11:144. PMID: 20598124. doi:10.1186/1471-2474-11-144.
15. Bishop A, Ogollah RO, Jowett S, Kigozi J, Tooth S, Protheroe J, et al. STEMS pilot trial: a pilot cluster randomised controlled trial to investigate the addition of patient direct access to physiotherapy to usual GP-led primary care for adults with musculoskeletal pain. BMJ Open. 2017;7(3):e012987. PMID: 28286331. doi:10.1136/bmjopen-2016-012987.
16. Keavy R, Horton R, Al-Dadah O. The prevalence of musculoskeletal presentations in general practice: an epidemiological study. Fam Pract. 2023;40(1):68-74. PMID: 35747902. doi:10.1093/fampra/cmz055.

17. Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, Louw Q, Ferreira ML, Genevay S, et al. What low back pain is and why we need to pay attention. *Lancet*. 2018;391(10137):2356-67. PMID: 29573870. [doi:10.1016/S0140-6736\(18\)30480-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30480-X).
18. Hoy D, Bain C, Williams G, March L, Brooks P, Blyth F, et al. A systematic review of the global prevalence of low back pain. *Arthritis Rheum*. 2012;64(6):2028-37. PMID: 22231424. [doi:10.1002/art.34347](https://doi.org/10.1002/art.34347).
19. Kääriä S, Luukkonen R, Riihimäki H, Kirjonen J, Leino-Arjas P. Persistence of low back pain reporting among a cohort of employees in a metal corporation: a study with 5-, 10-, and 28-year follow-ups. *Pain*. 2006;120(1-2):131-7. PMID: 16360271. [doi:10.1016/j.pain.2005.10.020](https://doi.org/10.1016/j.pain.2005.10.020).
20. Cohen SP. Epidemiology, diagnosis, and treatment of neck pain. *Mayo Clin Proc*. 2015;90(2):284-99. PMID: 25659245. [doi:10.1016/j.mayocp.2014.09.008](https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2014.09.008).
21. Garving C, Jakob S, Bauer I, Nadjar R, Brunner UH. Impingement syndrome of the shoulder. *Dtsch Arztebl Int*. 2017;114(45):765-76. PMID: 29202926. [doi:10.3238/arztebl.2017.0765](https://doi.org/10.3238/arztebl.2017.0765).
22. Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. *Eur J Pain*. 2006;10(4):287-333. PMID: 16095934. [doi:10.1016/j.ejpain.2005.06.009](https://doi.org/10.1016/j.ejpain.2005.06.009).
23. Seguridad Social. Estadísticas de incapacidad temporal por contingencias comunes [página web]. Disponible en: <https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46/EST189>.
24. Regal-Ramos R. Epidemiología de la incapacidad laboral por patología osteomuscular en España: 60.000 trabajadores valorados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en 2019. *Med Segur Trab (Internet)*. 2022;68(269):209-220. [doi:10.4321/s0465-546x2022000400003](https://doi.org/10.4321/s0465-546x2022000400003).
25. Lambeek LC, van Tulder MW, Swinkels IC, Koppes LL, Anema JR, van Mechelen W. The trend in total cost of back pain in The Netherlands in the period 2002 to 2007. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2011;36(13):1050-8. PMID: 21150697. [doi:10.1097/BRS.0b013e3181e70488](https://doi.org/10.1097/BRS.0b013e3181e70488).
26. Anema JR, Schellart AJ, Cassidy JD, Loisel P, Veerman TJ, van der Beek AJ. Can cross country differences in return-to-work after chronic occupational back pain be explained? An exploratory analysis on disability policies in a six country cohort study. *J Occup Rehabil*. 2009;19(4):419-26. PMID: 19760488. [doi:10.1007/s10926-009-9202-3](https://doi.org/10.1007/s10926-009-9202-3).
27. Busch H, Bodin L, Bergström G, Jensen IB. Patterns of sickness absence a decade after pain-related multidisciplinary rehabilitation. *Pain*. 2011;152(8):1727-33. PMID: 21507573. [doi:10.1016/j.pain.2011.02.004](https://doi.org/10.1016/j.pain.2011.02.004).
28. Busch H, Björk Brämberg E, Hagberg J, Bodin L, Jensen I. The effects of multimodal rehabilitation on pain-related sickness absence: an observational study. *Disabil Rehabil*. 2018;40(14):1646-53. PMID: 28345360. [doi:10.1080/09638288.2017.1305456](https://doi.org/10.1080/09638288.2017.1305456).
29. Ojha HA, Snyder RS, Davenport TE. Direct access compared with referred physical therapy episodes of care: a systematic review. *Phys Ther*. 2014;94(1):14-30. PMID: 24029295. [doi:10.2522/ptj.20130096](https://doi.org/10.2522/ptj.20130096).
30. Frogner BK, Harwood K, Andriilla CHA, Schwartz M, Pines JM. Physical therapy as the first point of care to treat low back pain: an instrumental variables approach to estimate impact on opioid prescription, health care utilization, and costs. *Health Serv Res*. 2018;53(6):4629-4646. PMID: 29790166. [doi:10.1111/1475-6773.12984](https://doi.org/10.1111/1475-6773.12984).
31. Abuhl B, Ehrmantraut D, Wolden M. First-contact physical therapy compared to usual primary care for musculoskeletal disorders: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Phys Ther*. 2025;105(8):pzaf080. PMID: 40511847. [doi:10.1093/ptj/pzaf080](https://doi.org/10.1093/ptj/pzaf080).
32. Fritz JM, Childs JD, Wainner RS, Flynn TW. Primary care referral of patients with low back pain to physical therapy: impact on future health care utilization and costs. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2012;37(25):2114-21. PMID: 22614792. [doi:10.1097/BRS.0b013e31825d32f5](https://doi.org/10.1097/BRS.0b013e31825d32f5).
33. Nordeman L, Nilsson B, Möller M, Gunnarsson R. Early access to physical therapy treatment for subacute low back pain in primary health care: a prospective randomized clinical trial. *Clin J Pain*. 2006;22(6):505-11. PMID: 16788335. [doi:10.1097/01.ajp.0000210696.46250.0d](https://doi.org/10.1097/01.ajp.0000210696.46250.0d).
34. Wand BM, Bird C, McAuley JH, Doré CJ, MacDowell M, De Souza LH. Early intervention for the management of acute low back pain: a single-blind randomized controlled trial of biopsychosocial education, manual therapy, and exercise. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2004;29(21):2350-6. PMID: 15507794. [doi:10.1097/01.brs.0000143619.34308.b4](https://doi.org/10.1097/01.brs.0000143619.34308.b4).

35. Zigenfus GC, Yin J, Giang GM, Fogarty WT. Effectiveness of early physical therapy in the treatment of acute low back musculoskeletal disorders. *J Occup Environ Med.* 2000;42(1):35-9. PMID: 10652686. [doi:10.1097/00043764-200001000-00010](https://doi.org/10.1097/00043764-200001000-00010).
36. da Casa C, Suárez ÁV, Asensio N, Blanco JF. Quality assessment of orthopedic surgery referral request letters from primary care consultation: evaluation of a Spanish healthcare area. *J Family Community Med.* 2021;28(3):189-95. PMID: 34703379. [doi:10.4103/jfcm.jfcm_133_21](https://doi.org/10.4103/jfcm.jfcm_133_21).
37. Downie F, McRitchie C, Monteith W, Turner H. Physiotherapist as an alternative to a GP for musculoskeletal conditions: a 2-year service evaluation of UK primary care data. *Br J Gen Pract.* 2019;69(682):e314-e320. PMID: 30962224. [doi:10.3399/bjgp19X702245](https://doi.org/10.3399/bjgp19X702245).
38. Bradford B, Collier TS, Freeman M, Goodwin R. Primary care reattendance following an FCPP appointment: a national retrospective service evaluation. *Musculoskeletal Care.* 2025;23(2):e70143. PMID: 40515757. [doi:10.1002/msc.70143](https://doi.org/10.1002/msc.70143).
39. Comunidad de Madrid. Los fisioterapeutas de los centros de salud de la Comunidad de Madrid atendieron a cerca de 159.000 pacientes en 2024 [nota de prensa]. Madrid; 5 de septiembre de 2025. Disponible en: <https://www.comunidad.madrid/noticias>.
40. Wood L, Hendrick P, Boszczyk B, Dunstan E. A review of the surgical conversion rate and independent management of spinal extended scope practitioners in a secondary care setting. *Ann R Coll Surg Engl.* 2016;98(3):187-91. PMID: 26741663. [doi:10.1308/rcsann.2016.0054](https://doi.org/10.1308/rcsann.2016.0054).
41. Candy E, Haworth-Booth S, Knight-Davis M. Review of the effectiveness of a consultant physiotherapy-led musculoskeletal interface team: a Welsh experience. *Musculoskeletal Care.* 2016;14(3):185-91. PMID: 27605463. [doi:10.1002/msc.1122](https://doi.org/10.1002/msc.1122).
42. Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. *Boletín Oficial del Estado, BOE-A-2006-16212.* Texto consolidado. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-16212>.
43. Ministerio de Sanidad. Cartera de servicios comunes de atención primaria: rehabilitación básica [página web]. Disponible en: <https://www.sanidad.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/2AtencionPrimaria/AP-RehabilitacionBasica.htm>.
44. Orden SND/454/2025, de 9 de mayo, por la que se modifican los anexos I, II, III y VI del Real Decreto 1030/2006. *Boletín Oficial del Estado, BOE-A-2025-9277.* Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-9277.
45. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. *Boletín Oficial del Estado, BOE-A-2003-10715.* Texto consolidado. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715>.
46. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. Madrid: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; 2019. Publicado por Resolución de 26 de abril de 2019 de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, BOE-A-2019-6761. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/calidadAsistencial/estrategias/atencionPrimaria/docs/Marco_Estrategico_APS_25Abril_2019.pdf.
47. Ministerio de Sanidad. Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2021. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/calidadAsistencial/estrategias/atencionPrimaria/docs/Plan_de_Accion_de_Atencion_Primaria.pdf.
48. Ministerio de Sanidad. Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2024. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/calidadAsistencial/estrategias/atencionPrimaria/docs/Plan_de_Accion_de_Atencion_Primaria_y_Comunitaria_2025-2027.pdf.
49. Ministerio de Sanidad. El Consejo Interterritorial aprueba el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 [nota de prensa]. Madrid; 16 de diciembre de 2024. Disponible en: <https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=6591>.
50. Situación actual de la fisioterapia en Atención Primaria de la Comunidad de Madrid [documento de trabajo sin autoría ni fecha, posterior a diciembre de 2024]. Madrid. Documento de trabajo no publicado.

51. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2012. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/calidadAsistencial/estrategias/abordajeCronicidad/docs/ESTRATEGIA_ABORDAJE_CRONICIDAD.pdf.
52. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2013. Disponible en: <https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/estrategiaSNS/docs/EstrategiaPromocionSaludyPrevencionSNS.pdf>.
53. Ministerio de Sanidad. Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2021. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/saludDigital/doc/Estrategia_de_Salud_Digital_del_SNS.pdf.
54. Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre, sobre justificación y optimización del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas. Boletín Oficial del Estado, BOE-A-2019-15604. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-15604>.
55. Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. Diario Oficial de la Unión Europea, L 13, de 17 de enero de 2014. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/59/oj>.
56. Long J. European region of the WCPT statement on physiotherapy in primary care. Prim Health Care Res Dev. 2019;20:e147. PMID: 31679552. doi:10.1017/S1463423619000811.
57. Ministerio de Sanidad. Informe monográfico. Recursos humanos, ordenación profesional y formación continuada en el Sistema Nacional de Salud. Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2024. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2025. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnual2024/Monografico_RRHH_2024.pdf.
58. Aiguadé Aiguadé R. La hora de la Atención Primaria [editorial]. Fisioterapia. 2022;44(4):199-200. doi:10.1016/j.ft.2022.03.002.
59. Departament de Salut. Programa d'incorporació de fisioterapeutes per a la promoció del funcionament i la prevenció de la discapacitat a l'atenció primària i comunitària. Barcelona: Generalitat de Catalunya; 2022. Disponible en: <https://salutweb.gencat.cat/ca/departament/ambits-estrategics/atencio-primaria-comunitaria/proiectes/programa-incorporacio-fisioterapeutes/>.
60. Departament de Salut. Pla funcional del Programa d'incorporació de fisioterapeutes a l'atenció primària i comunitària. Barcelona: Generalitat de Catalunya; 2023. Disponible en: <https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/9106>.
61. Ministerio de Sanidad. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP). Profesionales [consulta interactiva]. Disponible en: <https://pestadistico.inteligenciadegestion.sanidad.gob.es/publicoSNS/S/sistema-de-informacion-de-atencion-primaria-siap>.
62. Servicio Andaluz de Salud. Cartera de servicios de atención primaria. IV. Otros servicios. 2.3 Fisioterapia [página web]. Disponible en: <https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/cartera-de-servicios/atencion-primaria/iv-otros-servicios/2-otros-servicios-prestados-en-dispositivos-de-apoyo/23-fisioterapia>.
63. Servicio Andaluz de Salud. Sanidad implanta la derivación desde Atención Primaria a Fisioterapia en toda Andalucía [nota de prensa]. Sevilla; 26 de mayo de 2026. Disponible en: <https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/todas-noticia/sanidad-implanta-la-derivacion-desde-atencion-primaria-fisioterapia-en-toda-andalucia>.
64. Gobierno de Aragón. Cartera de Servicios de Atención Primaria del Sistema de Salud de Aragón. Zaragoza: Gobierno de Aragón; 2024. Disponible en: <https://atencioncomunitaria.aragon.es/wp-content/uploads/2024/07/CARTERAATENCIONPRIMARIA.pdf>.
65. Gerencia de Atención Primaria de Mallorca. Protocolo de actuación en las patologías de derivación directa en las Unidades de Fisioterapia de Atención Primaria de Mallorca. Palma: Servei de Salut de les Illes Balears; 2023. Disponible en: <https://docusalut.com/rest/api/core/bitstreams/6baa0511-9642-47e3-aa79-1202fd49c1ce/content>.

66. Servicio Canario de la Salud. Consulta de fisioterapia en Atención Primaria. Guía de actuación. Santa Cruz de Tenerife: Servicio Canario de la Salud; 2022. Disponible en: <https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listaImagenes.jsp?idCarpeta=46a3e0a2-75c8-11e2-bc0c-6512fc1bab5e&idDocument=046b7b81-75d6-11e2-bc0c-6512fc1bab5e>.
67. Gobierno de Canarias. Sanidad despliega servicio de fisioterapia en 24 zonas básicas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura [nota de prensa]. 19 de septiembre de 2022. Disponible en: <https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/sanidad-despliega-servicio-de-fisioterapia-en-24-zonas-basicas-de-gran-canaria-tenerife-lanzarote-y-fuerteventura/>.
68. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Guía de Unidades de Fisioterapia de Atención Primaria. Toledo: SESCOAM; 2022. Disponible en: <https://castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa>.
69. Junta de Castilla y León. Protocolos de fisioterapia en atención primaria. Valladolid: Consejería de Sanidad; 2017. Disponible en: <https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/programas-guias-clinicas/guias-practica-clinica/guias-clinicas.ficheros/1105660-Fisioterapia.PDF>.
70. Conselleria de Sanitat. Cartera de servicios de Atención Primaria Comunitaria. Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. València: Generalitat Valenciana; 2022. Disponible en: https://www.san.gva.es/documents/d/assistencia-sanitaria/2_cartera_servicios_atencion_primaria_comunitaria_resumida_es.pdf.
71. Área de Salud de Plasencia. Protocolo de derivación a las unidades de fisioterapia y rehabilitación. Plasencia: Servicio Extremeño de Salud; 2019. Disponible en: https://www.areasaludplasencia.es/docs/pgc/ses_plasencia_derivacion_fisioterapia_rehabilitacion.pdf.
72. Servizo Galego de Saúde. Carteira de servizos de fisioterapia de atención primaria e comunitaria. Santiago de Compostela: SERGAS. Disponible en: https://www.sergas.gal/Asistencia-sanitaria/Documents/1795/Carteira_Unidades_de_fisioterapia_de_atencion_primaria.pdf.
73. Servicio Madrileño de Salud, Gerencia Asistencial de Atención Primaria. Cartera de Servicios Estandarizados de Atención Primaria de Madrid. Actualización 2510. Madrid: Comunidad de Madrid; 2025. Disponible en: <https://www.comunidad.madrid/hospital/atencionprimaria/sites/atencionprimaria/files/2025-10/Cartera%20de%20Servicios%20Estandarizados%20AP.%20Actualizaci%C3%B3n%202510.pdf>.
74. Servicio Murciano de Salud. El SMS aprueba la cartera de servicios de fisioterapia en Atención Primaria [nota de prensa]. Murcia; 6 de abril de 2026. Disponible en: <https://www.murciasalud.es/en/-/el-sms-aprueba-la-cartera-de-servicios-de-fisioterapia-en-atenci%C3%B3n-primaria-para-mejorar-la-atenci%C3%B3n-de-los-pacientes>.
75. Servicio Navarro de Salud. Formación a fisioterapeutas de nueva incorporación en atención primaria, tercera edición [actividad formativa]. Disponible en: <https://www.formacionsalud.navarra.es/actividad/idactividad/7576>.
76. Gobierno Vasco, Irekia. La Fisioterapia de Atención Primaria de Osakidetza ha atendido ya a más de 8.600 pacientes en el primer semestre [nota de prensa]. 2024. Disponible en: <https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/95370>.
77. Redacción Médica. Los fisioterapeutas del Sergas podrán atender a pacientes bajo demanda. 6 de abril de 2022. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/autonomias/galicia/los-fisioterapeutas-del-sergas-podran-atender-a-pacientes-bajo-demanda-7761>. Fuente secundaria.
78. Comunidad de Madrid. Unidades de atención específica: fisioterapia [página web]. Disponible en: <https://www.comunidad.madrid/hospital/atencionprimaria/ciudadanos/unidades-atencion-especifica-fisioterapia>.
79. NHS. The NHS Long Term Plan. Londres: NHS; 2019. Disponible en: <https://www.longtermplan.nhs.uk/online-version/chapter-1-a-new-service-model-for-the-21st-century/>.
80. NHS England. Network Contract Directed Enhanced Service. Additional Roles Reimbursement Scheme guidance. Londres: NHS England; 2019. Disponible en: <https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2019/12/network-contract-des-additional-roles-reimbursement-scheme-guidance-december2019.pdf>.
81. Health Education England. First Contact Practitioners and Advanced Practitioners in Primary Care: (Musculoskeletal). A Roadmap to Practice. Londres: Health Education England; 2020. Disponible en:

- <https://www.hee.nhs.uk/our-work/allied-health-professions/enable-workforce/roadmaps-practice/first-contact-practitioners-roadmaps-practice>.
82. Chartered Society of Physiotherapy, British Medical Association, Royal College of General Practitioners. First Contact Physiotherapy posts in General Practice. A guide for implementation in England. Londres: CSP; 2018. Disponible en: https://www.csp.org.uk/system/files/001404_fcp_guidance_england_2018.pdf.
 83. Robert G, Stevens A. Should general practitioners refer patients directly to physical therapists? Br J Gen Pract. 1997;47(418):314-8. PMID: 9219412. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9219412/>.
 84. Hensher M. Improving general practitioner access to physiotherapy: a review of the economic evidence. Health Serv Manage Res. 1997;10(4):225-30. PMID: 10174512. [doi:10.1177/095148489701000403](https://doi.org/10.1177/095148489701000403).
 85. Goodwin RW, Hendrick PA. Physiotherapy as a first point of contact in general practice: a solution to a growing problem? Prim Health Care Res Dev. 2016;17(5):489-502. PMID: 27263326. [doi:10.1017/S1463423616000189](https://doi.org/10.1017/S1463423616000189).
 86. Stynes S, Jordan KP, Hill JC, Wynne-Jones G, Cottrell E, Foster NE, et al. Evaluation of the First Contact Physiotherapy (FCP) model of primary care: patient characteristics and outcomes. Physiotherapy. 2021;113:199-208. PMID: 34656297. [doi:10.1016/j.physio.2021.08.002](https://doi.org/10.1016/j.physio.2021.08.002).
 87. Wood L, Bishop A, Goodwin R, Stynes S. Patient satisfaction with the first contact physiotherapy service: results from the national evaluation survey. Musculoskeletal Care. 2022;20(2):363-370. PMID: 34709711. [doi:10.1002/msc.1599](https://doi.org/10.1002/msc.1599).
 88. Goodwin R, Moffatt F, Hendrick P, Stynes S, Bishop A, Logan P. Evaluation of the First Contact Physiotherapy (FCP) model of primary care: a qualitative insight. Physiotherapy. 2021;113:209-216. PMID: 34583834. [doi:10.1016/j.physio.2021.08.003](https://doi.org/10.1016/j.physio.2021.08.003).
 89. Walsh NE, Halls S, Thomas R, Berry A, Liddiard C, Cupples ME, et al. First contact physiotherapy: an evaluation of clinical effectiveness and costs. Br J Gen Pract. 2024;74(747):e717-e726. PMID: 38429110. [doi:10.3399/BJGP.2023.0560](https://doi.org/10.3399/BJGP.2023.0560).
 90. Walsh NE, Berry A, Halls S, Thomas R, Stott H, Liddiard C, et al. Clinical and cost-effectiveness of first contact physiotherapy for musculoskeletal disorders in primary care: the FRONTIER, mixed method realist evaluation. Health Soc Care Deliv Res. 2024;12(49):1-187. PMID: 39707910. [doi:10.3310/RTKY7521](https://doi.org/10.3310/RTKY7521).
 91. Leemrijse CJ, Swinkels IC, Veenhof C. Direct access to physical therapy in the Netherlands: results from the first year in community-based physical therapy. Phys Ther. 2008;88(8):936-46. PMID: 18566108. [doi:10.2522/ptj.20070308](https://doi.org/10.2522/ptj.20070308).
 92. Swinkels IC, Kooijman MK, Spreeuwenberg PM, Bossen D, Leemrijse CJ, van Dijk CE, et al. An overview of 5 years of patient self-referral for physical therapy in the Netherlands. Phys Ther. 2014;94(12):1785-95. PMID: 25082921. [doi:10.2522/ptj.20130309](https://doi.org/10.2522/ptj.20130309).
 93. Nivel. Jaarcijfers fysiotherapie 2024: aandeel patiënten met een verwijzing daalt. Utrecht: Nivel; 2025. Disponible en: <https://www.nivel.nl/nl/nieuws/jaarcijfers-fysiotherapie-2024-aandeel-patienten-met-een-verwijzing-daalt>.
 94. Helse- og omsorgsdepartementet. Prop. 71 L (2016-2017). Oslo: Gobierno de Noruega; 2017. Disponible en: <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-71-l-20162017/id2546178/?ch=9>.
 95. 1177 Vårdguiden, Region Stockholm. Rehabilitering i öppenvård [página web]. Disponible en: <https://www.1177.se/Stockholm/undersokning-behandling/smartbehandlings-och-rehabilitering/rehabilitering-i-stockholms-lan2/rehabilitering-i-oppenvard/>.
 96. Bornhöft L, Larsson ME, Nordeman L, Eggertsen R, Thorn J. Health effects of direct triaging to physiotherapists in primary care for patients with musculoskeletal disorders: a pragmatic randomized controlled trial. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2019;11:1759720X19827504. PMID: 30800175. [doi:10.1177/1759720X19827504](https://doi.org/10.1177/1759720X19827504).
 97. Bornhöft L, Thorn J, Svensson M, Nordeman L, Eggertsen R, Larsson MEH. More cost-effective management of patients with musculoskeletal disorders in primary care after direct triaging to physiotherapists for initial assessment compared to initial general practitioner assessment. BMC Musculoskelet Disord. 2019;20(1):186. PMID: 31043169. [doi:10.1186/s12891-019-2553-9](https://doi.org/10.1186/s12891-019-2553-9).
 98. Australian Physiotherapy Association. Position statement on scope of practice. Melbourne: APA; 2024. Disponible en: https://australian.physio/sites/default/files/APA%20Position-Statement%20on%20Scope%20of%20Practice%20May%202024_FA.pdf.

99. Canadian Physiotherapy Association. Position statement: primary health care. Ottawa: CPA; 2022. Disponible en: https://physiotherapy.ca/app/uploads/2022/08/primary-health-care_en.pdf.
100. Napier C, McCormack RG, Hunt MA, Brooks-Hill A. A physiotherapy triage service for orthopaedic surgery: an effective strategy for reducing wait times. *Physiother Can.* 2013;65(4):358-63. PMID: 24396164. [doi:10.3138/ptc.2012-53](https://doi.org/10.3138/ptc.2012-53).
101. Bath B, Grona SL, Janzen B. A spinal triage programme delivered by physiotherapists in collaboration with orthopaedic surgeons. *Physiother Can.* 2012;64(4):356-66. PMID: 23997390. [doi:10.3138/ptc.2011-29](https://doi.org/10.3138/ptc.2011-29).
102. Miller J, Barber D, Donnelly C, French S, Green M, Hill J, et al. Determining the impact of a new physiotherapist-led primary care model for back pain: protocol for a pilot cluster randomized controlled trial. *Trials.* 2017;18(1):526. PMID: 29121989. [doi:10.1186/s13063-017-2279-7](https://doi.org/10.1186/s13063-017-2279-7).
103. Oakley C, Shacklady C. The clinical effectiveness of the extended-scope physiotherapist role in musculoskeletal triage: a systematic review. *Musculoskeletal Care.* 2015;13(4):204-21. PMID: 25758358. [doi:10.1002/msc.1100](https://doi.org/10.1002/msc.1100).
104. Samsson KS, Grimmer K, Larsson MEH, Morris J, Bernhardsson S. Effects on health and process outcomes of physiotherapist-led orthopaedic triage for patients with musculoskeletal disorders: a systematic review of comparative studies. *BMC Musculoskelet Disord.* 2020;21(1):673. PMID: 33038935. [doi:10.1186/s12891-020-03673-2](https://doi.org/10.1186/s12891-020-03673-2).
105. Trøstrup J, Juhl CB, Mikkelsen LR. Effect of extended scope physiotherapists assessments in orthopaedic diagnostic setting: a systematic review. *Physiotherapy.* 2020;108:120-8. PMID: 32807362. [doi:10.1016/j.physio.2017.08.004](https://doi.org/10.1016/j.physio.2017.08.004).
106. Lafrance S, Vincent R, Demont A, Charron M, Desmeules F. Advanced practice physiotherapists can diagnose and triage patients with musculoskeletal disorders while providing effective care: a systematic review. *J Physiother.* 2023;69(4):220-31. PMID: 37714771. [doi:10.1016/j.jphys.2023.08.005](https://doi.org/10.1016/j.jphys.2023.08.005).
107. Piscitelli D, Furmanek MP, Meroni R, De Caro W, Pellicciari L. Direct access in physical therapy: a systematic review. *Clin Ter.* 2018;169(5):e249-e260. PMID: 30393813. [doi:10.7417/CT.2018.2087](https://doi.org/10.7417/CT.2018.2087).
108. Demont A, Bourmaud A, Kechichian A, Desmeules F. The impact of direct access physiotherapy compared to primary care physician led usual care for patients with musculoskeletal disorders: a systematic review of the literature. *Disabil Rehabil.* 2021;43(12):1637-1648. PMID: 31603709. [doi:10.1080/09638288.2019.1674388](https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1674388).
109. Babatunde OO, Bishop A, Cottrell E, Jordan JL, Corp N, Humphries K, et al. A systematic review and evidence synthesis of non-medical triage, self-referral and direct access services for patients with musculoskeletal pain. *PLoS One.* 2020;15(7):e0235364. PMID: 32628696. [doi:10.1371/journal.pone.0235364](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235364).
110. Gallotti M, Campagnola B, Cocchieri A, Mourad F, Heick JD, Maselli F. Effectiveness and consequences of direct access in physiotherapy: a systematic review. *J Clin Med.* 2023;12(18):5832. PMID: 37762773. [doi:10.3390/jcm12185832](https://doi.org/10.3390/jcm12185832).
111. Vedanayagam M, Buzak M, Reid D, Saywell N. Advanced practice physiotherapists are effective in the management of musculoskeletal disorders: a systematic review of systematic reviews. *Physiotherapy.* 2021;113:116-130. PMID: 34607076. [doi:10.1016/j.physio.2021.08.005](https://doi.org/10.1016/j.physio.2021.08.005).
112. Bishop A, Chen Y, Protheroe J, Ogollah RO, Bailey J, Lewis M, et al. Providing patients with direct access to musculoskeletal physiotherapy: the impact on general practice musculoskeletal workload and resource use. The STEMS-2 study. *Physiotherapy.* 2021;111:48-56. PMID: 32711896. [doi:10.1016/j.physio.2020.04.006](https://doi.org/10.1016/j.physio.2020.04.006).
113. Fischer M, Bui E, Besombes L, François M. Systematic review of direct access physiotherapy for musculoskeletal conditions in primary care: consequences for general practitioner workload, resource use, and organisation of care. *BMC Prim Care.* 2026;27(1):75. PMID: 41612203. [doi:10.1186/s12875-026-03186-9](https://doi.org/10.1186/s12875-026-03186-9).
114. Fischer M, Bui E, Besombes L, Pinsault N, François M. Effect of direct access to physiotherapy on prescribing and imaging in primary care for musculoskeletal disorders: a systematic review and meta-analysis. *Fam Pract.* 2026;43(4):cmag046. PMID: 42348720. [doi:10.1093/fampra/cmag046](https://doi.org/10.1093/fampra/cmag046).
115. Ojha H, Masaracchio M, Johnston M, Howard RJ, Egan WE, Kirker K, et al. Minimal physical therapy utilization compared with higher physical therapy utilization for patients with low back pain: a systematic review. *Physiother Theory Pract.* 2020;36(11):1179-200. PMID: 30739564. [doi:10.1080/09593985.2019.1571135](https://doi.org/10.1080/09593985.2019.1571135).

116. Snow BL, Shamus E, Hill C. Physical therapy as primary health care: public perceptions. *J Allied Health*. 2001;30(1):35-8. PMID: 11265271. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11265271/>.
117. Eurostat. Physicians and physiotherapists in the EU: how many? Eurostat News. Luxemburgo; 18 de agosto de 2023. Disponible en: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230818-1>.
118. Eurostat. Healthcare personnel statistics: dentists, pharmacists and physiotherapists. Statistics Explained [actualización periódica]. Luxemburgo: Eurostat. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_personnel_statistics_-_dentists_pharmacists_and_physiotherapists.
119. World Physiotherapy. Annual Membership Census 2024. Global report. Londres: World Physiotherapy; 2025. Disponible en: <https://world.physio/sites/default/files/2025-01/AMC2024-Global-report.pdf>.
120. Bury TJ, Stokes EK. A global view of direct access and patient self-referral to physical therapy: implications for the profession. *Phys Ther*. 2013;93(4):449-59. PMID: 23197847. doi:10.2522/ptj.20120060.
121. Sherrington C, Fairhall NJ, Wallbank GK, Tiedemann A, Michaleff ZA, Howard K, et al. Exercise for preventing falls in older people living in the community. *Cochrane Database Syst Rev*. 2019;1(1):CD012424. PMID: 30703272. doi:10.1002/14651858.CD012424.pub2.
122. Galan-Martin MA, Montero-Cuadrado F, Lluch-Girbes E, Coca-López MC, Mayo-Iscar A, Cuesta-Vargas A. Pain neuroscience education and physical therapeutic exercise for patients with chronic spinal pain in Spanish physiotherapy primary care: a pragmatic randomized controlled trial. *J Clin Med*. 2020;9(4):1201. PMID: 32331323. doi:10.3390/jcm9041201.
123. Fransen M, McConnell S, Harmer AR, Van der Esch M, Simic M, Bennell KL. Exercise for osteoarthritis of the knee. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;1(1):CD004376. PMID: 25569281. doi:10.1002/14651858.CD004376.pub3.
124. McCarthy B, Casey D, Devane D, Murphy K, Murphy E, Lacasse Y. Pulmonary rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;2015(2):CD003793. PMID: 25705944. doi:10.1002/14651858.CD003793.pub3.
125. Hayden JA, Ellis J, Ogilvie R, Malmivaara A, van Tulder MW. Exercise therapy for chronic low back pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2021;9(9):CD009790. PMID: 34580864. doi:10.1002/14651858.CD009790.pub2.
126. Louw A, Zimney K, Puenteadura EJ, Diener I. The efficacy of pain neuroscience education on musculoskeletal pain: a systematic review of the literature. *Physiother Theory Pract*. 2016;32(5):332-55. PMID: 27351541. doi:10.1080/09593985.2016.1194646.
127. Geneen LJ, Martin DJ, Adams N, Clarke C, Dunbar M, Jones D, et al. Effects of education to facilitate knowledge about chronic pain for adults: a systematic review with meta-analysis. *Syst Rev*. 2015;4:132. PMID: 26428467. doi:10.1186/s13643-015-0120-5.
128. Díaz-Cerrillo JL, Rondón-Ramos A, Pérez-González R, Clavero-Cano S. [Non-randomised trial of an educational intervention based on cognitive-behavioural principles for patients with chronic low back pain attended in Primary Care Physiotherapy]. *Aten Primaria*. 2016;48(7):440-8. Español. PMID: 26724987. doi:10.1016/j.aprim.2015.10.007.
129. Cuenca-Zaldívar JN, Fernández-Carnero J, Sánchez-Romero EA, Álvarez-Gonzalo V, Conde-Rodríguez R, Rodríguez-Sanz D, et al. Effects of a therapeutic exercise protocol for patients with chronic non-specific back pain in primary health care: a single-group retrospective cohort study. *J Clin Med*. 2023;12(20):6478. PMID: 37892618. doi:10.3390/jcm12206478.
130. Antúnez Sánchez LG, de la Casa Almeida M, Rebollo Roldán J, Ramírez Manzano A, Martín Valero R, Suárez Serrano C. [Effectiveness of an individualised physiotherapy program versus group therapy on neck pain and disability in patients with acute and subacute mechanical neck pain]. *Aten Primaria*. 2017;49(7):417-25. Español. PMID: 28089225. doi:10.1016/j.aprim.2016.09.010.
131. Serra-Prat M, Sist X, Domenich R, Jurado L, Saiz A, Rocas A, et al. Effectiveness of an intervention to prevent frailty in pre-frail community-dwelling older people consulting in primary care: a randomised controlled trial. *Age Ageing*. 2017;46(3):401-7. PMID: 28064172. doi:10.1093/ageing/afw242.
132. Romera-Liebana L, Orfila F, Segura JM, Real J, Fabra ML, Möller M, et al. Effects of a primary care-based multifactorial intervention on physical and cognitive function in frail, elderly individuals: a randomized controlled

- trial. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2018;73(12):1688-74 [paginación tal como figura en PubMed]. PMID: 29346524. [doi:10.1093/gerona/glx259](https://doi.org/10.1093/gerona/glx259).
133. Castell MV, Gutiérrez-Misis A, Sánchez-Martínez M, Prieto MA, Moreno B, Nuñez S, et al. Effectiveness of an intervention in multicomponent exercise in primary care to improve frailty parameters in patients over 70 years of age (MEFAP-project), a randomised clinical trial: rationale and study design. *BMC Geriatr*. 2019;19(1):25. PMID: 30691405. [doi:10.1186/s12877-018-1024-8](https://doi.org/10.1186/s12877-018-1024-8).
 134. Lin CW, Haas M, Maher CG, Machado LA, van Tulder MW. Cost-effectiveness of general practice care for low back pain: a systematic review. *Eur Spine J*. 2011;20(7):1012-23. PMID: 21203890. [doi:10.1007/s00586-010-1675-4](https://doi.org/10.1007/s00586-010-1675-4).
 135. Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. Resolución 1/2023 sobre el empleo de la ecografía en Fisioterapia. Madrid: CGCFE; 2023.
 136. Bachmann LM, Kolb E, Koller MT, Steurer J, ter Riet G. Accuracy of Ottawa ankle rules to exclude fractures of the ankle and mid-foot: systematic review. *BMJ*. 2003;326(7386):417. PMID: 12595378. [doi:10.1136/bmj.326.7386.417](https://doi.org/10.1136/bmj.326.7386.417).
 137. The Ionising Radiation (Medical Exposure) Regulations 2017. SI 2017/1322. Reino Unido. Disponible en: <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/1322>.
 138. Stiell IG, McKnight RD, Greenberg GH, McDowell I, Nair RC, Wells GA, et al. Implementation of the Ottawa ankle rules. *JAMA*. 1994;271(11):827-32. PMID: 8114236. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8114236/>.
 139. Downie A, Williams CM, Henschke N, Hancock MJ, Ostelo RW, de Vet HC, et al. Red flags to screen for malignancy and fracture in patients with low back pain: systematic review. *BMJ*. 2013;347:f7095. PMID: 24335669. [doi:10.1136/bmj.f7095](https://doi.org/10.1136/bmj.f7095).
 140. Foster NE, Anema JR, Cherkin D, Chou R, Cohen SP, Gross DP, et al. Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions. *Lancet*. 2018;391(10137):2368-83. PMID: 29573872. [doi:10.1016/S0140-6736\(18\)30489-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30489-6).
 141. Côté P, Wong JJ, Sutton D, Shearer HM, Mior S, Randhawa K, et al. Management of neck pain and associated disorders: a clinical practice guideline from the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMA) Collaboration. *Eur Spine J*. 2016;25(7):2000-22. PMID: 26984876. [doi:10.1007/s00586-016-4467-7](https://doi.org/10.1007/s00586-016-4467-7).
 142. Steuri R, Sattelmayer M, Elsig S, Kolly C, Tal A, Taeymans J, et al. Effectiveness of conservative interventions including exercise, manual therapy and medical management in adults with shoulder impingement: a systematic review and meta-analysis of RCTs. *Br J Sports Med*. 2017;51(18):1340-7. PMID: 28630217. [doi:10.1136/bjsports-2016-096515](https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096515).
 143. Karjalainen TV, Jain NB, Page CM, Lähdeoja TA, Johnston RV, Salamh P, et al. Subacromial decompression surgery for rotator cuff disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2019;1(1):CD005619. PMID: 30707445. [doi:10.1002/14651858.CD005619.pub3](https://doi.org/10.1002/14651858.CD005619.pub3).
 144. Bisset L, Beller E, Jull G, Brooks P, Darnell R, Vicenzino B. Mobilisation with movement and exercise, corticosteroid injection, or wait and see for tennis elbow: randomised trial. *BMJ*. 2006;333(7575):939. PMID: 17012266. [doi:10.1136/bmj.38961.584653.AE](https://doi.org/10.1136/bmj.38961.584653.AE).
 145. Hill JC, Whitehurst DG, Lewis M, Bryan S, Dunn KM, Foster NE, et al. Comparison of stratified primary care management for low back pain with current best practice (STarT Back): a randomised controlled trial. *Lancet*. 2011;378(9802):1560-71. PMID: 21963002. [doi:10.1016/S0140-6736\(11\)60937-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60937-9).
 146. Gusi N, del Pozo-Cruz B, Olivares PR, Hernández-Mocholi M, Hill JC. The Spanish version of the "STarT Back Screening Tool" (SBST) in different subgroups. *Aten Primaria*. 2011;43(7):356-61. PMID: 21296465. [doi:10.1016/j.aprim.2010.05.019](https://doi.org/10.1016/j.aprim.2010.05.019).
 147. Gallego-Izquierdo T, Ruiz-Vindel J, Ferragut-Garcías A, Martínez-Merinerio P, Montañez-Aguilera FJ, Noriega-Matanza C, et al. Adaptation and transcultural translation into Spanish of the Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation Questionnaire. *J Orthop Res*. 2020;38(12):2601-7. PMID: 32761913. [doi:10.1002/jor.24820](https://doi.org/10.1002/jor.24820).
 148. Vuurberg G, Hoorntje A, Wink LM, van der Doelen BFW, van den Bekerom MP, Dekker R, et al. Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: update of an evidence-based clinical guideline. *Br J Sports Med*. 2018;52(15):956. PMID: 29514819. [doi:10.1136/bjsports-2017-098106](https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-098106).

149. Blanpied PR, Gross AR, Elliott JM, Devaney LL, Clewley D, Walton DM, et al. Neck pain: revision 2017. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2017;47(7):A1-A83. PMID: 28666405. [doi:10.2519/iospt.2017.0302](https://doi.org/10.2519/iospt.2017.0302).
150. Haahr JP, Østergaard S, Dalsgaard J, Norup K, Frost P, Lausen S, et al. Exercises versus arthroscopic decompression in patients with subacromial impingement: a randomised, controlled study in 90 cases with a one year follow up. *Ann Rheum Dis.* 2005;64(5):760-4. PMID: 15834056. [doi:10.1136/ard.2004.021188](https://doi.org/10.1136/ard.2004.021188).
151. Ketola S, Lehtinen J, Rousi T, Nissinen M, Huhtala H, Konttinen YT, et al. No evidence of long-term benefits of arthroscopic acromioplasty in the treatment of shoulder impingement syndrome: five-year results of a randomised controlled trial. *Bone Joint Res.* 2013;2(7):132-9. PMID: 23836479. [doi:10.1302/2046-3758.27.2000163](https://doi.org/10.1302/2046-3758.27.2000163).
152. Ketola S, Lehtinen JT, Arnala I. Arthroscopic decompression not recommended in the treatment of rotator cuff tendinopathy: a final review of a randomised controlled trial at a minimum follow-up of ten years. *Bone Joint J.* 2017;99-B(6):799-805. PMID: 28566400. [doi:10.1302/0301-620X.99B6.BJJ-2016-0569.R1](https://doi.org/10.1302/0301-620X.99B6.BJJ-2016-0569.R1).
153. Kanto K, Bäck M, Ibounig T, Björkenheim R, Malmivaara A, Czuba T, et al. Arthroscopic subacromial decompression versus placebo surgery for subacromial pain syndrome: 10 year follow-up of the FIMPACT randomised, placebo surgery controlled trial. *BMJ.* 2025;391:e086201. PMID: 41330610. [doi:10.1136/bmj-2025-086201](https://doi.org/10.1136/bmj-2025-086201).
154. Kukkonen J, Joukainen A, Lehtinen J, Mattila KT, Tuominen EK, Kauko T, et al. Treatment of non-traumatic rotator cuff tears: a randomised controlled trial with one-year clinical results. *Bone Joint J.* 2014;96-B(1):75-81. PMID: 24395315. [doi:10.1302/0301-620X.96B1.32168](https://doi.org/10.1302/0301-620X.96B1.32168).
155. Morrissey D, Cotchett M, Said J'Bari A, Prior T, Griffiths IB, Rathleff MS, et al. Management of plantar heel pain: a best practice guide informed by a systematic review, expert clinical reasoning and patient values. *Br J Sports Med.* 2021;55(19):1106-18. PMID: 33785535. [doi:10.1136/bjsports-2019-101970](https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-101970).
156. Koc TA, Bise CG, Neville C, Carreira D, Martin RL, McDonough CM. Heel pain - plantar fasciitis: revision 2023. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2023;53(12):CPG1-CPG39. PMID: 38037331. [doi:10.2519/iospt.2023.0303](https://doi.org/10.2519/iospt.2023.0303).
157. Kang JR, Sin AT, Cheung EV. Treatment of massive irreparable rotator cuff tears: a cost-effectiveness analysis. *Orthopedics.* 2017;40(1):e65-e76. PMID: 27684078. [doi:10.3928/01477447-20160926-06](https://doi.org/10.3928/01477447-20160926-06).
158. Halls S, Thomas R, Stott H, Cupples ME, Kersten P, Cramp F, et al. Provision of first contact physiotherapy in primary care across the UK: a survey of the service. *Physiotherapy.* 2020;108:2-9. PMID: 32693238. [doi:10.1016/j.physio.2020.04.005](https://doi.org/10.1016/j.physio.2020.04.005).
159. Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Padrón Continuo [base de datos]. Madrid: INE. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990.
160. O'Caoimh R, Galluzzo L, Rodríguez-Laso Á, Van der Heyden J, Ranhoff AH, Lamprini-Koula M, et al. Prevalence of frailty at population level in European ADVANTAGE Joint Action Member States: a systematic review and meta-analysis. *Ann Ist Super Sanita.* 2018;54(3):226-238. PMID: 30284550. [doi:10.4415/ANN_18_03_10](https://doi.org/10.4415/ANN_18_03_10).
161. Chartered Society of Physiotherapy. CSP urges government to boost FCP roll-out across England [nota]. Londres; 19 de enero de 2022. Disponible en: <https://www.csp.org.uk/news/2022-01-19-csp-urges-government-boost-fcp-roll-out-across-england>.
162. Lin CW, Haas M, Maher CG, Machado LA, van Tulder MW. Cost-effectiveness of guideline-endorsed treatments for low back pain: a systematic review. *Eur Spine J.* 2011;20(7):1024-38. PMID: 21229367. [doi:10.1007/s00586-010-1676-3](https://doi.org/10.1007/s00586-010-1676-3).
163. Korthals-de Bos IB, Hoving JL, van Tulder MW, Rutten-van Mölken MP, Adèr HJ, de Vet HC, et al. Cost effectiveness of physiotherapy, manual therapy, and general practitioner care for neck pain: economic evaluation alongside a randomised controlled trial. *BMJ.* 2003;326(7395):911. PMID: 12714472. [doi:10.1136/bmj.326.7395.911](https://doi.org/10.1136/bmj.326.7395.911).
164. Driessen MT, Lin CW, van Tulder MW. Cost-effectiveness of conservative treatments for neck pain: a systematic review on economic evaluations. *Eur Spine J.* 2012;21(8):1441-50. PMID: 22447407. [doi:10.1007/s00586-012-2272-5](https://doi.org/10.1007/s00586-012-2272-5).
165. EFQM. Modelo EFQM 2025. Edición en español. Madrid: Club Excelencia en Gestión; 2025. Disponible en: <https://www.clubexcelencia.org/conocimiento/plataforma-de-conocimiento/modelo-efqm-2025>.

166. Hernández-Lázaro H, Mingo-Gómez MT, Jiménez-Del-Barrio S, Simarro-Martín A, Wiśniowska-Szurlej A, Ceballos-Laita L. Development of an ICF core set for the management of musculoskeletal conditions in primary care physiotherapy services in Spain: a Delphi study. *Disabil Rehabil.* 2025;47(18):4759-4768. PMID: 39931756. [doi:10.1080/09638288.2025.2460723](https://doi.org/10.1080/09638288.2025.2460723).
167. Hernández-Lázaro H, Jiménez-Del Barrio S, Ceballos-Laita L, Lahuerta-Martin S, Medrano-de-la-Fuente R, Hernando-Garijo I, et al. Multicentre cross-sectional study assessing content validity of the International Classification of Functioning, Disability and Health core set for post-acute musculoskeletal conditions in primary care physiotherapy services. *J Rehabil Med.* 2023;55:jrm11950. PMID: 37974517. [doi:10.2340/jrm.v55.11950](https://doi.org/10.2340/jrm.v55.11950).